# 前　言

中国医学是中华民族几千年来同疾病作斗争的经验总结，是一个伟大的宝库。它在医学理论和药物运用上均有其完整而独特的理论体系。它的发展基础，源于观察自然、利用自然，并依照自然法则，来求取治病保健之目的。对人体生理功能，法天取象，概括以阴阳五行，又以平衡阴阳五行来纠正病理现象。它如：四诊、八纲、八法等统隶属之。它在诊疗方法上有方脉、针灸、正骨、外科、按摩、推拿、气功、导引等。历史实践证明有效，蔚为独特的中国医学。

方脉学中医学中一组成部分，是运用四诊八纲来辨证施治，选方组药，以药物为武器，达到祛病保健之目的。

几千年来在这方面的书籍除内、难二经外，浩如烟海，汗牛充栋。有探究疾病性质及其变化规律的如：《伤寒论》，温病学有《温热经纬》、《瘟疫论》等；以验方传世的有《千金方》、《寿世保元》等；以脉究病有《脉诀》、《频湖脉诀》等；专门记述药物性能以适应疾病的有《本草》、《本草纲目》、《本草備要》等；有为便于检方应病汇集历代名方验方如：《方剂学》、《处方学》、《汤头歌诀》等。均有所长，各有所偏。但后学者在临床上综合应用实是一大难事。因之有宗汉方者；有宗时方者；有因病检方者；有以方试病者；流派纷繁，不一而足。但各宗一家之言，势难适应各种纷繁复杂的疾病。中医学术，自古輪廓相传，师第相授，沿袭至今，惟对内在质的更新改进甚少。致使方脉学术踏步不前，这即它的历史根源。

余从事方脉诊疗工作四十余年，痛感方脉学术亟需总结出系统完整的有关疾病性质、类型、病理传变、转化规律及生理反映，和证、脉、药、方、相连，整套有法则的诊疗方法来。为从事医疗工作者提示出显见明析的规矩可循，分别应用。使中医学术，发扬光大，继续更好的为人类服务。不自揣度，爰写《方脉精微》一书，一得之愚，公诸社会，对增进中医学术，提高医疗水平，或将有所裨益。

# 目　　录

前言……（1）
中医基础理论辩析……（1）
一、阴阳……（1）
二、五行……（4）
三、经络……（5）
四、气　卫气论……（6）
五、血　营气……（8）
六、水液 ……（10）
七、功能与器质 ……（11）
疾病类型 ……（12）
一、伤寒 ……（12）
二、伤风 ……（13）
荆防病 ……（14）
附：经验方 ……（16）
三、温病 ……（17）
四、湿病 ……（18）
五、杂病 ……（21）
1、中风……（21）
2、心脏病……（22）
3、头痛……（23）
4、牙痛……（23）
5、口舌糜烂……（24）

6、咽喉肿痛……（24）
7、哮喘……（25）
8、足后跟痛……（25）
9、腰胯痛……（25）
10、上肢及肩胛痛 ……（26）
11、背脊痛 ……（26）
12、鹅掌风 ……（26）
13、失眠症 ……（26）
六、传染病 ……（27）
**诊断** ……（28）
一、药、脉、证、方、相印法 ……（28）
**外感篇** ……（28）
桂枝脉证 ……（29）
荆芥脉证 ……（31）
防风脉证 ……（32）
羌活脉证 ……（34）
独活脉证 ……（35）
紫苏脉证 ……（36）
藿香脉证 ……（37）
细辛脉证 ……（38）
柴胡脉证 ……（39）
外感病类型 ……（40）
一、伤寒型 ……（40）
1、寒伤血分桂枝汤型……（41）
2、寒伤气分细辛汤型……（41）
二、伤风型 ……（41）

（A）风寒型 …… (41)
（B）风热型 …… (42)
三、外感病两型合病型 …… (43)
**内伤篇** …… (44)
川芎脉证 …… (44)
芍药脉证 …… (45)
当归脉证 …… (47)
地黄脉证 …… (49)
续断脉证 …… (51)
山萸肉脉证 …… (52)
狗脊脉证 …… (53)
吴茱萸脉证 …… (54)
肉桂脉证 …… (55)
丁香脉证 …… (56)
党参脉证 …… (56)
白术脉证 …… (57)
黄芪脉证 …… (59)
草果脉证 …… (60)
干姜脉证 …… (61)
砂仁脉证 …… (62)
大腹皮脉证 …… (63)
厚朴脉证 …… (64)
苏子脉证 …… (65)
葛根脉证 …… (66)
石膏脉证 …… (67)
乌药脉证 …… (68)

小茴香脉证 …… (69)
元参脉证 …… (70)
熟枣仁脉证 …… (71)
总述 …… (71)
内伤病治法与特有脉象 …… (72)
二、疑似脉辨 …… (74)
左寸浮部不是小肠脉　右寸浮部不是大肠脉 … (77)
三、舌诊 …… (78)
**正本清源** …… (80)
一、疾病规律 …… (80)
二、肝胆病与治法 …… (84)
三、癌 …… (86)
**妇科辑要** …… (90)
月经超前 …… (91)
月经衍期 …… (92)
月经前后不定期 …… (92)
倒经 …… (92)
婚久不孕 …… (92)
附：男性不育病 …… (93)
带下 …… (93)
流产 …… (93)
恶阻 …… (94)
产后 …… (94)
乳疾 …… (94)
**方剂评述** …… (95)
**医案摘录** …… (97)

泻痢　五例 …… (97)
浮肿　四例…… (100)
腰肢病　七例…… (102)
中风　四例…… (107)
胃病　二例…… (110)
肝胆病　三例…… (112)
核肿　三例…… (115)
尿道病　二例…… (120)
血病　六例…… (121)
疮疡　四例…… (125)
气虚　四例…… (127)
胀满　二例…… (130)
肾脏病　一例…… (131)
癌　一例…… (132)
心脏病　一例…… (134)
医案录后语…… (138)
治略…… (139)
编后语…… (141)

# 中医基础理论辩析

中国医学原自实践经验，它的基础便是科学的、坚实的，古人由此而总结出来的整套理论，既适合於人体生理病理普遍规律，又指导着医疗技术实践。几千年来，历代医家又从中不断创造发展。截至现在它的实用价值事实胜於雄辩，那就不应当有所怀疑，而应该运用现代知识求取其所以能为人们产生医疗保健作用的真正道理与方法来，进一步更好的为人类所受用。客观存在的事物，只有认识再认识。不同时代的解释和说法容或有异，但理无二致。阐明本质探索规律，提高中医疗效，这是我们努力的方向。而古籍中也有与事实不尽符合地方。根据实践进行纠正，使之更形完善，大有必要。几十年来医疗实践观察认识所及：中国医学无论在理论上、方法上、脉理上、药物处方等方面，都有其不可磨灭的精萃所在。这一伟大历史结晶，是经得起实践考验的医学真理。爰将其基础理论辨析如下：以飨同好。

## 一、阴　　阳

阴阳理论始创於《易经》。这是我国古代一种朴素的唯物论和自发的辩证法思想。应用於医学领域，源自《内经》。古人以其长时间观察到的事实为基础，经分析演绎说明，总结出这一大自然界中互相矛盾而又互相依存的阴阳理论。因它普遍存在於自然界，因此，人们用这种“两元论”来解释各种客观事物的运动，进一步运用於医学方面，奠定了中医理

论基础。它把宇宙（大世界）和人体（小世界）视作两个相似的系统，并按同一法则运行，天人相应，天人合一。任何一个存在的事物，无论是有生命的，还是无生命的，以及每一状态，都可以分别归属於阴阳对立的一方，不是属阴，就是属阳。那些具有强、热、明亮、坚硬、高大、轻等特征者属阳；而与这些特征相反的属阴；在人体中如：心、肝、脾、肺、肾属阴；小肠、胆、胃、大肠、膀胱属阳。人体任何状态，不论生理的、病理的、精神的、物质的凡是超出正常范围的属阳，亏损不足的则属阴。因此：发烧属阳，寒战属阴。自然界和人体内或外的任何一个地方，阴和阳都始终存在着。

兹表列如下：

| 宇宙（大世界） | |
|---|---|
| 阴 | 阳 |
| 地 | 天 |
| 月 | 日 |
| 秋冬 | 春夏 |
| 雨 | 风 |
| 水 | 火 |
| 女 | 男 |
| 静 | 动 |
| 内 | 外 |
| 黑夜 | 白天 |
| 衰退 | 生长 |

| 人身（小世界） | |
|---|---|
| 阴 | 阳 |
| 血 | 气 |
| 脏 | 腑 |
| 胸 | 背 |
| 里 | 表 |
| 下 | 上 |
| 寒 | 热 |
| 营 | 卫 |
| 精 | 神 |
| 退缩 | 亢进 |

**六经分属**

| 阴 | | | 阳 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 足三阴 | 足少阴 | 肾 | 足三阳 | 足太阳 | 膀胱 |
| | 足厥阴 | 肝 | | 足少阳 | 胆 |
| | 足太阴 | 脾 | | 足阳明 | 胃 |
| 手三阴 | 手少阴 | 心 | 手三阳 | 手太阳 | 小肠 |
| | 手厥阴 | 心包络 | | 手少阳 | 三焦 |
| | 手太阴 | 肺 | | 手阳明 | 大肠 |

分性是对客观事物的具体看待。而阴阳二性，不是静止的，也不受时间与地域限制。人为的、自然的、经常在变动，又经常在自我调整，求取平衡，以维系机体存在。当人体表阳受滞时，里气即张。心阳不足时，肾水上逆凌心；反之，心阳过亢，则肾阴亏损；脾气过强，则肝气不舒；内寒过盛，则格阳於外；内热过甚，则四肢厥冷，如此等等。阴阳胜负，构成各种病理状态。只有在阴平阳秘，阴阳二性处於中性状态时，才是人体健康的表现。

如把人体气血营卫再作较详细分析，则气分之阳热属阳，气分之液属阴。血分之血属阳，血分之液属阴。血分功能（营）属阳，血分之血液属阴。气分之功能属阳，气分之气液属阴。也就是功能属阳，物质属阴。如再将营卫气血互相对立，则营属阴，卫属阳。气属阳，血属阴。设卫阳受阻，则营热弛张症见：高烧无汗。血分之阳受阻，气分之液充斥而肿满。由此可以认识到，阴阳二性互相是平衡的，任何一方的过亢、是对立面过弱的表现，阴生阳中为真阴，阳生阴中

为真阳。二者又是互根的，一方发展的极至，则向相反方面转化。如阳极转阴，阴极转阳。在病理上的转变往往浮现出诸多假象（表面），因而，临床上须透过现象看本质，平调阴阳以纠正病理，这便是中医理论基础之一。

## 二、五　行

五行理论，最早见於《尚书·洪范》。它用金、木、水、火、土五种物质来表明宇宙间各种现象的转化规律。它的主要意义，不是把这些因素作为独立的个体，而是它们在这个系统中如何变化和彼此相互作用。"行"的含意是运动、行为、活动、及相互作用。用这一静的物质标明动的作用理论，有其多面性和普遍性。

五行动态，只能从五种物质的功能来理解：水生木，木生火，火生土，土生金，金生水，水生木，循环往复，如环无端。而水克火，火克金，金克木，木克土，土克水，又是反面的制约关系。此应用於医学则始於《内经》。在祖国医药学里，主要是用五行来概括和说明脏腑组织的属性及其内在联系归纳人体与自然界某些内在联系，从而指导病理分析，以及诊断和治疗的临床实践。如：肾属水，肝属木，心属火，肺属金，脾属土，同样道理相生相克，作用机体运转。其间任何一个过程，又都不是孤立的，不是干扰了其它过程，就是被其它过程所制约。只有处於均衡运行条件下，才显示出宇宙力量，体现出支配人体这个世界的机能活动下生存的基本规律。

宇宙万物在大的五行系统中运行。人体内部器官的五行

系统在正常时属生理状态，当生克不平衡时，便出现病理状态。如：肝强侮土时，当平肝以实脾；肺虚壮脾，是培土以生金；肝亢伤肾，便滋阴以潜阳；木火中烧，则泻火以安木。这种平调阴阳，虚则补其母，实则泻其子的原则，千百年来为中医诊断治疗提供着有益指导，无数实践证明是符合实际的、正确的、有效的。又如：肝胆属木，木旺於春，属东方，其味酸，其色青，其声呼，其动为风，在志为怒，肝开窍目，荣於爪甲，主筋，藏魂等等。在诊疗中如发现目疾，睡眠不安，风痛，怒，狂，酸，面青等症状时，必须着眼於肝胆。脉诊中如发现肝虚时，根据母子定律，补肾以强肝（水生木）反之泻火以平肝等。

另外：肝属木，旺於春，心旺於夏，肺旺於秋，肾旺於冬，脾旺於四季，脾色黄主中央，以生万物，各脏在其旺季一般不易受邪，即或受邪因其旺而抵抗力强，疾病也容易解除。设肝胆有病适逢秋季，金气克木，肝胆病较难向愈等等。这又为疾病预后方面提供着有益指导。

再如：春勿补肝，防其实实，勿伐肝，免伤生生之气，夏勿补心，秋勿补肺，冬勿补肾，勿补勿伐，顺其时，应其运，适其性等。这又为医者在治疗方针上提供着有益指导。所有这些完整的与大自然协调一致的五行五脏功能运行理论，构成了中医理论的又一特色。

## 三、经　络

经络学说是研究人体经络系统的生理功能、病理变化及其与脏腑相互关系的学说。经络的功能，是行气血，营阴阳，

濡筋骨，利关节。它们运行於脏腑和身体表里之间。全身共分为手经三阴三阳，足经三阴三阳，合身前任脉，背部督脉共为十四经脉。其他尚有任、带等脉。在经与经之间互相连系之脉为络，而经络内通各自脏腑，外行肌表躯壳之间共营其气血运行功能。

经络在生理上作用诚如上述，在病理上也相互影响，如此经有病可以传给他经。《伤寒论》中太阳传阳阴、少阳等。经病也可以传给各自脏腑，如太阳邪热传腑而为膀胱蓄血证；少阳邪热传肝而为下血谵妄证等。反之经病可以自解，也可以由人力辅助而解。而脏腑病欲解时多沿各自经络向外解除。也有脏病传腑而解者。因此，病由经络传脏腑是为逆传，病势趋于严重，由脏传腑或随经外出而解者是为顺传，病势趋于向愈方面。

经络之於病理有其规律性，因此，在诊断时随着病痛发生处所可以知其为某经疾病，进一步再联系其与各自脏腑关系。这一诊断方法，也多为中外医生所采用。如再加上脉诊等更可以确诊疾病之所由生，给诊疗提供出更为确切的方法来。

## 四、气

中医学中“气”的概念有好多种：此处可分二种，一、大自然外气。二、人体内之气。

一、大自然外气，是指四时八节气候而言，并以其动静冷热分为六种，即风、寒、暑、湿、燥、火。六气它对人体健康影响，在《内经》中已有非常详细描述。人在大自然中

生长，其皮肤、口鼻等与外界空气相接触，气候经常在变化，人体机能如有不相适应，每多疾病产生，此多为外感病。

二、内气又可分为功能与卫气二种。

1、功能是人体内的生命能。即所谓：心气，脾气，肝气，肺气、肾气，神气，精气，血气，营气，胃气，元气等等。所有这些气的意义正是表明每一脏腑的功能而言。如补中益气汤所益之气乃为全身气血功能，尤其是中气（脾胃之气）。肾气丸专强肾之功能等。

2、卫气是指人体内外体温而言。所谓：卫外之阳，但必须与卫内之阳同时并存。《伤寒论·少阴篇》中四逆汤、真武汤、麻黄附子细辛汤、及一般常用回阳救急的汤剂等，都是对增进和调整体温（卫气）的最好方剂。另作卫气论一篇供参考。

## 卫 气 论

《素问·痹论》："卫者，水谷之悍气也，其气慓疾滑利。不能入於脉也，故循皮肤之中，分肉之间，熏於肓膜，散於胸腹。"《灵枢·本藏篇》："卫气者，所以温分肉，充皮肤，肥腠理、司开阖者也"。

其与营气，一阳一阴，统帅全身，营养百脉。

至其本身，与水精相合，卫气上行，水液下行，其气四布，精气方生，聪耳明目，肾气乃充，元阳固守，福寿康宁。

至其变也，寒则脉微身冷，肢厥有凶，上为吐逆，下泄清冷，阴阳离诀，寿命立倾。四逆回阳，急切有功。

热则消谷善饥，口渴引饮，大便燥结，谵语频频，芒硝大黄，急下存阴。热壅於上，大汗淋淋，脉洪身热，白虎为

真。

其门玄府，开合适中，汗随气出，排浊存清。如遇风冷，便逆其性，风水石水，内外皆生。甚则气喘溺血，小便不通，鬼门净府，二者须斟。

阳不入阴，睡眠不成，喷嚏哈欠，卫气之形。

卫气营血，两相融融。营分受寒，卫气必争，翕翕发热，淅淅恶风，阴阳相击，项强头痛，鼻鸣干呕，桂枝是凭。

卫阳不固，自汗津津，防风黄芪，玉屏可信。阴虚不足，盗汗始生，归地黄连，确有殊功。

温病高热，卫气不行，同为肢冷，过在营分。滋阴通阳，妙手回春。

卫气营血，医所凭诊。阴平阳秘，百岁真人。

气的含意，另外，还有人体肺、脾、胃、肠、膀胱的功能，和卫气、体液的运行等共称为气分。相对而言，心、肝、肾活动情况和血液运行状况称为血分。诊脉时病人右三脉主气分。左三脉主血分。左右相较，即可得出气血之盈亏。

## 五、血

血的功能称："营"。血中之热称："血中之阳"，又称"营气"。血中液体称"血中之阴"，如：(阴虚阳亢，阴虚劳热)。五脏中心主血，肝藏血，脾统血。血中之液由肾来供应。(精生血) 在生理的情况下，血中之阴阳，处於平衡状态，心肝脾肺肾等对血之功能，必须正常，其中如有任何一方出现偏悖便是病态。但最能引起血病的重要原因有以下几个方面：一、六淫之邪入血分。二、卫气及体液之病影响血分。三、七

情；如思虑伤脾，惊恐伤肾等。以上三项中惟独卫气与体液有病时常引致血分不安而出现血病者最为多见；如衄、目疾、耳咽肿痛、蛤蟆瘟、瘰疬、疮疥、痛肿、月经不调、赤白带下、痢疾、便血等。

一般情况下，除传染病和血虚病人外，血分不易受邪。在温病学中，叶天士在其《外感温热篇》中提出："大凡看法，卫之后方言气，营之后方言血，在卫汗之可也，到气才可清气，入营犹可透热转气，……入血，就恐耗血动血，直须凉血散血，……"这一认识不仅适用於温病，其它疾病同样也适用。每当面对血病时，常常从脉诊中发现当时血病多由气分病而引发。治气理液，血病多自安。设不辨究脉理，见血治血，扬汤止沸，治标不及本，非其治也。

## 营　气

《灵枢·营卫生会篇》："人受气于谷，谷入于胃，以传于肺，五脏六腑皆以受气，其清者为营，浊者为卫，营行脉中，卫行脉外。"《素问·痹论》："营者，水谷之精气也，和调于五脏，洒陈于六腑，乃能入于脉也，故能循脉上下，贯五脏六腑也"。

血是实体（质），营是功能（气）。

清医，叶天士说："营之后方言血"。是说病邪先伤及血份，"入营犹可透热，仍能气而解"。该从血的气分透热邪使外解。至入于血，则恐耗血动血，直须凉血散血。病邪入血分，该当治血。他把营与血分成两层来对待，对邪在血分的温病治疗创造出新疗法，是近代中医学上一大进步。

营气盛，则面现华色，肌肉滑，体质壮，衰则面容憔悴，

肌肤枯燥晦暗。女子经迟色黑，面现蝴蝶斑等。

另如：面部胀红，是感冒之象；颧骨绯红，是阴虚痨热之象；病有内寒者，面赤及营气外浮（阴盛格阳）之象等等，应须分别。

## 六、水　液

肾为癸水，居北方，肾主五液，肾主二便，总司全身水液。水凡人体津、液、汗、涎、唾、涕、泪、尿等都与肾有密切关系。液与卫阳又都根於肾中。阳生阴中为真阳。阴生阳中为真阴。如：卫阳外散，阴液下泄，是为阴阳离诀，生命熄灭。如：水不生木，木不生火，则贫血容枯，生机衰退。

血中之热为阳，血中之液为阴。气中之阳为卫，气中之阴为水液。气血之中，阴阳二相，一有不平，病变随生。

汗多大便必燥结，口渴引饮，大汗多有亡阳之虑，汗多有寒中之忧。

卫阳不足，则水液不行，痰涎壅盛，涕泪交流，泻利纵横，肿胀以生。

血中阳亢，阴液必伤，血中阳虚，血行则迟缓。郁郁寡欢，甚则肢体肿满，腹水等症。

水液之运行全赖气血二气之阳以为本。阳盛又伤阴，舌干，口燥，阴虚劳热等疾又生。

水液与气血二气相辅相成，互相依存，而气与血也要处於平衡状态中。

人体疾病中，在临床上水分之病最多，如：外感病之腠理闭塞、咳嗽痰涎、胃肠蓄水、便泻、呕吐、四肢关节痛、肿

胀、小便不利、带下、葡萄胎、子肿、不孕等都与水液息息相关。治不调理水液，非其治也。

## 七、功能与器质

人体疾病，绝大多数出於功能障碍，器质性病相对而言占少数。二者成因，先功能疾病而后转化为器质疾病。当在功能障碍时，调理最易全愈。久延不解，病毒瘀结，代谢产物蓄积，器质病变由是滋生。

中医学中阴阳五行、营卫气血等理论及其治疗方法等。大半侧重於调理生理功能，纠正病理状况。在诊断中依据四诊八纲，尤其注重脉象，诊察脏腑功能，阴阳偏盛，外邪类属，邪之深浅等等。调脏腑，理阴阳，疏经络，扶正以祛邪。调气理血，化腐，解毒散结，生肌、长肉等法，促进器质病变恢复正常，这一调理和促进机体功能来改变器质病变方法，对妇科月经不调，赤白带下，瘰瘕积聚，肠胃溃疡，疮疡肿毒，口舌糜烂，关节肿痛等诸多急慢性常见疾病，具有特殊疗效，为古今医者所奉行，不在见病治病，重在视病情，依脉象，调理脏腑经络，促进机体自然疗能来改变器质病态。

古代人观察人体生理病理自然规律，利用自然疗能，纠正或促进自然功能，以器质为本，以功能为用。在实践经验中总结出系统的整体观医学理论，突出的表现了人体功能的特殊重要性，为历代医家所掌握运用，这伊是中医真谛之所在。

# 疾病类型

## 一、伤　寒

寒伤营：

《伤寒论》：太阳病头痛，汗出，恶风，桂枝汤主之。

桂枝证不解，则传入少阳而口苦，耳聋或鸣、胁痛、寒热往来等，小柴胡汤主之。再传入里，呕不止，心下急，郁郁微烦，大柴胡汤主之。

桂枝证未解，妇人适经血来，或停经，热邪入血分，高热，谵语等，仍以小柴胡汤主之。

桂枝证未解，热邪下入膀胱蓄血，其人如狂，抵当汤主之。

桂枝证初起，热邪连及腹内而腹痛者。桂枝加芍药汤主之。

桂枝证初起，头痛、无汗而喘者。麻黄汤主之。

桂枝薰少阴经病；咳喘者，小青龙汤主之。如胃热高者，大青龙汤主之。

桂枝证传入阳明经，则高热，汗多，脉大，口渴引饮等。白虎汤主之。传胃腑，腹胀，大便难，口燥，舌干，谵语等。大承气汤主之或先用小承气汤。

阳明病，但头汗出，身无汗，齐颈而还，小便不利，渴引水浆者，热瘀热在里，身必发黄。茵陈蒿汤主之。

其他如：桂枝证未解，与水结者。五苓散主之。

邪热结于胸腹间，诸泻心汤主之。

胸胁腹间有停水者。十枣汤下之。

邪热滞于上焦者，栀子豉汤主之。

气滞于胸。用厚朴杏子汤。

痰水结于胸腹者，用大小陷胸汤。

气不足者，用小建中汤。

阳不足者，桂枝加炙附子汤。

过汗亡阳。筋惕肉瞤谵语者。真武汤、桂枝蜀漆龙牡汤主之。

口鼻吸受风寒为少阴经病，头痛，清涕，咳嗽，恶寒，发热。麻黄附子细辛汤主之。

腹痛或泄泻，四肢冷，用附子理中汤。

四肢冷，脉细，欲睡。四逆汤主之。

腹痛，呕吐涎沫。吴茱萸汤主之。

热邪下痢重者。白头翁汤主之。

附子理中汤证、四逆汤证、吴茱萸汤证。为太阴、少阴、厥阴、三阴病。习惯上称内伤寒。麻桂证称外伤寒。

如果遇到内外伤寒俱病时，则“先温其里，再攻其表”。温里宜理中、四逆、吴茱萸汤，救表宜桂枝汤。

详情请参看《伤寒论》

## 二、伤　风

风伤卫：风邪伤及卫表使人汗腺闭阻，代谢不畅，毒物产生。卫分受病，营分必起反应，发热头身痛，治不及时，便

引发少阳病，或阳明病。若血虚血热之人，则血分诸病出现。内虚人则肠胃病出现。致其传变规律与伤寒病相仿。而变生各病，要比伤寒复杂，发病率也很高。

## 荆防病

祖国医学随着时代在进步、而不断完善发展。始从《伤寒论》到清《温病学》，从萌芽到一学派的形成，为当今中医界所推崇。但自宋元以来，尚有另一医学学派在萌动，而为人们所忽略。这就是“荆防病”。从下列方剂的分析中，就可清晰地分辨出其轨迹。

《妇人大全良方》的“人参荆芥散”，主治妇人血风劳。即风邪与血相搏。腹中巨痛、月经或断或来、四肢酸痛、面色萎黄、羸瘦等。

刘河间的“防风通圣散”，主治：风热气血壅盛，表里三焦俱实，疮疡肿毒、丹斑瘾疹等。

《证治准绳》中“荆防败毒散”，主治：恶寒发热，头身痛疼所致，下痢，痈疡等。

缪仲淳的“防风解毒汤”，主治：风热发斑、耳项红肿等。

时逸人之“荆防达表汤”，主治：外感头身痛等。

其它尚有一般通用“荆防五积散”等。

所有以上各方散见於宋后各个时代，俱属有效验方。方中都以荆防二药领先，所治病症，一是外感风寒头身痛；二是风血相搏的疹、疮、肿、毒、痢、月经不调；三是风邪入气分的肿硬痰核等。根据多年临床经验，在众多复杂的疾病中，伤寒与温病虽多见，但相当多数病症是为“荆防病”纠缠所致；如：眼目红肿、耳痛、牙痛、咽喉肿痛、鼻塞、流

血、涕黄、咳嗽痰黄、痢下赤白、或带绿色、焦黄风沫，甚或肠风带血、妇人带下赤白黄、月经痛、赶前错后、崩、漏，胃酸痛胀、风湿疹癣、关节痛，小儿食不长肌肉，老人疲乏困倦等。脉诊时均有荆防二脉出现，治疗时随证加入荆防二药，率多迎刃而解。究其原因，荆防二药，一入血分，一入气分。防风一药入脾经，除风湿，能发汗，治关节痛，尤其是四肢。与黄芪配合能止汗。看来它不但与脾胃经络有关，还与汗腺紧密相连。而荆芥一药，清头目，利咽喉，主治头风痛，无汗，疮，疥，血晕，寒热，瘰疬，结聚，血痢，吐衄，小儿发热抽搐，腮腺肿毒等。

在症候上，荆防二病常易合并发生。若汗出当风，或劳热之后，突遭风寒侵袭，汗腺突闭，郁热排泄不畅，毒物郁积，血热随起，聚於上则头目耳鼻腮项肿痛疮衄起；发於表则风湿疹痒癣起；陷入胃肠则胃腹痛泻赤黄绿风沫等；与妇女经血相搏则痛经，月事不调；与脾湿相合下行又成五色带下等。青年儿童血气旺盛，得之多发病於上。妇女血虚，遇之多生经带病。脾胃气虚者多生泻利或便不畅病。这已形成一定的规律。

防风病不但与荆芥病结合，如遇血分受寒时，又与桂枝病合并发生，形成关节病。不独荆芥而已，当荆防病邪热传入半表半里时，也常有柴胡证出现。刘草窗的“痛泻要方”，所治恶寒、发热利下不爽、色焦黄或绿、或白沫、腹痛、不喜饮食等症，有人认为是消化不良症，非也。实乃荆防病邪热入里所致，用白术、炒杭芍、防风、柴胡、砂仁、甘草等服之立效。

荆防病的这些规律，已形成与伤寒、温病两大体系不同

的疾病特征，诊疗时应须独立看待。如果说，荆防二药能促进人体免疫系统功能的话，那末荆防病便可认为是人体免疫系统的病患了。古方“荆防败毒散”的作用前人早已认识，历经使用有效，绝无置疑。

附：经验方

荆防归芎异功汤。

方组：荆芥、防风、当归、芎药、党参、白术、茯苓、半夏、炙甘草。

加桔梗、柴胡、紫苏——治胸胁痛。

加桔梗、薄荷、贝母、连翘、银花——治咽肿痛。

加紫苏、麦冬、五味子、侧柏炭——治鼻血。

加干姜、砂仁、白芷、白蒺藜——治牙床肿痛。

加蝉退、白蒺藜、菊花——治风湿疹痒。

加黄芩、栀子、柴胡、木通、菊花——治耳痛流脓血。

加焦诃子、煨肉蔻、五味子——治五更泻。

加蝉退、白蒺藜、菊花、紫苏、木贼草——治眼目红肿痛。

去当归，加干姜、煨肉蔻、砂仁——治肠风泻，有泡沫声响。

去当归，加砂仁、干姜、柴胡——治小儿发烧，泻利腹痛，绿色便。

加地榆炭、干姜、柴胡（或黄连黄芩木香）治赤白痢，腹痛发烧。

加贝母、白芷、白蒺藜、银花、蒲公英——治疮疡疥肿痛。

加续断、干姜、砂仁——治腰痛（椎间盘突出）。

加肉桂、干姜、白芷、紫苏——治妇女面部蝴蝶斑，经行色黑。

加砂仁、干姜、煨肉蔻、乌贼骨、木香——治妇女白带。

加山萸肉、砂仁、干姜——治妇女经期不准，量或多或少。

加焦山栀、益母草——治妇女倒经。

加荜澄茄、干姜、砂仁、小茴香、扁蓄——治妇女小便时涩痛（尿系感染）

加蛇床子、小茴香、紫苏——治妇女阴痒，湿疹。

加砂仁、小茴香、干姜、木香、威灵仙、元胡——治痛经。

有防风脉原属脾虚者，五味异功汤势所必用。

风湿有内热时，加苦参。

有羌活脉时须加羌活。

口苦、耳鸣、白带有黄色、涕黄、痰黄、加黄芩或柴胡。

## 三、温　病

温病即是在不同的季节，感受了不同的温热病邪而引起的外感，热性病的总称。明医·吴又可："温邪乃天地之异气，瘟疫也。"清医·叶天士说："温邪上受，首先犯肺，逆传心包。"

温病是一种极其复杂而又传变迅速的热性传染病。它的或因多为血热型体质，由口鼻受邪，变生各种急热症候。在春天受邪称为春温，夏为暑温，湿温等等。"温"是根本，风暑湿是诱因或兼夹症。"温"为一种"异气"，内含"毒"素。

邪热瘀于脏腑三焦或入心包，可导致神昏谵妄等症。毒入血分，而发斑疹

温病与伤寒虽同为外感热病，其病理过程也多是由表及里，由浅入深。但伤寒是以“六经”辨证，而温病则以“卫、气、营、血”及“三焦”为辨证依据。正如叶天士所言及的“在卫汗之可也，到气才可清气，入营犹可透热转气，入血就恐耗血动血，直须凉血散血……。”进一步明确了温病的证治规律。

## 四、湿　病

水液在人体生活中占有很重要的地位。五脏六腑，肌肉，皮肤，骨骼，关节，都靠水液来滋养润滑。所有排泄物都靠水洗涤运送。呼吸、体温，以水的代谢来调节其他如：泪、汗、涕、唾涎、痰等都由水来运作。有水才能完成新陈代谢，以维系生命。因此水在人体中的多少，运行状况，关系着正常生理健康与疾病。如某一环节出现毛病，就会造成水湿病。如：水肿、积水、缺水、尿多或少、汗多或不汗、口干引饮、痰、咳、白带、大便干或泄泻等。水湿流注关节，与外邪结合，则成为各种风湿病。

湿病是水液为患，其症状为：呕吐、泻泄、头身疼痛、体困重、手足发胀、面目虚浮、腰背四肢运动不灵、甚或疼痛、关节动则疼痛，或弹响、涕清冷、痰多、咳喘、流涎、泛酸、白带过多、经来清淡、葡萄胎等。

湿病分为寒湿、湿热、风湿三种：

腹中有湿，气分或血分有寒，为寒湿。

腹中有湿，气分或血分有热，为湿热。

内有湿，肢体感受外界风寒或风热，则为风湿痹病，正如："风寒湿三气杂至，合而为痹也。其风气胜者为行痹；寒气胜者为痛痹；湿气胜者为着痹。"（《素问·痹论》）

其治法：

寒湿在脏腑间，有"藿香正气汤"证。"附子理中汤"证或"桂附理中汤"证。吴茱萸汤证。草蔻分清饮证。附子细辛汤证。四逆汤证。香砂养胃汤证。乌药散证。四神丸证。真人养脏汤证。妇女湿重白带过多，有完带汤证，或湿气充盈全身，用香砂六君子汤加川芎、当归。平调气血，能使土木勿侮。

寒湿在腹，经络间复受风寒，多为诸关节病。气分用：防风、独活、五加皮、千年健、威灵仙、细辛、草蔻等。血分用桂枝、肉桂、川芎、当归、鸡血藤、丹参、木瓜等。尚须分别选用络石藤、夜交藤、忍冬藤、青风藤等，以及乳香、没药、松节等，诸通络祛湿药。立方要内外兼顾，双管齐下，奏效较快。

寒湿在腹，又外受风热的关节疼痛，气分用桑叶、桑枝、蔓荆子、桑寄生、防风等外疏风热，薏米仁、丝瓜络以收湿通络，伍香砂以除寒湿；风在血分时，病多为耳目肿痛、风湿疹、疥、疮、疡、腮肿牙痛等；耳肿痛，"柴平汤"加夏枯草外散风热，内除寒湿。目红肿痛，流泪、涕清、荆、防、蝉退、木贼草、白蒺藜、菊花等外舒风热。细辛、白芷、半夏治肺胃寒湿，风湿、疹、疥、疮、疡，亦用。眼科药重用蝉退、白蒺藜、透毒外出，加二花、蒲公英、丹皮、赤芍、解毒凉血药，配白术以渗湿。牙痛腮肿用荆防、白蒺藜、紫苏、

白芷、菊花、僵蚕舒风散结止痛，二陈砂仁以除胃寒。分攻合击，病均立愈。其间风热亢甚时，芩连苦参亦应相机加入，其效更显。

脏腑间湿热证：舌质红，苔多黄腻，或燥，直用三黄便可。如湿热在气分时，病多头面口唇间出生白色水泡，或肢体间出生白泡，关节间生痰核，（寒湿证也有）或历节风痛肿，（白虎历节风）平热用石膏、知母、葛根等；除湿用、薏米仁、白术、茯苓等。

腹中寒湿与妇女经血相搏时，多发为诸妇科病。（参看妇科辑要）

其出路：

腹中寒湿病欲解时，其痛点多自上而下，由胃及腹，再转至小腹，最后循经传至两腿间，痛至足趾末端，便告痊愈。此种疼痛，有症则不显於脉象，是脏腑寒湿病随经解散的自然现象。与经络外受风寒证有别。

各种关节病欲解时，痛处由腿肢上部逐渐向下转移至于足趾末梢则痊愈。

疹、疥、疮、疡、痒、红肿痛症，以疏风散结透疹解毒为要。绝不能逆其病势，养痈贻患，欲其内消势不可能。

总之，湿在人体各个组织、细胞、腺体、筋骨节间都有它的重要作用。当它输不灵在某处积蓄凝滞时，湿病於是产生。例如：膝关节疼痛病中有的以手扪膝时感到掌下肌肉中噗噗喳喳作响，里面已聚湿成液。治胃腑舒经络每多见好。因足阳明经路过膝间。如治不得当，鹤膝风病有可能产生。平时白带多的妇女，孕时羊水定多，有的会产生子肿病。胃肺有湿的人容易得痰多咳喘病。痰出於气管，却生於胃中，古

说："胃为生痰之器，肺为储痰之具"：化痰止喘咳，不治胃是不凑效的。

水湿在人体中，有其一定循行路线。古说："三焦"（六腑之一）就是它的运行道路。所以《素问·灵兰秘典论》说："三焦者，决渎之官，水道出焉"。有三种状态，所谓："上焦如雾，中焦如沤，下焦如渎"。即水湿在上焦，形成云雾状升腾散发；在中焦起生化敷布；在下焦直接渗利以去。

湿是体气运行时渗透到各个器官、组织间的点滴液体，也有各腺体专供的液体。涕泪是咸的，痰涎唾液是甜淡的，来路不同，作用各异。但是它也有一定的管道。它如：霍乱病人吐泻过多，形成脱水现象。如此看来，水湿在人体中形成一个与血液循环、淋巴、神经等一样的系统，协同运行而营生。对它所生疾病，应分别看待。治疗上也应顺其运行规律，如雾者升而发之；如沤者中而和之；如渎者导而下之。对湿所生病，自当壮脾（脾主湿）之吸收与输泄功能，使其勿着勿留，和同其他各系统并行不悖，共营其生理上运行。

## 五、杂　病

### 1、中风

症状：

突然晕倒，不省人事，醒后多留后遗症，语言蹇涩、有声无语，咬字不清，口眼㖞斜，偏瘫，半身不遂。若晕后鼾声如雷，小便失禁为脱证难治。

治法：

人事不省者，先刺人中，或风府，或用通关散取嚏，有

嚏则生。

不语者，香砂六君子汤加石菖蒲、远志、半夏、南星，有外感脉证，加相应药物。

语言蹇滞，或有声无语，按内伤脉症治疗，何脏不足补何脏。再加远志、菖蒲、半夏、南星。内寒加炙附子，有外感脉症，加相应药物。

口眼㖞斜，香砂六君子汤加南星、半夏、白附子，有外感脉症加相应药物。若左关寸脉浮大加平肝息风药。气虚重用炙黄芪。

偏瘫、半身不遂，左半身为血虚，右为气虚，下肢不用为肾虚。用药重在补虚。炙芪、党参（人参）、当归、天麻为必用药物。若语言蹇滞，半身不遂同时出现，先治语言蹇滞，次治半身不遂。

按：中风一证，多属气虚、血虚，或肾虚。

治标：建瓴汤镇肝熄风。

治本：重在大补气血，补气为先，选用补阳还五汤。因气为血之帅，气行则血行，在补气之中，依脉象再加舒经活络药物，全面治疗，多见良效。

2、心脏病

症状：

心悸、心慌、脉结代。

心脏跳动，上下起落，开合收缩，均匀自如，怡然自得，柔和有力，有神，是为正常。如任何一方显出偏悖，便出现病态。若心脏左大右小或右大左小，血管变形，药物难治。

心脏功能出现异常，有其一定原因。解除原因，跳动自趋正常。

如：外感风寒，经络不畅，内伤生冷，脏腑气血运行受滞。血虚则左无力，气虚则右无力。脾肾虚则收无力，心肺虚则张无力。一不正常，心脏病便出现。

治法：

脉右虚则补气，左虚则补血。或用“归脾”汤气血双补。结、代脉补脾肾。或用“炙甘草汤”上下齐补，效果良好。“柏子养心丸”直调心脏功能，也有实效，至于在其它疾病中出现心脏病，各因疾病类型，依法治之。

3、头痛

头痛多见于外感病，治如外感法。

寒湿头痛：头痛、痛在骨内，清涕、不咳、不烧，舌质淡或青，苔薄白或青灰。

方药：六君子汤加干姜、砂仁、细辛、白芷、藁本、蔓荆子、紫苏、有羌防脉加羌活防风。

肝寒头痛：痛在头面颊等处骨缝中。揉按之不减，有的颧骨表面发红。未发时饮食如常，照常习作，一如好人，脉之左有桂枝脉，关部内有吴茱萸脉。舌质边缘青，苔青或灰。

方药：大温经汤去益母草、麦冬。

风热头痛，头痛如裂，汗多，口渴，右脉洪大，左有桂枝脉，为白虎桂枝汤证。若头痛如破，汗多不渴，舌质淡，苔薄白，左有桂枝脉左关洪大，此非白虎汤证，依脉象用桂枝汤加焦枣十二枚愈。

体虚头痛：头痛、眼花、或微汗。依脉象血虚补血，气虚补气。

4、牙痛

牙痛多为外感病引起，依外感病治法加白蒺藜。

肝热牙痛，牛黄解毒片。

肾虚牙痛，元参、生地、熟地。水煎服。

胃寒牙痛，六君子汤。上牙痛加干姜、砂仁、白蒺藜。

下牙痛加萆茇补骨脂白蒺藜。

如有外感依脉象加相应药。

脾寒牙痛，左痛，附子理中丸。右痛，桂附理中丸。

牙床肿痛，多属外感病，依外感法加白蒺藜、当归、乳香、桔梗。

5、口舌糜烂

口腔病多为外感与胃病相结合而生。

热口疮：舌尖及边缘生红色斑点，糜烂痛疼，舌质红。难于进食，伤风用“荆防败毒散”去柴、前、胡，加生甘草、桔梗、薄荷、竹叶、灯心、通草，苔厚加消食药。

寒口疮：舌质淡，苔青，舌尖边斑点糜烂。用香砂六君子汤加桔梗、薄荷。苔厚加消食药。再依脉象加相应外感药。

两颊及唇舌溃烂亦如上法。

6、咽喉肿痛

咽部肿痛，上腭部发红，脉见荆防脉。用荆防甘桔汤加薄荷柴胡。脉急促而躁，用银翘散、或桑菊饮。咽部红肿，无表证脉时，用养阴清肺汤，重用元参，加丹皮、赤芍、贝母、银花等。

咽痛色青，紫而不肿，舌质淡，苔青，为寒痛。香砂六君子汤加桔梗。依脉象加表药。

声音嘶哑，喉痛，应分清表里寒热。舌质淡，苔青，痰

青，为肺胃寒；苔白舌质红，为风热；寒加乌梅，再加肉桂，热加射干、胖大海、甘桔为必用药。若嘶哑日久，加炙黄芪、当归。

7、哮喘

病在肺，但与脾肾相关连，外感为主要诱因。

伤寒型：咳嗽痰青，舌质淡，苔青，清涕，有桂枝脉象。小青龙汤主之，胸痛加桔梗，痰不利加远志，痰黄加柴胡。

伤风型：症状与上相同，有荆防脉象。香砂六君子汤加荆防，再加干姜、细辛、五味子、白芷、紫苏。

脾虚型：症状与上同，惟动则气喘甚。脉右关中虚。

药用：炙黄芪 30g　党参 20g　白术 10g　茯苓 10g　半夏 10g　干姜 10g　细辛 3g　五味子 3g　煨肉蔻 10g　白芷 6g　苏梗 4g　桔梗 10g　远志 6g　炙甘草 10g　加姜枣。有外感脉症加外感药。

8、足后跟痛（骨刺）

乃肾虚之象。药用济生肾气丸。

可用汤剂：九地 10g　山药 10g　山萸肉 10g　茯苓 10g　泽泻 10g　丹皮 6g　肉桂 10g　炙附子 10g　水煎服。

9、腰胯痛（坐骨神经痛）

病为骨盆腔内瘀积寒湿所致。

右痛：香砂六君子汤加补骨脂、肉桂、木香、当归、山萸肉、金狗脊、威灵仙、羌活或独活。

左痛：香砂六君子汤加炙小茴香、木香、苏梗、威灵仙、炙附子、防风。

10、上肢及肩胛痛（肩周炎）

病为气虚，经络受风寒所致。

香砂六君子汤加桂枝、防风、威灵仙、姜黄。

左痛，重用防风，右痛加当归、乳香。

无论左右痛，有羌活脉加羌活。无桂枝脉去桂枝。

11、背脊病（脊椎骨质增生）

症见：腰背酸痛，活动受限，或两肩胛骨缝间疼痛。

病为伤寒所致。寒伤巨阳脉。两肩胛骨缝间痛，为风伤足太阳经脉。

香砂六君子汤加炙黄芪、桂枝、威灵仙、元胡、苏梗、白芷。左关脉大时，加当归、芍药。有羌活脉加羌活。

12、鹅掌风

手心起皮，厚硬裂口，甚或渗血、脱皮、痒痛。

病属手厥阴经受风所致。

药用：薄荷 3g　连翘壳 10g　丹皮 6g　赤芍 10g　白薇 10g　麦冬 10g　坐地 10g　茯苓 10g　生甘草 3g　生姜三片。

有外感脉象加相应药物。

13、失眠症

卫气入内则睡眠。

但失眠症原因很多：一、身体任何部位出现病痛，就会失眠。二、胃不和，卧不安。三、血不养心则失眠。补肝血则眠多。如：酸枣仁汤，当归补血汤等。

至若，情感波动，辗转难眠，远非药物所能治。姑不论。

## 六、传染病

传染病是疫毒病菌传入人体所生疾病。其病来势猛，传播快，发病人群集中。若处理不及时或不得当，常危及生命。其类型有多种：

麻疹、猩红热、白喉、痄腮（腮腺炎）、伤寒（类似中医湿温）、霍乱（系真菌性病，与中医藿香正气汤功能性疾病有别）、破伤风、鼠疫、性病、肺结核等。

传染病有其特殊症候，初得之与一般外感病近相似。惟脉象有别，一般外感伤及人体肌肤口鼻，仅功能发生疾病，脉象上常有表里经络之分。传染病则不同，六经混然一体，无表里经络之分，极易鉴别。

详情请参看《传染病学》时逸人著。

# 诊　断

## 一、药、脉、证、方、相印法

方脉学是一门具有综合性、复杂性的学科。在实际应用中主要以证、药、脉、方为主。查历代医疗书籍中：脉学只言脉与证；医书多言病证与药方，间或言及脉证；方剂学中只言方剂组成和适应病症；药物学中只言药物性能与适应证候。各学科分散论述，语言每多略而不详，难以全面综合印证使用。医者虽运用四诊八纲，辨证论治，选方用药，毕竟缺乏确切根据，难免不无迷离之感。千百年来，陈陈相因。中医学术裹足不前，这未曾不是原因之一。

为便于学医者综合运用起见，特将：药、脉、证方相印法分述于后。

其法简明可靠，系统方便，既能分清疾病性质，切合实际，又能探本求源，伏主求因。在诊疗中最可能作到证、脉相符，药脉相符，药证相符。然后所处方剂，既能符合病情需要，又能切合生理需要，环环相扣，融为一体，每见疗效。

现将常见病中经常运用，且已证明最确切无误的药、脉、证、相符合 34 种药脉分篇条例如下：供选用。

### 外感篇

外感病是常见病之一。是六淫邪气侵袭人体皮毛、口鼻，

阻滞汗液气血经络运行之所致。六淫性质不同，着人部位有别，病理反应也就各异。初得病时一般人都能察觉，有的也会用药处理。但有效有不效。或因轻微小疾，人多忽视，往往酿成复杂病候。因此，外感病类型很多，兼夹证不一。统套方剂每难切合实际，难于辨证施治。原因在于辨证中忽视切脉所致。明代医家喻嘉言认为："以药试病，或妄药误病，皆医之罪也。"晋代曾有人用桂枝汤通治一般外感病，其结果如王叔和所说："桂枝下咽，阳盛而死，承气入胃，阴盛以亡。"前车应戒，然而桂枝汤不能因阳盛而不用，主要在於用得其当。

《内经》上说，"风为百病之长，善行而数变。"是说明外感病是百病根源。经验证明，内伤杂病中经常也夹杂着外感病。若脉理不明，难于分析。因此，对外感病的确切认识，不独有利于治外感病而已，也有助于治疗各种复杂病，现将个人多年实践经验所得，反复验证，将确实具有具体、准确、有效的方法提炼概括，总结出外感篇一则，共九节，察脉知证，依证用药，以药名脉，分清疾病性质，并对兼夹证及其病理演变规律等，从个人观察认识所及，一一列出，供参考使用。

## 桂枝脉证

脉象：

左手寸、关、尺三部脉管壁之内侧面，另出现线状脉一条，和脉管相平行，与脉管外壁相处于若即若离之间，随同脉搏起伏跳动。浮取则得，间或出现于关寸部和关尺部。

证候：

头昏、头痛、项背强痛、胃腹痛、恶心欲吐、烧或不烧、

阵汗出，又复恶寒，而痛不因汗解，有时汗愈多而痛愈烈。

附图

**虚线表示桂枝脉**

病因：

心阳不足，血络受寒。

证药配伍：

表寒：桂枝汤（有汗）。麻黄汤（无汗）。

胃腹寒痛：小建中汤。

喘：桂枝加厚朴杏子汤。

水饮射肺：小青龙汤。

胆热：柴胡桂枝汤。

心阴不足，脉结代心动悸：炙甘草汤。

病理演变：

肺胃热盛：白虎汤。桂枝白虎汤。

肝胆血分热起：大小柴胡汤。

水液运行失调：五苓散。

桂枝一脉，除外感伤寒病外，在内伤杂病中的胃腹、关节、水肿、瘫痪、肝病、肺病、心脏病、脉管病、疮疖、妇女经血不调等病中也常出现。

当桂枝脉出现处的脉管壁侧面，如有残缺不够完整时，这是内伤病脉象。有时误认为桂枝脉。但桂枝脉是在完整的脉管壁之外与脉管相处于若即若离之间的独特的一线状脉，而和内伤脉的脉管壁本身形态，有所改变二者截然不同，应须鉴别。

附言：

证药配伍、病理演变二节内容，系《伤寒论》方证，如求其详，希参看原本。

## 荆芥脉证

脉象：

浮取左寸浮大或数。

证候：

头昏痛、眩晕、耳痛、目赤、疮疖、痢、寒热、疹等。

病因：

风邪侵袭血分。

证药配伍：

伤风感冒：荆防达表汤。（时逸人《处方学》）

外风内寒：荆防五积散。

疮疡瘾疹：荆防败毒散。

病理演变：

疮、疡、疹、癣、瘰疬、目赤、喉肿、腮肿、赤白痢疾、咳吐脓血、痔。

妇女经血不调、痛经、崩漏、抽搐。

附言：

荆芥脉证，是风邪侵袭血分所致，其因有二：一、血虚

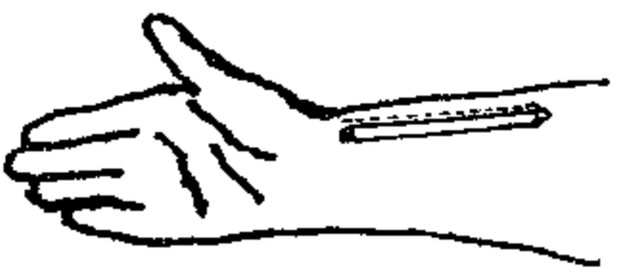
受风；二、劳累汗出受风，或热人汗出当风。其所显示各证，初起多为轻微感冒，后则为正邪互争中肌体所表现的各种反应，形成多种类型病态。其邪热向外时出现疮、疹等；向内寻求出路时出现痢、带、崩漏等。经验中体会上列各症每在荆芥脉出现同时也多有防风脉象并存，古医名方中荆防二药经常合同，有其一定的实践意义。

## 防风脉证

脉象：

浮取右手三部脉管壁外侧，紧临管壁处有一线状脉，随同脉搏跳动。

附图



虚线表示防风脉

证候：

眩晕、头身痛、骨节痹痛、四肢挛急、左胸肋痛、疮疡、癣、疥、疲乏困倦、烦满易怒；老人皮肤发痒、脱屑；咽喉肿痛、耳下肿痛、眼红肿痛；肠鸣腹胀、便泻等。

病因：

风寒外袭，汗腺闭塞，代谢受阻。

证药配伍：

外感：荆防达表汤。荆防败毒散。

咽喉肿痛：甘桔汤。凉膈散。加荆芥、防风、银花、牛子等。甚则加：元参、生地、贝母、麦冬、丹皮等。

眼红肿痛：当归、赤芍、荆芥、防风、蝉退、白蒺藜、木贼草、黄连等。

胃腹寒痛：荆防五积散。

腹痛泻利：痛泻要方。

疮疡肿毒：防风通圣散。

崩漏：归芍六君子汤。加：荆芥、防风、川断、九地、仙鹤草、煅龙牡等。

病理演变：

血分热起：衄、眼红痛、咽肿、经血妄行、痢疾、咳血、尿血等。

体液受阻：关节痹痛、带下、鼻塞不通、乳癌、瘰疬、食不长肌肉、皮痒、眼皮跳动、烦躁等。

附言：防风一脉与脾脏经气有关，当其出现后，病痛多表现在四肢关节、左胸肋部胀痛、腹胀易怒，脾气不伸，肝气不顺。饮食不为肌肉、小儿喜哭、夜间抽筋、消瘦、成人半身麻木、瘫痪等之证，清医陈修园说："大病必须顾脾胃，病转之后，必使土木勿忤，防风驱风之中，大有回生之力，乃补脾和肝之妙剂也。"

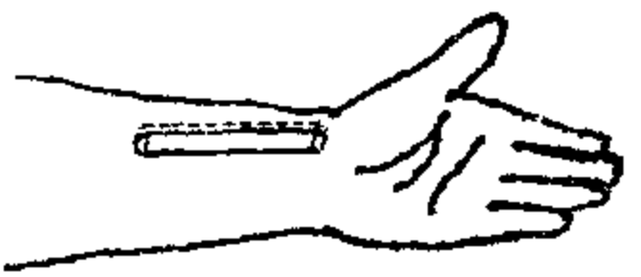
当脾气不运时，体液运行受阻，代谢功能失常，必致引发诸多疾病。防风脉药，当与人体免疫系统有关。

## 羌活脉证

脉象：

浮取左手三部脉管壁外侧；另有一条线状脉与脉管壁相处于若即若离之间，随脉跳动。

附图



**虚线表示羌活脉**

证候：

头痛、后脑痛、项、背、腰腿痛、肩胛痛、恶心、呕吐、背寒或发烧。

病因：

寒冷风湿侵袭背部。

证药配伍：

头身背痛：羌活胜湿汤。

背痛呕吐：平胃散加羌活。

项强不能转侧：六君子汤，加羌活。

病理演变：

脊椎关节变形。

中风不语。

痈疽发背。

附言：

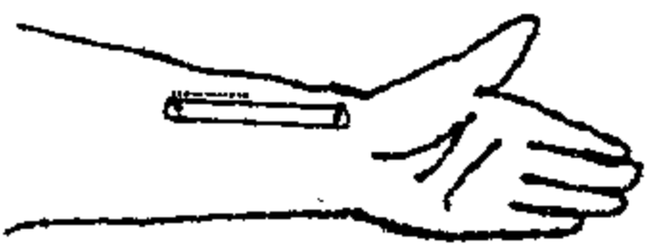
足太阳膀胱经行身之背。督脉在脊中为三阳之总管。羌活脉象反映了背部太督二经之病。但在无病的健康人当其出汗时，也有羌活脉出现，却项背不痛，俟其汗止后，再切脉时，羌活脉则不复再见，似此脉象与背部汗腺体温有关。它如：脊椎病、中风、关节病等，其中也常伴有此种脉象，似与脑脊髓液也有关系。

## 独活脉证

脉象：

浮取左手尺部脉管壁外侧另出现一线状脉，与管壁处于若即若离之间。

附图



虚线表示独活脉

证候：

腰痛、下肢痛、胯痛。

病因：

风、寒、湿侵袭腰、腿。

证药配伍：

腰肢关节痛：独活寄生汤。

腰痛兼肾虚：桂附八味丸，加独活。

胯痛：山萸肉、补骨脂、威灵仙、独活等。

病理演变：

下肢痿废，曲伸不能。

附言：

羌活脉多出现于左手寸、关尺三部，独活脉仅出现于尺部。虽古人对羌独二药多同方并用。但个人体会在诊疗时依脉分别使用，应手取效。

## 紫苏脉证

脉象：

浮取左手三部脉管壁之上正中有一线状脉，浮现管壁之上，随脉跳动。

附图

虚线表示紫苏脉

证候：

头痛、浑身不适、咳嗽、喘、鼻塞、胸闷、梅核气。

病因：

口鼻吸受风寒之气。

证药配伍：

咳嗽头身痛：参苏饮。

梅核气：四七汤。

病理演变：

胆热横逆：胸肋疼痛。

肝火上逆：咳痰带血或咯血。

## 藿香脉证

脉象：

浮取右关。脉来管壁处散乱无力。

附图

证候：

头身痛、心腹痛、吐泻、烦乱、牙痛、眉棱骨痛。

病因：

风寒秽气，内侵中焦，胃阳失运。

证药配伍：

呕吐头身痛：藿香正气汤。

泄泻：理中汤，加：藿香。

病理演变：

脱水：口干、唇红、皮肤干燥、渴饮等。

胃阳失调：胃溃疡、慢性肠胃病。

附言：

在牙痛、口疮、面肌肉痛、腿膝关节痛时，也多有藿香脉出现。

## 细辛脉证

脉象：

浮取右寸脉鼓硬。

证候：

头昏重、体困、鼻酸、流清涕、目泪喷嚏连连，或欲嚏不能者，及阵阵汗出、不烧不渴、口淡无味、咽喉周缘色青紫、胸闷、咳嗽、鼻塞等。

病因：

风寒侵袭肺肾气分，郁遏阳气，寒水上侵。

证药配伍：

感冒清涕泪：苍术、二陈、干姜、附子、细辛、白芷、苏梗。

少阴经伤寒：麻黄附子细辛汤。

咳嗽痰青：干姜、细辛、五味子。

头痛：细辛、白芷、藁本。

病理演变：

涕黄、鼻血、哮喘、颊颔骨痛。

附言：

流行感冒初起时也有鼻流清涕一症，但其咽喉周缘色红

或微黄，口干、舌质红、脉数软。细辛脉证却与此相反，二者应须鉴别。

细辛脉证二三日不解时，若体气壮实者多有流鼻血、鼻塞、痰涕发黄、头昏蒙等肝胆血分热起症状。斯时寒水上逆症状却消失。如痛在后脑或面颊颔部，不红不肿，其痛入骨，须及时治疗，迁延时日，若出现块硬肿痛，多有癌变可能。喷嚏、哈欠是人体阳气在循行路线中活动现象。阳不入阴则无眠，阳气受阻，寒水必致上逆，阳气式微，恶寒而倦卧，喜哈欠，（少阴病）。如少阴经病时则用：麻黄附子细辛汤。麻黄发其阳，引阳上升外出，附子追肾寒，细辛却肺寒，三药上下内外一气贯通，以恢复阳气生理功能。在少阴病中，若血分亢奋时，则有血痢、咽痛、烦躁等症出现，如少阴病本身演变时，则有汗出，利下、肢冷、息高等气分阴阳离决等危证出现。（参看《伤寒论·少阴篇》）。

## 柴胡脉证

脉象：

左关浮取，脉管壁上单独浮起一水泡样脉象虚软无力，随同脉搏起伏。

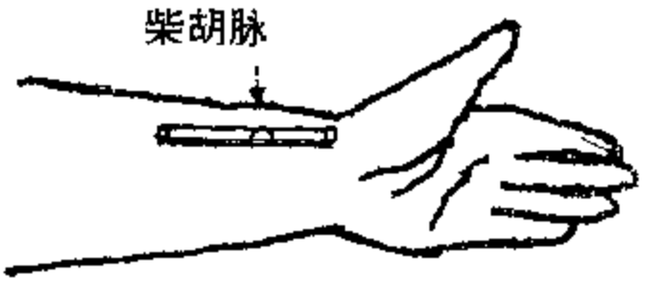
证候：

眩晕、耳鸣、耳聋、口苦、不欲食、胸胁痛、痰涕黄、寒热往来、耳后肿痛。

病因：

外感不退，内伤食滞，郁怒不解，肝气不舒。

附图




证药配伍：

胆热：小柴胡汤。

少阳、阳明内热：大柴胡汤。

情志不舒：逍遥散。

胃腹寒胀：柴平汤。

病理演变：

邪热内陷：下痢腹痛。

邪热陷入血分：高热谵语。

湿热相结：黄疸。

附言：

柴胡脉证，多因其它病症所引发。因此多与原发病相伴行，有时原发病解除后，柴胡脉证常自平复。

“肝为将军之官，胆为中正之官”。肝胆不宁静，表明身体某部有病邪的干扰。治必求其所因，伏其所主。如违背人体自然疗能，治不求因，见病治病，妄平肝胆，徒伤正气，往往给病人带来后患。但须与急则治标，缓则治本相结合。

## 外感病类型

一、伤寒型：

1、寒伤血分桂枝汤型：头身项背痛，阵阵汗出或无汗，恶风寒，恶心欲吐，舌淡、苔青、脉缓有桂枝脉证。

药用：桂枝汤加五味异功汤，胃寒加砂仁、干姜。（经验方）咳嗽、气喘加麻黄、杏仁。

注：此证治不得当，迁延时日，便有病变出现。如：《伤寒论》所述的桂枝柴胡证，桂枝白虎汤证，抵当汤证。除中病（多饮多食）等。详细请参阅《伤寒论》。

2、寒伤气分细辛汤型：头痛、清涕、阵阵汗出、喷嚏连连、咳嗽、痰青，或不咳、气粗、四肢困重、一般不发烧。（如与荆防病相连，必发烧）舌淡、苔青。脉有细辛脉象。

药用：细辛汤：细辛、干姜、白芷、紫苏、砂仁、加五味异功汤。（经验方）咳加五味子，痰不利加桔梗、远志，痰黄加柴胡或黄芩。

四逆汤型：恶寒、四肢厥冷、倦卧欲睡、舌质青、苔腻，或无苔。六脉迟而细。

药用：四逆汤，或回阳救急汤，即五味异功汤加炮姜、炮附子、肉桂、五味子（5—7粒）开水煎服，肢温脉回有力即愈。

注：如又出现头身痛，发烧等症，依脉证按法治之。《伤寒论》（太阳少阴同病者，先攻其里，乃解其表）。

二、伤风型：

（A）风寒型：

1、荆防汤型：头昏痛、眩晕、四肢骨节痛、发烧、舌淡红、苔薄白。脉有荆芥、防风脉象。

药用：五味异功汤加荆芥、防风。

腰痛，有羌独活脉加羌活、独活。有续断脉加续断。眉

棱骨痛加白芷、紫苏。咽痛或胸痛加桔梗。口苦、耳鸣、加柴胡或黄芩、头痛甚加菊花僵蚕。鼻塞不通加辛夷、干姜、砂仁、薄荷。鼻血加五味子、麦冬、侧柏炭、当归。牙痛加白蒺藜。

注：荆防病原属气分受风，血分反弹排毒。多有发热、肿痛、风疹、疮疡、鼻血等症，妇女有错经痛经等。荆防败毒散、防风通圣散等均属有效名方。

2、参苏饮型：头身痛、咳嗽、胸闷、痰粘、发热、恶寒、舌淡红或青、苔腻。有紫苏脉。

药用：参苏饮（去干葛）胸胁痛或痰黄加柴胡或黄芩。

3、藿香正气汤型：头身痛、发热、呕吐或泻、胃痛、舌淡、苔灰或青。脉有藿香脉象。

药用：藿香正气汤。

(B) 风热型：

桑菊饮型：（温病）发热、头身痛、口干、咽痛、咳嗽、小便短赤、苔尖边红、苔微黄、脉浮数。（无六阳经脉）。

药用：桑菊饮。口干喜饮加麦冬、贝母，咽肿痛加元参、生地，目赤加蝉退、白蒺藜、赤芍等。

银翘散型：（温病）头身痛、口干、发烧、无汗、咳嗽、咽红痛、舌赤、苔白。

药用：银翘散。

蝉菊汤型：

1、（肝经血分）头身痛，发烧，目赤，肿痛，流泪，羞明，口干渴，舌赤或微红，苔腻，脉左寸关浮大。

药用：蝉菊汤（经验方）当归、赤芍、蝉退、菊花、白

蒺藜、荆芥、木贼草、谷精草、茯苓、生甘草。目赤痛甚加黄连、红花。脉有防风、羌活、细辛等脉象时，加入各脉药。如：传入四肢骨节间痛时，则目疾轻，而周身痛。另以桑枝、桑寄生、秦艽、丹参、青风藤、牛膝、薏米仁、北沙参、丝瓜络等类药组方调治之。

2、肺经气分：头身痛，咳嗽，发烧，恶寒，口干，舌红，苔白。脉右寸浮大软。

药用：薄荷、贝母、马斗铃、蔓荆子、牛蒡子、菊花、桔梗、生甘草。

注：1、风热病。风邪在血分时，极易引发脏腑湿热。

2、风寒病。风邪无论在血分或气分，多有湿邪兼挟。

3、风热病。初起似温病，而无温病之传变。眼目痛虽有传染性，但只限于眼目。虽有全身筋骨痛类型，而无高热等症。

三、外感病两型合病型：

1、桂枝细辛型，患者既有桂枝证型，又有细辛证型，药用小青龙汤。

2、桂枝荆防型，二病同时出现，治先用荆防汤，待热退后，再用桂枝汤。（千万不可先用桂枝汤，火上加油）

3、荆防细辛型，二病同时出现，二方合用即解。

4、荆防参苏型

5、参苏细辛型

6、荆防蝉菊型

7、蝉菊细辛型

上四型，二方合用，也可即解。

注：外感病两感型合并者其分辨方法；除各自症候群外，脉象上极为分明，最易察知。

如：猩红热，两腮发红，咽喉红烂，上下嘴唇四周发白。

白喉，除高烧外，喉肿处上有白膜，擦之不去。

医者临症时宜细心观察，分别处理。切不可误将传染病认为外感小病而忽略治疗，酿成大错。

## 内伤篇

内伤病是人在饮食起居，七情六欲，职业劳作，病邪损害，药物中伤等原因中造成五脏六腑，气血经络，虚弱劳损的种种病态所有这些虚损内伤，无论在有形的血液形质方面，或无形的功能方面，真正受到损伤的有时是一个方面，而影响往往及于相对面，病症常常真假互见，虚实并存。这是机体病理上的正常反映，凭证断病，容易导致错误认识，贻误治疗。例如：阴虚阳亢，脾虚肝强，虚人中邪，邪实正虚等等。因此：在辨证论治中，关于切脉一项，潜心揣摸，最为有益。现将已总结出的内伤脉证撰写内伤篇一则，共二十五节，兹分述于下。

### 川芎脉证

脉象：

左关迟缓，脉管微硬，来而迟迟不前，去则缓缓似扭，挣挣巴巴。甚则曲曲如蛇行，是为肝死之脉。

证候：

精神苦闷不振，善太息，易怒，身体困倦，嗜坐卧，不欲起，不喜饮食。面色无华，或青或白，头重顶如物压，后

脑冷痛。右肋下胀闷。全身浮肿或腹水。

病因：

情志不遂，肝气不舒，或咨食生冷酸物，或误服平肝清热药物，致肝气损伤。

证药配伍：

情志抑郁：佛手散。加：香附子、玫瑰花。

酸冷伤肝：佛手散。加：公丁香、砂仁。

寒湿内瘀：佛手散合平胃散。加：吴茱萸。

肝虚失眠：酸枣仁汤。

产后：生化汤。

病理演变：

郁闷。

贫血。

水气泛溢：浮肿或腹水。

突然腹鼓胀，两眼圆睁。（肝气暴升）

附言：

肝气不畅，肝失调达，则肝不生血而见血虚。肝郁之证。一阳不升，气液上逆而为腹胀，浮肿，腹水等阴霾四布气象。如欲却除沉寒痼冷，旺盛肌体活力；必先使木旺春回，然后生机盎然。

## 芍药脉证

脉象：

A 型：左关脉管单独浮大有力。

B 型：左关脉管单独沉弦数或缓。

证候：

A 型：汗多、头昏、眩晕、四肢酸困软、耳鸣、眼花、胃酸痛、痉、带下、善噫、血崩漏。

B 型：胃腹痛、痢下、赤白带、目红痛、小便赤涩、阴肿、胁痛、痛经、口苦、黄疸等。

病因：

A 型：肾阴不足。外邪亢盛。久病伤阴。热病耗阴。产生失血。怒气伤肝，肝阳过亢。

B 型：热邪内陷。湿热内蕴。血滞。

证药配伍：

A 型：表邪致病者：用与其他脉象相应表药，配芍药。如：桂枝汤等。

肝阳独亢：芍药、龙骨、牡蛎、珍珠母等。

情志致伤：一贯煎。逍遥散。

热病肝亢：羚羊钩藤汤。清瘟败毒饮。犀角地黄汤等。

血崩漏：补中益气汤加芍药、九地、阿胶、仙鹤草等。

寒湿内滞：肝阳外现：芍药、肉桂（桂枝）、吴茱萸、苍术等。

B 型：湿热内蕴：龙胆泻肝汤。

血滞：大黄、丹皮、桃仁、土元等。

病理演变：

A 型：阴虚阳越：眩，眼黑，肢软，潮热。

B 型：二便闭结，吐，便血，内热如焚。

附言：

左关脉浮大或沉弦，都表明肝脏本身为内外邪气所困扰。在治疗时，无论清邪，滋阴，潜阳，敛汗，舒经，解毒，或清热平肝。用肉桂，桂枝温经平肝时都常配用芍药。证明芍

药有调整肝脏功能的作用。但肝气虚弱不足时，芍药又非所宜。故有："芍药伐肝，有伤生气，为产后血虚禁药"。

当左关脉出现沉弦时，右关脉常浮大有力。表明为内热之候。（须参看舌及苔）须直清里热。热解脉复外出。

肝气与肝阳之别：肝气是肝之功能，如受抑制时则表现为：身痛，胃腹痛，胸胁痛，出血汗多，痉症等。

肝阳是肝血中之热，因液（阴）虚不能维阳，（阴阳不平衡）阳热浮越外现所致之各种病候，如：耳鸣，眩晕，浮肿，多汗，牙痛，腰肢酸软等。在治法上，一是祛邪以平肝调肝，顺其条达之性。一是滋水以生木，潜阳以平肝，达到阴平阳秘的地步。

肝阴与肝血，也有分别：肝阴指血中之液而言，血中之液缺少，易致肝燥筋急；血中之液多血少，势必面青，浮肿，色黄无华等贫血症状出现。

在桂枝证中左关脉浮大，症现汗出头痛，用桂枝汤调营卫，症脉就平复。在痢疾症中，左关脉又为沉弦数，用芩连芍药内清后，左关脉又恢复正常。脉象的如此一浮一沉，一松一缩，当然是抵抗内外邪气的表现。面治疗中辅以芍药，首先证明芍药对脉管有巨大影响力。它如：逍遥散中芍药配白术又作用于门静脉。

## 当归脉证

脉象：

A 型：左关中取（即透过脉管壁）血流微弱无力。

B 型：左关中取血流沸腾如沸水滚动（乱动）。

C 型：左关中取接近底部似有粗糙碴质状物，上下不离其

位，滞滞碍手，或滞涩不前。

证候：

A 型：贫血、体困头昏、目视不明、面白脱色、口唇无华、目白睛青灰、闭经、经少色淡、失眠、心悸、健忘、食少、心烦、肢麻。

B 型：头昏、目胀或红肿、身体局部红肿焮痛、咳吐脓血、便血、胁痛、月经过多、小便赤涩热痛、口干不喜饮、热而无汗。

C 型：闭经、经行不爽量少、小腹刺痛、胃痛、胸胁刺痛、半身不遂、皮肌间易起青红片块疙瘩、肌肤甲错、干瘦、面目青黄乏力。

病因：

A 型：久病伤血，营养不良，或误服损伤肝血药物，失血。

B 型：外感内蕴积热，邪毒瘀于血分。

C 型：久病耗阴，经脉不和，血不归经。

证药配伍：

A 型：血虚。当归补血汤。人参养营汤等。

B 型：血热。丹栀逍遥散。犀角地黄汤。仙方活命饮等。

C 型：血滞。四物调经汤。桃仁承气汤。丹参等。

病理演变：

血虚不复：有导致严重贫血可能。

血热不除：有失血、斑疹、脑病等发生。

血滞不解：有虚劳，痨瘵等病出现。

附言：

按血病原因很多：有外邪、内伤、疫毒和血液本身失调，

或瘀或滞；肾阴肾阳不足，水不生木；或误服平肝伤血药物，损伤血液再生功能；气病而致血病，情志过劳等等。治疗时务须追寻血病根源，参合其他脉证依法治之。

血热亢盛一证；如属温病、传染病等范畴各依法治之。

血热亢盛，转为脑病时，脉多变为劲弦，斯时在解毒凉血散血、平肝药物中加入“白虎汤”清肺金，使金旺制木，症较易愈。余师愚之“清瘟解毒饮”是最好例证。

在一般感冒发烧和其他杂病期间，左关如出现B型当归脉象病人身体某部有瘀血出血症状时，在治疗外感等病药方中加入当归等和止血散血解毒等药，病多同时一并解除。

如在毒邪高热不退时，于凉血解毒药剂中加入金石斛一药，效果也好。

## 地黄脉证

脉象：

左尺脉浮动且虚，或左尺关二部均现革脉。

证候：

腰酸困痛，腿脚酸软，足心热痛，足根痛不能触地，小便频数，量少，或多，口渴欲饮，头昏体困，阳萎，血崩漏，尿血，阳强，遗精，气短，咳嗽声音空旷，浊痰上泛，耳鸣，目昏花，遗精，易恐惊而恐惊时二便不能自收持，齿痛松动等。

病因：

热病伤阴。房劳伤肾。外感发烧久久不解。肺劳阴虚。惊恐伤肾。崩漏失血。消化不良。营养失调。

证药配伍：

腰脚酸软痛：六味地黄丸。桂附八味丸。

耳鸣目昏花：杞菊地黄丸。

相火易动阳强：知柏地黄丸。

崩漏：九地、山萸肉、当归头、生龙牡、黄芪，虚寒漏血；加：鹿角胶等。

遗精：金锁固精丸。加：九地、龙牡、桑螵蛸、菟丝子。

阳萎：人参鹿茸丸。桂附八味丸。气虚用补中益气汤。加：九地、鹿茸、菟丝子等。

病理演变：

腰腿萎废。下肢瘫痪。

阳越头昏。齿松痛。脑血管意外。

性欲减退。血闭。血崩。尿血。小便不利，消渴等。

附言：

真阴亏损，易致阳越。在肝为眩晕，头昏，目视不明，血压升高；在心为心跳气短，脉现结代；在肺为上消；在脾为中消；甚或多食而不饱。（中风症多有此象）。

血崩，失血等症中重用地黄极易收效。

四物汤与肝肾：

当归、川芎、芍药、地黄合组为一方名四物汤。通治肝血不调，血虚劳损诸病，此方可合用，也可分用。肝气虚者重用川芎。肝气过强时重用芍药。血虚重用当归。液（阴）虚重用地黄。惟芍药能抑肝之强，增益肝阴，调整肝气。当归、川芎舒气生新血；当归、芍药调肝补血；当归、地黄纯补血液；芍药、地黄纯补肝肾之阴；川芎、芍药具有增进肝阴肝阳两种功能效用。是以血虚兼寒重用当归、川芎二阳药。阴虚有热，重用芍药、地黄二阴药。人体生理病理各殊，阴阳

气血，变化复杂。运用四物汤剂，凭证是一个方面，切脉求因，最为切当。

## 续断脉证

脉象：

左尺脉虚浮数，中按血流促促上涌，似有急供不及之势。

证候：

腰痛不可挽仰，面目萎黄浮肿，崩漏，胎动，流产，尿血，痢，痔等。

病因：

外感邪热伤阴。或劳力过度，阴血暗耗。或久病耗阴。

证药配伍：

腰痛：属外感者解表药中加续断。

胎动：泰山磐石饮，或补中益气汤，加：续断、山萸肉。

闪跌叉气：补中益气汤，加：续断、木香、乳香。

崩漏：气虚：补中益气汤，加：续断、血余炭等。或归脾汤，加：续断等。

面目萎黄浮肿：八珍汤，加：续断、砂仁、肉桂等。

病理演变：

血漏不止。

腰腿萎废。

贫血面萎黄浮肿。

椎间盘突出。骨质增生。

附言：

续断脉证，多在外感发烧，或其它疾病并发，少见独立出现。切其脉虚数无力，血管中血流急急上涌，似有不竭不

止，急供不及之势，每当病因解除后，尺脉常自安静。

如：椎间盘突出，腰椎骨质增生二病常有此脉象。同时伴有各经络脉证，综合治疗方中重用续断，见效很快。

## 山萸肉脉证

脉象：

左尺脉虚，浮、中、沉三候均无力。

证候：

腰酸困痛，两腿无力，小便频数，遗滑精，阳萎，尿血，头昏，耳鸣耳聋，目昏花，经血不调，不孕，老年经水不断，喘息少气，面色萎黄。

病因：

高热。失血。利下伤阴。情欲不节。久病。年老下衰。肝阳过亢。先天不足。药物损伤。惊恐等。

证药配伍：

腰腿酸软：六味地黄汤。桂附八味丸。

小便频数：六味地黄丸或八味肾气丸。加：覆盆子。

老年妇人经水不断：断下汤。（傅青主）

遗精早泄：人参鹿茸丸。补中益气汤。加山萸肉，桑螵蛸，菟丝子，白果，煅龙牡等。

耳鸣：十全大补汤。加：山萸肉、灵磁石、骨碎补等。

病理演变：

腰腿痿废。

内风瘫痪。

暴脱气喘汗出。

附言：

地黄、续断、山萸肉三脉之比较。

地黄脉：左尺脉浮动且虚，或革脉。

续断脉：左尺虚浮数，中按如流促促上涌。

山萸肉脉：左尺浮、中、沉均无力。

地黄脉证是肾真阴亏损。

续断脉证是肾中阴液精血亏损。

山萸肉脉证是肾气衰弱。

当病人根基已离，元气将脱、肺肾之气互不相接，症见：口张、气喘、汗出淋漓时，山萸肉可济急。

## 狗脊脉证

脉象：

左尺脉管紧束如线，或鼓起高大绷、硬、缓。

证候：

腰痛，腰强，下肢麻木，胯痛。

病因：

寒湿伤及腰肾经络。

证药配伍：

腰痛脉紧：狗脊、肉桂、补骨脂等。

脉鼓缓：狗脊、苍术、五加皮等。

腰胯痛：（左）六君子汤。加：狗脊、防风、秦艽、附子等。

（右）归芍六君子汤。加：狗脊、肉桂、补骨脂、威灵仙等。

病理演变：

腰腿痿废麻木等。

附言：

坐骨神经痛和下肢肌肉痿缩病，常有狗脊脉象。

## 吴茱萸脉证

脉象：

左关沉取脉紧（其紧在脉管底部）。

证候：

心腹痛胀，痞硬，寒疝，呕吐涎沫，泄泻，女子经迟，色黑，瘀块。舌质青，苔青腻。

病因：

生冷内伤，寒湿郁积。

证药配伍：

胃痛呕吐涎沫：吴茱萸汤。

胃痛作酸：左金丸。或平胃散加：吴茱萸、乌贼骨。

五更泻：四神丸。

经来迟色黑：大温经汤。

病理演变：

腹中结块，痹痛。

反胃吐食。

口疮。牙痛。头痛在骨。

水肿。

附言：

吴茱萸主治三阴寒，当胃肠内平滑肌因寒湿致痰气血郁积，交凝成块吴茱萸常常取效。

## 肉桂脉证

脉象：

左关中取，脉管紧束如索，直上下行。

证候：

胃腹痛，食少，右肋下痛，面无华色，贫血，体困，腹胀，水肿，泄泻，腰膝筋骨痛，嗳气，经色黑，量少迟，面生蝴蝶斑。

病因：

寒伤肝血。

证药配伍：

肝血寒：当归、肉桂。

脾气寒：白术、炮姜、肉桂。

经迟黑少：四物汤。加：肉桂。

疮疡塌陷：阳和汤。

肾气虚寒：桂附八味丸。

筋骨寒痛：肉桂、芍药。

泄泻：真人养脏汤。

水肿：五苓散去桂枝加肉桂。

病理演变：

贫血。

水肿。腹水。

不孕。

衰老。

附言：

肉桂脉证，是腹中血分受寒，血行受滞，影响血液运行

和生血功能，在妇女则经少、迟、色黑、有块、或痛经，甚或血瘀经闭。年届五十左右经断后，则面失华色、黄瘦、衰老。因此肉桂作用在温血脉，壮肌肉，驻颜色。其用在里。而桂枝作用在温暖肌表血脉。二者功同温血，一走表，一走里。在治疗上，治内用肉桂。治肌表经络多用桂枝。但二者脉象绝不相同；无论证在表或里，选用二药时，仍以脉象为准则，最为妥贴。

## 丁香脉证

脉象：

左关微鼓缓。

证候：

胃腹胀痛，呕吐，呃逆，右胁下胀痛。

病因：

酸冷饮食，损伤肝阳。

证药配伍：

右胁下胀痛：当归、公丁香、木香、元胡。

呃逆：丁香柿蒂散。

胃痛呕吐：平胃散。加：公丁香、伏龙肝。

虚寒崩漏：丁香胶艾汤。

附言：

肉桂脉证是腹内血分受寒。

丁香脉证是肝之功能因寒而滞。

## 党参脉证

脉象：

右关平塌虚弱，右寸脉或塌或小。

证候：

疲困，四肢少力，面色黄白，声低气短，胸闷，痰多不利，食少。

病因：

饥饱不时，伤及中焦。劳累耗气。

证药配伍：

脾胃虚弱：六君子汤，大小建中汤，补中益气汤。

痰嗽不利：六君子汤加远志桔梗。

气虚泄泻：参苓白术散。

呼吸困难：独参汤。

病理演变：心跳气短，惊悸。双手颤抖，中风不语，神识昏愦或舌强言蹇，肢体偏枯。

附言：

党参脉证，是人体脾胃、肺、脑诸脏功能虚弱表现。功能失调，证出多样。病出脾胃与白术配合；病出肺与五味子配合；病出心与附子配合。当右关脉平塌虚弱，而右寸脉却柔软高起时，也是气虚之候，仍可用党参以扶胃气。

## 白术脉证

脉象：

右关中取脉来空空。（脉管中血流虚无、或稀少）

证候：

完谷不化，大便溏稀，不喜食饮，痰多，口干渴，喜热饮，四肢困倦，嗜卧，目不欲开，动则气喘，饮食不为肌肉，瘦削。腹胀满。脐腹痛。小腹左侧堕痛。肌肤肿，手足胫肿。

心悸弓，

病因：

久泻伤脾，或药物通下伤气，湿郁脾因。

证药配伍：

泄泻食少：真人养脏汤。

食不为肌肉：参苓白术散。

肌肤肿：热：白术、茯苓、石膏、麻黄。冷：五苓散。

脐腹痛：寒：附子理中汤。热：白术、黄芩。或白术、芍药、甘草。

动则气喘：六君子汤。加炙黄芪、五味子。

关节肿痛：白术、薏米仁、茯苓、防风、桑枝等。

病理演变：

不嗜饮食：虚肿。

气短困卧、消瘦。

大便溏泄，干瘦，目陷。

脾虚日久，更能导致心跳、心慌。（植物神经功能紊乱）

附言：

白术能增强胃肠吸收功能，这一机能似与肾脏重吸收机能互相协调一致，因此，在水液潴留体内外而为肿胀症时，每多选用白术、山药、茯苓、泽泻等药促进水液循环，以解除水湿郁积之水肿病。如：肾气虚衰时药剂重心放在肾，脾之功能衰弱时，药剂偏重于治脾。四肢关节肿痛时，在用疏经药物时仍须配合能够增强脾或肾对水液有吸收排泄药物，促其吸收与排泄，以加速疾病的恢复。

“四君子汤”与脾肺肾

党参、白术、茯苓、甘草组成四君子汤，为治肠胃病主

方，亦为补气药方，党参能增强脾胃肺肾脏器之活动功能；白术能增强脾胃之吸收功能；茯苓有利水去湿作用；甘草有大补脾阴作用。白术得党参，脾胃吸收功能益强；茯苓得党参利水之效益宏；甘草得党参脾阴之力益壮。四药合用，互相促进，共成其旺盛消化功能，为健脾胃之主方。痰多者，脾肾之吸收功能有障碍。治虚痰，必用白术。尚须注意肾。故有"肺为储痰之器，脾为生痰之具"，"肾虚水泛为痰"之说。痰涎之根在於脾肾，水湿失运，精微不化，聚为痰饮，而或肾虚失司，水饮泛溢，而为水液诸病。

肺虚治脾，虚则补其母。脾旺消化力强，营养充足，气液充盈肺先得其益。肺强金旺，金生水、肾亦得其利。从本质言：人体水液吸收排泄生化功能，系一整体。肺主布敷，脾主吸收，肾主排泄。三脏职能共同完成水液循环代谢。而一脏有病，必影响它脏。因此，在水气病中，三脏症状，常相杂见。陈修园之消水圣愈汤，仲景大小青龙汤、真武汤等均为治水要方，均以调理脾肺肾三脏功能为旨意。

## 黄芪脉证

脉象：

左或右三部脉大缓而虚旷，起则缓缓而来，落则突然下跌。左三部出现此属血虚。右三部出现则为气虚。

证候：

体困乏力，虚损，五劳，水肿，疮疡久不收口，喘嗽，汗多，小便不利，脱肛，瘫痪，贫血，妇人子脏风邪，子宫脱垂，流产。

病因：

气血津液，虚损内伤。

证药配伍：

气虚：六君子汤加黄芪。

血虚：四物汤加黄芪。

脾阴虚：归脾汤。

阴虚劳嗽：黄芪鳖甲汤。

疮疡久不收口，十全大补汤。

肢体浮肿：风水：防已黄芪汤。虚肿：十全大补汤。

半身不遂：补阳还五汤。

病理演变：

精血久不恢复。老弱早衰。疲困乏力。躬背驼腰。

附言：

黄芪补气温三焦。根据黄芪脉象证候和个人多年实践观察，黄芪一药能兴奋人体血管活动机能，无论动静脉管、体表、体内及各脏腑血管、淋巴腺管等。其功能既能治疗上列各症。在老年人中，黄芪脉象尤为突出。有出现於左三部者，但多数出现於右三部。表现为气虚证状，甚者躬腰驼背，持杖而行。故老年人多有心脏病、中风等。疗病时配白附子、南星、白芷等治口眼㖞斜甚效。用补中益气汤治子宫脱垂和胃下垂等。对肺虚咳喘，黄芪又有殊功。也许因肺中血管特多的缘故吧。

## 草果脉证

脉象：

右关沉取脉紧（紧在脉管底部）

证候：

腹胀，脘闷欲吐，左肋下胀痛，小腿肚转筋痛，发寒热。

病因：

冷湿伤及脾阳。

证药配伍：

腹胀痛：白术、草果仁、木香等。

脘闷不嗜食：六君子汤加草果仁。

寒热往来：达原饮。

小腿肚痛：白术、草果仁、木瓜、藿香等。

病理演变：

吐泻。

腹胀肿满。

脾脏块痛。

附言：

吴又可说："知母能治阳明独盛之热，草果能治太阴（足）独盛之寒"。脾寒肝必热，遇有外邪其热更甚，常发为寒热往来。吴氏达原饮是其主方。仲圣小柴胡汤，也治寒热往来，其病是胃阳虚而胆热。二方症状相同，治法相同，所扶之阳有别而已。

## 干姜脉证

脉象：

右关中取脉紧，血流中有线状紧脉一条，随同血流上下行。如间或出现，则腹中痛。

证候：

脐腹痛。呕吐，泄泻，口唇青紫，咳嗽，鼻涕清，痰稀白或青，鼻头青，恶寒肢冷。

病因：

脾肺气分受寒，阳气虚衰。

证药配伍：

脐腹痛、泄泻：理中汤。附子理中汤。桂附理中汤。

恶寒肢冷：四逆汤。回阳救急汤。

咳嗽痰涕青：干姜、细辛、五味子。或小青龙汤。

呕吐：理中汤加二陈汤。

病理演变：

肢冷脉细，元阳欲灭。

寒水泛溢，肿满。

附言：

脾肺胃气分阳气不足，寒水泛溢，水肿，肢冷，痰涕青等一派阴霾四布之症出现。干姜为要药。

干姜守中，得半夏、茯苓则化痰。得麻黄、紫苏则发汗。得苍术、茯苓则开湿郁。古说："干姜守而不走，附子走而不守，干姜无附子不行，附子无干姜不热。"是以四逆汤有追阳之功。

干姜之用重在温脾阳。炮姜能温脾之血分。治血证有殊功，因脾统血故也。

良姜能温心脾之阳，治胃痛、小腹痛有效。

## 砂仁脉证

脉象：

右关浮取紧或弦。

证候：

胃脘痛，食少，气闷，嗳气，呕吐，泄泻，脘胀，体困。

病因：

生冷伤胃。

证药配伍：

胃呆食少：香砂六君子汤。

胃脘痛：平胃散。加：砂仁、良姜、元胡等。

呕　吐：平胃散。加：砂仁、藿香、竹茹等。

伤　食：香砂六君子汤。加：焦三仙。

嗳　气：旋复代赭汤。加：砂仁等。

病理演变：

胃功能逐渐衰退，食欲不振。日久胃胀痛或胃壁上触之有硬块。

附言：

胃病有因内伤生冷，外感风寒，夹气、夹水饮、夹郁等。如舌苔青、舌质青、属寒。砂仁为必用药。若舌苔白薄、舌质红者，多属肝郁气滞金铃子散加砂仁。胃病除按本脉外，尚须参合其它各脉，一并论治。观察舌苔更为切要：苔青或黑润为寒；苔灰为水饮；苔厚腐为食积；无苔为胃气不升；舌右有苔，舌左边无苔为寒伤气分；反之为寒伤血分。治气分宜温脾，治血分宜温肝。

砂仁一药，味辛窜香温，馀味有清凉感。与干姜合用助胃阳。除水饮与苍术合用。滋胃阴扶胃气（胃功能）与麦冬、或芍药合用。因此，砂仁一药，其效在促进胃之功能，起健胃作用。

## 大腹皮脉证

脉象：

右关浮取脉缓，脉管隆起如弓形，绷硬鼓指。

证候：

胃脘痞满，胀痛，霍乱吐逆，胸腹肢肿，吐酸，子肿，脚气，瘴疟，苔青或灰。

病因：

寒湿气滞。

证药配伍：

心腹胀痛：平胃散。加：大腹皮、苏梗、砂仁等。

霍乱吐逆：藿香正气汤。理中汤。

肿　　胀：五苓散。五皮饮。佛手散。加：吴茱萸、大腹皮等。

病理演变：

肢体水肿。

附言：

寒湿积於胃及三焦，胃气难於输布，肝强时发为霍乱吐逆；

弱时寒水浸袭全身浮肿。治疗时如肝强者单独用逐水气药；肝弱时须用当归、川芎、吴茱萸等使肝强春生，水患方易平息。

## 厚朴脉证

脉象：

右关浮取，脉管绷紧而鼓，中取有帚状线条随脉搏跳动向寸口部汩汩冲射，有时指下感觉吱吱作响。

证候：

腹胀痛，喘，咳。

病因：

气滞上逆。

证药配伍：

大便结腹胀：大小承气汤。

表气不舒里气上逆：厚朴杏仁汤。

水湿胀逆：苍术、厚朴、大腹皮、茯苓等。

血滞腹胀：桃仁承气汤。

食积胀逆：五消汤。加：厚朴。

梅核气：四七汤。

病理演变：

饮食难下，二便不通，腹臌胀满。

附言：

脾之经气不舒，腹中胀气窜逆，理脾胃方中加防风即解。（必须有防风脉象）肝气不舒腹胀，调肝方中重用厚朴，配枳壳、沉香等舒气药，从内破散。腹水鼓胀，则用大戟、芫花、甘遂等逐水消胀。厚朴又非所宜，因厚朴只消滞气。

## 苏子脉证

脉象：

右寸口中取脉滑，血流累累上窜。

证候：

咳嗽痰多，胸胀气喘，不嗜食，面目浮肿。

病因：

痰湿上逆。

证药配伍：

外感痰咳：外感方中加苏子。

食痰上逆：三子养亲汤。

水饮上逆：十枣汤。葶苈大枣汤。

怒气上逆：逍遥散。加：贝母、苏子。

病理演变：

肺胀喘满。胸胁支饮。头面肢体浮肿。

附言：

《脉诀》云："寸口脉滑，非气即食"。"气"字可理解为表气或里气有问题致使湿浊上逆。苏子治气分寒湿痰上升；桑白皮可治气分热痰上升；莱菔子治胃中食积痰升；白芥子治皮里膜外之痰（朱丹溪），亦能搜剔内外痰结及胸膈寒痰冷涎壅塞。以上数药，均可治寸口脉滑证。

## 葛根脉证

脉象：

右关浮取大数。

证候：

口干渴，发热无汗，下利腹痛，头身痛，烦躁，吐衄。斑疹不出。

病因：

胃腹气分阳热内蕴，多因其它疾病引发。

证药配伍：

身热下利腹痛：葛根黄芩黄连汤。

表证不解：柴葛解肌汤。

斑疹不出：升麻葛根汤。

病理演变：

吐，衄，便血。泻利烦渴。

附言：

葛根脉证是胃肠气分阳热郁闭所致。葛根可以透阳热，起阴气，解口渴，止便泻。李东垣说："葛根其气轻浮，鼓舞胃气上行，生津液，解肌热，治脾胃虚弱之圣药也"。如胃有寒湿误用之，则面目浮肿。

## 石膏脉证

脉象：

右寸关二脉浮取浮大而数，中取洪大而有力。

证候：

头痛，牙痛，发热，汗多，口干渴引饮，气喘，胸满，烦躁，唇紫，头面生水泡。

病因：

肺胃气分阳热亢盛。

证药配伍：

表寒未解：大青龙汤。桂枝白虎汤。

气喘汗多脉洪引饮：白虎汤。

高热神昏：清瘟解毒饮。

蛤蟆瘟：普济消毒饮。

一身悉肿：越婢汤。

阳热郁肺：麻杏石甘草。

牙　　痛：石膏、熟地、元参。

病理演变：

大汗淋漓，饮不解渴，肿胀喘满。

眩晕昏愦。

附言：

一中年妇人，因面颊红肿，曾注射青霉素后满面白泡隆起，流清水不止。用普济消毒饮重用石膏愈。

一般常见病中如口唇起泡，中含水液，用薄荷清气分阳热，随药而愈，但必须配砂仁干姜等除胃中寒湿药方可。

石膏一药如用不得当能致口眼㖞斜。

## 乌药脉证

脉象：

右尺浮取脉弦或鼓硬。

证候：

小腹痛，食不下，噎，疝气，脚气、嗳腐、精神郁闷，心腹痛，腹胀满，手足厥冷，足胫青紫黑。

病因：

小腹受寒。

证药配伍：

疝气：乌药散。

腿足肿：乌药、吴茱萸、良姜、天仙藤、白术、茯苓等（天仙藤散）

食少嗳腐噎：六君子汤。加：乌药、砂仁、香附子等。

病理演变：

小腹癥瘕。

下肢肿痛。

附言：

乌药脉，腹诊时似为小腹内膜间病。足厥阴肝经行於此，气海、关元、丹田等穴都集於此。又为人身阳气发源之地。因此乌药证多与气血相连，也多有痰湿气血互结为块痛、妇女

得之，妨碍行经。

## 小茴香脉证

脉象：

右尺中取脉紧。

证候：

寒疝，小腹坠痛，阴囊冷痛，痃癖作痛，腰痛，脚肿，小便频数，量少，妇女痛经，久不生育，舌根质青。

病因：

生冷寒气侵袭小腹。

证药配伍：

寒疝痛：茴香丸。（沈氏尊生方）

痃癖痛：茴香散。（证治准绳方）

偏坠：

左睾坠：六君子汤。加：炙小香、砂仁、川楝子、白芍等。

右睾坠：补中益气汤。加：炙小香、菟丝子、砂仁、川楝子、元胡等。

腰痛：金狗脊、炙小香、大云、补骨脂等。

痛经：归芍六君子汤。加：炙小香、元胡、益母草、苏梗等。

病理演变：

癥瘕积聚，经血不调，久不生育。

附言：

茴香脉证是寒凝小腹气分，影响肝经、肾经，发为疝、坠瘕、腰痛等。妨碍血行则痛经。在病理反应上气分寒时，血

分热必起。因此在古今名方中，多寒热药并用。

若气分寒凝累及血分寒滞时，当用偏热药直攻其寒，炙小香、吴茱萸、芦巴子、木香、元胡等尤当必用。

## 元参脉证

脉象：

左寸脉浮大，中取有滑象。

证候：

口干，咽肿痛，大便干，头昏，眩晕，牙痛，瘰疬，丹毒。

病因：

血热上壅。阴虚肾阳上浮。

证药配伍：

头昏腰困：元参、地黄、山萸肉、生牡蛎等。

咽喉肿痛：养阴清肺汤。加：连翘、薄荷、禹花、蒲公英等。

牙痛：元参、生地、白蒺藜等。

肺热喘促：元参、贝母、黄芩、天竺黄等。

眩晕：元参、白薇、龙骨、牡蛎、代赭石、牛膝等。

大便干燥：滋阴增液汤。

病理演变：

脑血管意外。瘫痪。肺痈。脓胸。下肢痿废。

附言：

血热上壅。多由外邪所致。肾阴亏虚，水不制火，肾阳上浮。所谓无根浮游之火，下虚上实。元参可以平调。至如外邪所致的咽牙肿痛、头面浮肿，肺炎喘促，丹毒等，配方

中重用元参，有滋阴清热解毒之效。

## 酸枣仁脉证

脉象：

左关寸之间，（关之上寸之下）脉管微大而软中空。

证候：

心烦，失眠，虚汗，口渴，盗汗，肢酸困痛、心悸，易怒，恍惚不安。

病因：

心肝阴液不足。

证药配伍：

心烦失眠：酸枣仁汤。（金匮方）

心悸恍惚：酸枣仁汤。（秘传方）

易　　怒：当归、白芍、酸枣仁、龙骨、牡蛎、茯神。

病理演变：

神经衰弱。健忘恍惚。

惊恐不安。

附言：

心肝阴液不足，心神失于濡养，神不守舍，发为上列诸症。如三焦有虚火配栀子；胃中阳热高时配知母；心经有火配朱砂；肝阳过亢配龙牡铁落等。

切取此脉时，若左关寸间中取有滑脉时，多有咳痰带血、胸膈痛疼等症。治当别论，非枣仁所宜。

## 总　　述

内伤病，人为的较多。外感病环境影响较大。但也与个

人卫生状况有关。体质健强的人，少有外感病，容易得外感病的人，必有潜在内伤病。《内经》曰："邪之所凑，其气必虚"。因此在诊疗这两个疾病时，就得同时兼顾。而在脉象上也常常同时有所反映。内伤为本，外感为因。病者不知，医者应本末兼顾。如果当在内伤病突出时，自然以调治内伤为主。可是在切脉时，却往往发现有某种外感脉象存在。但无外感证型。一旦脏腑反应强盛时，才出现头身痛等症状来。有人误认为虚不受补。其实不然，这种潜在证候，是因机体抗病能力不足，正邪相安无事的原故；有的也是经络不够舒畅的原故。所以在调理脏腑时，仍应依脉适当加入相应的外感脉药，或疏经药，疗效较好。总之调理脏腑，疏通经络，平衡阴阳气血，以排除病邪的方法，既可适用於治疗外感内伤病，也可适用於治疗其他一切复杂病候。应当作为治疗疾病的普遍法则来看待为是。

## 内伤病治法与特有脉象

高者抑之，陷者举之。结者散之，散者收之。寒者热之，热者寒之。实则泻之，虚者补之。其高者因而越之，其下者引而竭之，在中者和之，通因通用，塞因塞用。滋阴潜阳，泻南补北。虚则补其母，实则泻其子等。历代医家又在此基础上又提出自己的见解和治疗方法：朱丹溪益阴济阳。张子和汗吐下和。张景岳新方八阵等。五彩纷呈，不胜枚举。

治气用四君子汤。治血用四物汤。气血两虚，用八珍汤。补血用人参养荣汤。补肾用六味地黄汤。补三焦用炙黄芪。治心神衰弱用归脾汤，或柏子养心汤。脉结代心动悸用炙甘草汤。

此皆古法古方可依。但实际应用中要依证按脉；如发现有某种经脉出现时，先调其经脉，再治其脏腑。或表里内外同时合治。因各脏腑之经脉与其本脏腑息息相关，气脉相通，功能相济。根枝相连。一通均通，一顺均顺。而血虚者，当以增强肝肾功能为主。药用肾气汤加当归、枸杞子、巴戟天、鹿角胶等。产后失血，面白汗多，须六君子汤加炮姜，佛手散强肝脾生新血。小儿面黄肌瘦，一般家庭习用皂矾给服，效果良好。殊不知皂矾有补铁作用。

特有脉象：

凡六脉中超出或不足其各自脏腑本身应有脉象时，发现在那个部位，那个脏腑就有所损伤。如上篇所述。此外尚有下列数种：

1、左内侧三部脉，似桂枝脉而边缘不整如锯齿者。

2、左内侧三部脉，整个脉管半面全无，只有外侧半面脉跳动。（好似一个竹管从中破开为二半面）

3、右部外侧有防风脉而无防风经证，只现四肢困倦无力；或三部内侧管壁虚晃无力，似有若无，或三部外侧管壁虚晃无力，似有若无。

4、左寸关部脉平塌不起，或右寸关部脉平塌不起。

5、六脉乍大乍小，忽急忽缓，或有表脉出现，细候又不见，变幻不定。（对此种病人，不论其症候如何，应先补气血，固肾壮本，俟其脉象有常时，再依脉证施治较妥）

6、或左急右缓，或右急左缓。（病在急的一面，应先治之）

7、六脉中某个别脉，或左三部或右三部，其脉位脱离其原有脉位。高出于皮肤间。（病愈后其脉便回归原位，如肾脉

深牢近骨，肝脉之弦和近筋等）

## 二、疑似脉辨

紧脉：

分二种：

1、脉管收缩细小如线，上下跳动而有力。

2、脉管之形不变，在上下左右中等部另出现一线状脉，随同脉搏跳动。

紧脉主寒。出现於何部，病痛便在何部，有时忽隐忽现，病痛也就时痛时止。是脉管收束而紧张之象。

弦脉：

其状有二：

1、单纯收束紧张，所谓：绰绰如按琴瑟弦。

2、某部之脉状如枣核形，在上下跳动中，“端直以长”，同时核形又在紧张中开阖活动。

弦主气血不和，或气液不和，如痃癖积聚，诸疟痰饮等。又主肝气横逆，躁急忿怒，温热痉病等。一般所谓肝脉自弦，（左关）是弦而和缓从容自如之象。自然，也没有病痛出现，是为肝之本脉。

微脉：

微指整个脉象似有若无之象，所谓：“脉微欲绝”。

细脉：

细是整个脉形缩细，指下显然如发如丝。

微细二脉都是内气将溃之象。《内经》云：“形盛脉细，少气不足以息者死”。“及热病脉细，神昏不能自持者死”。新病

脉细，如治疗及时得当者，也多转危为安。而微脉则多危殆。

濡脉：濡是脉弱小踏步不前之象。多见於左尺部，主肾气肾精虚损病。

啬脉：是血和液不足之象。多见於左关中沉部，主阴血虚少或瘀血内阻。

大脉：是血管扩张之象，而又溢出於其自身脉位。

洪脉：是血管扩张溢出其自身脉位的同时，跳动时浮中沉皆大而有力，中取如波涛汹涌之象。

大主病进，或主虚劳。

洪主热甚邪甚，洪而有力为实火。无力为虚火。

缓脉：缓指整个脉搏跳动势头而言，从容而来，缓缓而去，呼吸四至为缓。

迟脉：滑伯仁曰："以至数而言，呼吸之间，脉仅三至"。张路玉曰："呼吸定息，不及四至"。

缓主湿主痰，迟主寒主滞。热病脉缓或迟，（阳极转阴）多与神昏谵语，冲乱烦躁等脑病症状相并发。

结脉：王世亨曰："大小不定，往来不拘数，至时一止"。孙思邈曰："脉来动而中止，按之小数，中能还者，举指则动"。结脉是在跳动中一微数后止而复动。所谓："动而中止时按之又有小数"和"大小不定，往来不拘数"。此种脉象，有在每至脉中出现者，也有十数至后而出现者。

代脉：王叔和云："数而中止，不能自还，因而复动"。杨仁斋曰："动而再止，不能自还，因而复动，由是复止，寻之良久乃起，有更代之意"。

代脉是在跳动中突然一暂停，复又照常跳动。有十数至

一止者，也有数十或百至以上一止者。

结脉之止，不是真止，而是小数，似止非止。代脉之止，却是真止。止后从头再跳，界限分明。

按：十八难曰："脉来去时，一止，无常数"。《伤寒论》："脉结代，心动悸"。二种学说为时最早。对结代二脉相提并论。后世则将二脉分别看待。有人认为结代脉是五脏受气不全之故。在个人经验中脉之结代在心脏，而结代之根源，有因肝肾血液不足者，有因脾气虚弱者，也有因外感病经络不疏而致者。但代脉之根，则多属肾虚，壮肾之后，代脉多自消失。

数脉：经云："来去促急，一息六七至"。张景岳曰："五至六至以上，皆为数脉"。

促脉：丹波氏脉学辑要谓："促为短急促迫之状，非为数而一止也"。

数脉以至数而言，促脉以脉之动势而言，数脉多热病，促脉多虚寒病。

小脉：叶子雨云："减於常脉一倍曰小"。《内经》云："滑小紧以沉，病益甚"。又云："温病大热，脉反细小，手足逆者死"。

弱脉：《脉理求真》云："沉小软弱，举之如无，按之乃得"。王叔和云："极软而沉，细按之指下欲绝"。《内经》云："脉弱以滑，是有胃气"。又云："脉弱以啬，是为久病"。

小脉指脉管收缩变小，血液流量不足，言脉之形状。

弱脉指脉管乏力和脉搏跳动无力，就脉之动势而言。

长脉：高阳生曰："长者阳也，指下寻之，如持竿之状"。

张石顽曰："指下逗逗，上溢鱼际，下连尺泽，过於本位"。如竿之状，出鱼际，溢尺泽，是说明脉搏上下跳动而有力永长之象。

牢脉：李中梓曰："沉分大而弦实，浮中二候，了不可得"。脉说云："沉而有力，牢之位也，沉而弦长，牢之体也"。是沉分之脉弦长以实者便是。

长脉得於浮中二候，而牢脉则在沉分寻求，二者主病当以所兼脉为主，同时参合证候以为断。一般无病情况下，长牢二脉主长寿。长脉就横向而言。牢脉指纵深而言，也就是在沉分深切之脉仍跳动而不断者为牢脉。

按：切脉要取正确姿势，次要定位。医者必须用左手切取病者右手之脉，右手切取左脉。脉分寸关尺；食指取寸，中指取关，无名指取尺，定位一定要准确。因关部脉又可分关上、关下二部，关上主胸膈间病，关下主肝之下，肾之上腰胁间病。

**"左寸浮部不是小肠脉　右寸浮部不是大肠脉"** 古说："左寸小肠肝胆肾，右寸大肠肺脾命"。这一说法是依照脏腑配合学说来定出左右手寸关尺部在脉诊上分属脏腑的部位。左寸小肠，指左寸浮部为阳为腑为小肠，沉分为阴为脏为心。右寸大肠，指右寸浮部为阳为腑为大肠，沉分为阴为脏为肺。此说为时已久。但经验证明，事实并不为然：左寸浮紧主头痛，浮数主头昏，目赤。左寸短也主头痛。中沉脉滑主咽喉肿痛，脉大主胸痛咳逆，吐脓血。脉虚主失眠，健忘，恍惚等。因此左寸中沉部主心是正确的。浮部各脉与小肠实无关连。而小肠痛疼时脉多出现於右关中沉二部，却与脾脏有关。至如右寸浮紧、浮弦主胸痛，浮数主口干喜饮；浮大主咳逆

胸痛；浮大鼓主胸胀；中沉滑主痰食积等。是右寸脉浮中沉部与肺胃中疾患有关，而浮部脉也与大肠无关。但在赤白痢疾，小腹坠痛，痛在下直肠时，其脉则右尺部出现大数脉象。迴盲部慢性隐痛时，左尺部则出现紧弦鼓缓等脉象。如此；则可证明所有寸部脉主胸：心肺，头，目，耳，齿中疾患。而小肠病其脉在右关中部。大肠病脉出左右二尺部中。所以说："左寸浮部不是小肠脉。右寸浮部不是大肠脉"。此点应根据事实予以纠正。

## 三、舌　诊

看舌分舌质、舌形、舌苔三项。同时注意其干燥与湿润与否，以察津液盈亏。舌质、舌形、舌苔以察气血偏盛，寒热表里脏腑营卫邪气之所在。综合脉证，辨证论治。

（一）舌质：

舌色：宜红润。若红而干，血热伤津；紫红而干，热邪将入营分；绛而干，热邪入血分；紫红湿润，寒湿之象；紫而润，寒湿瘀伤血分；淡红为虚。

部位：

舌左边青紫为寒伤脾。在右边青紫为寒伤肝。青紫在舌尖边，寒伤胸膈。在舌根寒伤下元。根上偏左，寒痛在左胁下，根上偏右，寒痛在迴盲肠间。

舌尖边有红色星点，谨防伏火内起。舌尖边红赤，心火内蕴。舌尖发黑，心阳受阻。

（二）舌形：

舌胖大有齿印，腹中瘀积寒水。舌中心有直沟一条，为中气虚。舌中心有拇指大一片凹陷，为胃虚之象。

舌面如水纹[illegible]缝，阴虚之体。干燥质[illegible]治须补阴。若苔灰或青，舌质微红而润，宜须温胃去寒

舌面或左右或根部，无苔光[illegible]如羊腰子色，属脏腑之气因寒而滞，依出现部位，药治相[illegible]脏腑。

（三）舌苔：

宜淡白，中厚，边薄。苔[illegible]高在舌中心，为胃中积食。干燥为热，润为寒。厚腻在舌根部为寒滞下焦。在舌左边，食积在脾，治宜温脾化滞。在舌右边，食积在肝，温肝化滞。

舌边左或右一边苔厚，一边无苔，先治苔厚一边。若一边苔薄，一边无苔，当补无苔一边脏腑。全舌面无苔，乃胃肠之气不升，中寒之象。

苔底厚，表有黄色，外感未尽，胆热将起。底厚表色白燥，胃热之象。舌苔厚腻，色黑生长毛，大寒之象。色黑面燥，摸之刺手，大热之象。苔灰在中寒湿在胃。苔青在舌之中下，胃肠俱病。苔黄而腻，湿热内蕴。苔黄而燥，胃肠热结。

# 正本清源

## 一、疾病规律

众所周知，人类文化知识，大多是在前人已有基础上继承，发扬、发展的过程中积累的。医学是中国传统文化的一部分，其过程也不例外。从历代中医先贤的积累中，包括内难二经，伤寒，时病，温病，传染病等著作，人们不难看出疾病的发生，发展，传变、转归、痊愈等，都有其一定规律。依照疾病变化规律，人们找出了各个阶段应当采取的所有恰当的处理方法来治疗疾病，解除痛苦、保护健康。

其总的规律大致如下：

“阴胜则阳病，阳胜则阴病。阳胜则热，阴胜则寒。”（《内经·素问·阴阳应象大论》）

“是故气之所并为血虚，血之所并为气虚……，故气并则无血，血并则无气”。“阳虚则外寒，阴虚则内热”。（《内经·素问·调经论》）

“阳明虚则寒慄鼓颔也；巨阳虚则腰背头项痛。”……阳胜则外热，阴虚则内热。“卫气者，昼日行于阳，夜行于阴”。（《内经·素问·疟论》）

“故物生谓之化，物极谓之变，阴阳不测谓之神，神用无方谓之圣”。（《内经·素问·天元纪大论》）

“夫物之生，从于化，物之极，由于变，变化之相薄，成

败之所由也”。（《内经·素问·六微旨大论》）

“邪之所凑，其气必虚，阴虚者阳必凑之。……诸有水气者，微肿先见于目下也。……诸水病者，故不得卧，卧则惊，惊则咳甚也”。（《内经·素问·评热病论》）

“百病之始生也，必先于皮毛，客于络脉，络脉满，则注于经脉、经脉满则入舍于腑脏也”。（《内经·素问·经络论》）

“邪气盛则实，精气夺则虚”。九窍不利，肠胃之所生也。治之要极，无失色脉，用之不惑，治之大则。（《内经·素问·太阴阳明论》）

“治病必求于本。阳化气，阴成形。寒极生热，热极生寒；寒气生浊，热气生清；清气在下则生飧泄，浊气在上，则生膜胀”。（《内经·素问·阴阳应象大论》）

“形不足者，温之以气，精不足者，补之以味。……阳病治阴，阴病治阳，定其气血，各守其乡。血实宜决之，血虚宜掣引之”。（《内经·素问·阴阳应象大论》）

“四肢者，阳也”……营气虚则不仁，卫气虚则不用……“胃不和则卧不安”。（《内经·素问·逆调论》）

“五脏六腑皆令人咳，非独肺也。……人与天地相参，故五脏各以治时。感于寒则受病，微则为咳，甚则为泄、为痛。乘秋则肺先受邪，乘春则先受之”……（《内经·素问·咳论》）

“少阴者，冬脉也。故其本在肾，其末在肺，皆积水也，……肾者，胃之关也，关门不利，故聚水而从其类也。上下溢于皮肤，故为跗肿。跗肿者，聚水而病也”。（《内经·素问·水热穴论》）

"任脉为病，男子内结七疝，女子带下瘕聚"。（《内经·素问·骨空论》）

"见其色，知其病，命曰明。按其脉，知其病，命曰神。问其病，知其处，命曰工"。（《内经·灵枢·邪气脏腑病形篇》）

伤寒病，太阳病不解，邪热传腑，膀胱蓄血。传少阳经，病口苦耳鸣，耳聋，胁痛，寒热往来。传肝入血，妇女热入血室，谵妄。传肺则咳喘。传阳明经，多汗、脉洪、大渴引饮。传胃腑，大便干结，腹胀，传脾为除中，多食善饮，（消渴病）误治热邪入胁下与水饮相结，为十枣汤证。入胸膈为诸陷胸汤证等等。

荆防病，延误不解，传少阳经（症状与伤寒同），传阳明经为白虎汤证。传肝则妇女经血妄行，流产，白带等。传脾则肠风泄泻，或脾热滞留，多食，多饮，多便的消渴病发生。传胃为各种类型胃病。传肺咳喘病生。出皮肤风疹、疮、疡、疖病发生。

温病，其病性质不同，传脾与湿相结为湿温等。传入血分，必发斑疹。入胸膈则为神昏脑病。

湿病，湿在三焦为诸肿病；传脾与风寒湿相结为诸风寒湿关节病；与肝血结合为妇女赤白带下，羊水过多，子肿等；与胃寒相结下肢膝关节肿痛，或胃酸过多等；与肝相结为黄疸病，热为阳黄，寒为阴黄；湿热结于脾，或泻利，或多食多饮消渴病生；结于肺则痰喘病生；寒湿上头为寒湿头痛；上胸则心阳式微，胸膈肿满，或下肢浮肿；与风相结于表为风湿病；与寒相结则妇女经迟，色黑痛经，不育面生蝴蝶斑等。

依上所述可以得出以下几种认识：

太阳病解而未尽，无论伤寒、伤风、邪热必从少阳经兴起，与肝胆相联，为诸肝胆病。或从阳明经兴起与脾胃气分之热相联为消渴病（糖尿病）

传入少阳肝胆，与血相联发为蓄血，热入血室见：谵妄、狂躁、斑疹、妇女月经不调，崩、漏、带下、流产、疮疹等。

与湿相结，症出黄疸，带下，肿满等。传阳明入肠胃，症发胃痛。泻利。与湿相结，传四肢，病诸关节痛症。（分寒湿风湿）

总此，可以得出：肝胆病，消渴病，斑疹，疮疡，妇女月经不调，崩漏，带下，泻利，肿满，关节病等等概属续发病之例。如欲彻底治疗此种病症，得从原发病下手，原发病不去，续发病不已，因病根存在，舍本逐末，治标不治本，急功近利，劳民伤财，贻害病家，有违经旨，也违犯了人体自然功能。本正源自清，本末倒置，更违事理，为自然科学工作者所不取。事理本身也不接受——行不通。

张仲景说："医者要见病知源"。（《伤寒论·序言》）孔子说："物有本末，事有终始，知所先后，则近道矣"。

例如：

高血压病。在于一般疾病过程中，多见血压升高现象，病好高压即退，此处所说高血压病。是指身体无痛痒、饮食起居正常，惟独头昏晕。量之血压积数不与其年龄相符的一种病症。如误治失治，易导致脑血意外病。

一般治疗，见病治病，用降压药，药到病除，药止病起，天长日久，心脏又会发生病变，而成心脏病，究其实质，血压高张，其原因多种多样。外感病在身，血压也会升高。但老年人体质抗力不足，虽外感却不自知，只感疲乏困倦，不

以为意，会忽略失治，医生脉之才能发现，以外感法治之，高血压病即愈。还有气虚血升，（阴病治阳）肾虚血升，（阳病治阴）肝阳上亢，（滋阴潜阳）又有滥用滋补，血压升高者等等。依脉证治之多效。

消渴病。一般治法，对症用药，滋阴生津，补气补液，降阳生津，或控制饮食，增补胰岛素等。药到病轻，难于根治，消渴病是邪热所引起的脾胃脏腑气化功能不调症。治病求因，治病求本。先治外感未了病症，和其他杂病，再调脏腑，消渴病多自行痊愈。

心脏病。（功能性）心悸，心慌，头晕，肿，脉结、代等。心脏跳动不正常，都有它内在根源，找出根源也易痊愈。（请参看本书医案摘录）

所有这些认病治病方法，都是千百年来中国古圣先贤遗留给后代人的医学瑰宝。我们应当很好珍惜利用，为大众解除疾苦。真正作到："见色知病，问病知处，按脉知病。""见病知源"之地步，方显中医本色。

## 二、肝胆病与治法

肝藏血，主疏泄。和心肺脾肾有着密切联系：肝木与脾土要常处于平衡状态之中；乙癸同源，肝之条达依靠肾水的涵养；心主血，肝藏血，心为五脏之主，而肝木为相；肺金以平肝木之亢。

现代医学认为：肝脏是人体最大的器官，有解毒、抗病等生理功能。研究证明，"肝"与神经系统、消化系统、生殖系统、循环系统、免疫系统等息息相关。故有："肝为将军之

官”之称，所以在论病时常摆脱不了它的干系。胆附於肝上。一腑一脏，互相照应。胆服务於肝为肝排毒。如：遇外邪或内邪侵扰，肝胆的排毒作用不能正常运作时，不是肝生病，就是胆腑排毒受阻。胆汁瘀积日久，便为黄疸，渣质沉淀，成为结石等。这在诸多病例中经常会遇到。如：患外感病，脾胃病，关节病等。有的人常服用镇痛、解热、镇痉、平肝等药，求取眼前效果。未作根本治疗，免疫功能一般又都不太好，毒邪瘀积肝胆，肝胆病症突现。医者见症治症，舍本逐末，惟肝胆病是务。结果肝火愈平愈旺，它病又纠缠不清，疑难杂症，从此以生。

肝胆火邪为何愈平愈旺？因为肝胆火邪因毒质存在而发生，排毒抗病是肝胆的本能。医者应帮助肝胆驱除毒邪之来源，勿使肝胆受累。若反用芩、连、栀、柏压抑肝胆功能，扬汤止沸，不知釜底抽薪，薪不去，汤沸不止，非徒无益，时日稍长，肝胆原有功能将破坏殆尽。

肝胆有其自生疾病，但大多数是其它疾病所引发。如：桂枝证不解，可转为柴胡证，（胆热）一般感冒、食积、停水、胃痛等多伴有口苦，耳鸣、寒热往来、胁痛等症。人们却常把注意力集中在肝胆上。于是抑肝平肝，消炎退火等。好象肝胆不务正业，有意生事似的。肝胆的罪过太大了。如果把这种治法叫治标应急措施，抑止病势，减轻痛苦的话，情有可原。常此抑制，肝何以堪？竭泽而渔。不成贫血，就有癌变萌生。此非病变，而是人祸。故有“脏腑无语，冤魂夜嚎。”之悲叹。它如：肝阳上亢，是水不涵木，根在肾水。血瘀生火，要在逐瘀以生新，平肝胆火是无辜的。

中医认病是整体观。人体本是有机的完整体，各系统互

相制约、支持、协作、构成良性循环，生生不已。一旦生病，除表现出各种特有症状外，脉象表现更为真切、实在、明朗。诊病时结合其他三诊，不难找出病源，治标治本，极易求得。扶助各脏腑原有功能，因势利导，解除疾病，这是最上乘作法。尤其对肝胆病更应着眼治本，最低也要标本兼治，绝不能损伤肝胆，（但不能排除手术）破坏人体正常防卫与造血功能。

人体被病邪侵扰，医者要着手成“春”，这“春”字便指肝胆功能而言。肝属东方为木，胆为少阳，一阳初生於东方，万物开始萌生，是春的象征。数千年前中国医学家已将肝胆功能与人体疾病关系探究清楚，方向非常明确。医学发展至今天，前人的经验积累与现代生理病理仍相吻合，惟独治法上极应切实继承发扬这一传统医疗方法，造福人类。这是当今中医工作者应该大声疾呼积极努力的一个重要方面。

## 三、癌

癌是人类大患。到目前为止，全世界医学工作者尚未能攻克。至其成因，当代研究结果是癌细胞作祟。那么癌细胞又从何产生？国际医学界认为：会得癌的人，是因为他体内的免疫细胞懒惰起来，疏忽了一些微小变化，才让癌细胞作大，这时想消灭它，为时已迟。澳大利亚伯涅特说：“癌症是免疫抵抗力的不起作用”。美国医学家鲍林说：“刺激免疫体系，可对恶性肿瘤建立一种生化障碍。”

医学对癌症的治疗，已确认热可杀死癌细胞。但当患者在未得癌前，某部（或内或外）有肿痛炎症发生时，一般往

往用治标办法，消炎平热，抑制人体抗病能力。难免不孕育癌细胞的潜在生长。这恐怕也是癌病增多的原因之一。

癌病一般不易被早期发现，及至发现，癌已形成，为期已晚，成为杂病发展的最后阶段。因此，癌病患者大多数形体消瘦，元气大溃。反之，如患疾病的人在他体气壮实，抗病能力强大时，患处必致红肿疼痛，或成脓溃疡，而后一散了之，癌细胞又怎能滋生？

根据个人多年临床观察有如下例症：

1、一养牛工人，不慎被牛蹄伤及后背，服止痛消炎药长时间未效。继则不嗜食，食则吐，后查为食道癌。

2、某干部因其子犯罪被判刑，气愤忧郁，胸胀不能食，食则噎。后查为食道癌。

3、一12岁男孩，从高处跳下，伤及左腿，膝下内侧痛肿。某医用活血散瘀药，数月不效，后肿及膝上小腿，后查为癌。

4、一民警患肝炎，某医用知、柏、芩、连、龙胆草、板兰根等，患者急剧消瘦，腹水成患，查为肝癌。

5、一老年干部感冒时左颈项耳后下方肿痛，注射青霉素等，感冒病愈，肿痛转发为硬块。隐痛数月后，复发烧疼痛，后查为癌。

6、一老妇左颧骨间疼痛，服用镇痛药针不效。后服苍术、细辛、白芷、藁本、菊花等中药痛止。约二年后，痛又大作，入院治疗，痛不止，颧骨反高起，后查为癌。

7、一老妇女，平时白带多。曾用中西药未效。后带中夹血时下，经查为宫颈癌。

8、一胃溃疡患者，杂用中西药治疗经年未效，后查为癌。

9、一老妇月经复潮，久治不愈。后查为子宫癌。

10、一老妇颔下右侧近气管处生一疙瘩，不红、不肿、不硬，平时不痛不痒。如遇感冒食积胃不舒时，便肿痛发作。用和胃治感冒药后，新病解除。旧病疙瘩又恢复原状。数年后，一医误用泻药，疙瘩日渐增大肿痛如拳大，经查为癌。

从上诸例中，可以看出癌细胞的产生，有其一定根源。如果说人体某处生病或有疮痛不愈，治不得当，病灶存在，癌细胞便是旧病灶的产物。

1989年3月24日《文摘周报》转载香港《明报》报道：为了探明癌细胞自生自灭的规律。医学家们搜集了各种癌症自发消退的病史后发现：

（一）自发消退者中，以青年或儿童居多。

（二）往往有发高烧的病史。常在某次发高烧之后，癌症原发灶“不翼而飞”了。其中尤以丹毒、结核、和肺炎最为突出。

（三）有些病人在患过一次病毒性疾病之后，癌症缓解或消失了。1893年，法国一次流感过后，有的白血病人发生了自发性缓解。1912年，意大利一位妇女被狂犬咬伤，在接种狂犬病疫苗后，她的子宫颈癌反而痊愈了。

这些现象告诉人们：只要设法把自体内的免疫系统激发起来，病人就会产生抗御癌症的强大力量。

不难看出，其它病在姑息治疗，或抗病功能被损害后，有可能转变为癌病。但癌病也可因它病痊愈而缓解或消失。有它病当其体质强壮，抗病功能强大者，可以不生癌病，癌病者多数元气已损，缺少抗病能力，任癌作大。

在治法上，目前有研究直接杀死癌细胞或抑制其生长能

力的；有用增强免疫系统功能以消灭癌细胞的；有用局部理疗化疗的；有研究接种疫苗的；有用发热疗法的等。当然不排除手术治疗。以上都是对癌证已形成的系统治疗方法。

曾治一食道癌和一胃癌而痊愈（病案详医案摘录）。又治一妇人咽喉间生一小疙瘩，色青紫痛，某医院诊为癌，曾用和胃疏经药亦痊愈。例证虽不见多，但可一隅三反。要之医者在治病过程中尤其对迁延不愈病患，更防变癌可能。必须以治人治命为主，辅助病体利用其本身抗病功能来解决病患，防癌於未然，是为上策。若利用人体高烧抗病功能，使癌转为它病而解，也是方法之一，不过其中有一定风险，尚须慎省，却不能冒然从事。癌是人类大患，如果人们一旦找出了癌病变化规律，采取种种适当措施，这一大祸患，最终将会被消除的。

# 妇科辑要

妇女在生理上有月经、胎孕、生产、哺乳等不同於男子之处。因而，其脏腑经络气血的运行活动有其特殊的规律性。在病理反应上也就与男子有别。治疗上自然产生特殊方法，这便是妇科学。

古说："人体以脏腑经络为本、以气血为用，脏腑是生化气血之源。经络是运行气血的通路。"女子胞宫（子宫）是行经和孕育胎儿的器官。气血是月经、养胎、哺乳的物质基础。胞宫除与脏腑十二经脉互相连系外，与冲脉、任脉、督脉、带脉更为密切，尤以冲任为甚。胞宫作用是受冲任二脉影响的。冲任均起胞中，冲为血海，任主胞胎。冲脉为十二经气血汇聚之所，是全身气血运行的要冲。故《灵枢·海论》称它为"十二经之海"。"血海"。任脉主一身之阴。凡精、血、液都属任脉总司，为人体任养之本。任脉之气通，冲脉之血盛，下达胞宫，故月事以时下。但月经要保持正常又与督脉、带脉有密切关系。

督脉与任脉同出会阴：一行身后而主阳，一行身前而主阴。二脉至唇口而会於龈交穴，循环往复，维持着阴阳脉气的平衡。从而也保持了月经的正常来潮和经量，以及促进受孕的作用。

带脉匝腰一周，约束全身经脉。故冲、任、督三脉都要受带脉的约束，方能维持它们的正常功能。

子宫生理既与各经脉密切相连，治疗子宫病就不能抛弃各经脉而不顾。但历代医家对妇科病治疗方法上往往多侧重

于调理脏腑，对疏理经脉，间或顾及，却不够重视。然而在妇科临床中经脉病与子宫月经等病却经常并存。病者在症状上多数突出血分病，对其它证候，医病二者，多易忽略，只以突出血分病为治。结果遂愈遂犯难于根除。若在诊断时如重视脉象，就不难发现血分病与经脉病并存关系。依证候，分标本。先调经脉、气分，而后调理血分，则血病多迎刃而解，且不再犯。因此，对妇科病之调经，应从广义角度看待。为欲调理月经，先须调理经脉，二者不容偏废。更应调理好脾胃，所谓先气而后血，是符合“气行则血行”的自然规律的。现将具体证候，分列如下：

月经超前：

一、血热妄行型：

当归 10g、炒杭芍 10g　生地 10g　丹皮 6g　白术 10g　焦山栀 6g　生甘草 3g

二、肝郁气滞型：

当归 10g　炒杭芍 10g　白术 10g　柴胡 4g　薄荷 3g　生甘草 3g

三、气虚血弱型：

党参 10g　白术 10g　茯苓 10g　当归 10g　川芎 10g　九地 10g　山萸肉 6g　菟丝子 10g　甘草 3g

四、邪热扰血型：

党参 10g　白术 10g　茯苓 10g　半夏 6g　当归 10g　炒杭芍 10g　川断 10g　菟丝子 10g　防风 10g　荆芥 6g　羌活 10g　柴胡 3g　甘草 3g

注：如属桂枝脉去荆防羌加桂枝。上列各症中如：血色正赤，量多，加血馀炭、阿胶、炒蒲黄、仙鹤草等。

经来小腹痛加：炙小香。经色有黄：加：黄芩、柴胡。淋漓不断加：山萸肉、煅龙牡等。脾胃有寒加：干姜、砂仁。

月经衍期：

（一）气血不足型：

十全大补汤。加：山萸肉、枸杞子、巴戟天、鹿角胶等。

（二）寒凝血迟型：

大温经汤。有桂枝、吴茱萸脉时方可施用。如无上脉，而量少色黑有块等，可用归芍六君子汤。加：肉桂、炮姜、厚朴、木香、红花等。

月经前后不定期：

（一）脾气虚寒型：量少色淡或如咖啡色。

党参 20g　白术 15g　山药 15g　茯苓 10g　煨肉蔻 10g　补骨脂 10g　炮姜 10g　当归 10g　川芎 6g　炒杭芍 10g 炙甘草 3g

（二）气血不和型：

八珍汤。依脉象加入相应药物。

倒经：

党参 10g　白术 10g　茯苓 10g　麦冬 10g　当归 10g　赤芍 10g　益母草 10g　紫苏 6g　甘草 3g

婚久不孕：

身体虚弱：服补气血药。

月经不调：按上法调经。

有其它杂病：先治杂病，后再调经。

宫冷不孕：暖宫丸。桂附八味丸。

肝肾虚寒：右归饮。加：巴戟天、菟丝子等。待体壮经

顺后，服二益丸一至二盒，不久即孕。如属男性病，并治男方。

附：男性不育病：

体气虚弱：服补气血药。

精关不固：（遗、滑、早泄）桂枝龙骨牡蛎汤。加：菟丝子、川断、山萸肉、桑螵蛸。但须有桂枝脉方可施用。

阳萎：

补中益气汤。去升柴加：菟丝子、山药、肉桂、炙附子、山萸肉等。其中炙黄芪用量宜加大。鹿茸亦可加入。

上三症中如有杂病者，先治杂病，而后治本病。

带下：

（一）风血相搏：带有赤黄。

当归 10g、赤芍 10g　白术 10g　茯苓 10g　地榆炭 10g　荆芥 5g　防风 10g　柴胡 5g　菟丝子 10g　生甘草 3g　黄芩 6g

（二）血热：

当归 10g　赤归 10g　白术 10g　茯苓 10g　茜草 6g　乌贼骨 10g　菟丝子 10g　生甘草 3g

（三）脾气虚寒：

完带汤。理中汤等。

流产：

气血双虚，根蒂不固。

炙黄芪 30g　党参 20g　白术 10g　山药 15g　茯苓 10g　当归 10g　炒杭芍 10g　菟丝子 10g　山萸肉 10g　川断 10g　焦杜仲 10g　炙甘草 3g

有其它疾患时，依脉加入相应药物。

恶阻：

归芍六君子汤。去半夏加入脉证相应药物。

产后：

（一）小腹痛：（儿枕痛）生化汤。

（二）汗多，大便难：

不能当疾病看待。因血虚所致，俟后体气恢复血旺后，其症自消。

（三）产后感冒：

六君子汤。加：当归、川芎。再加脉症相应药物。

（四）体虚久不复元。

党参 10g　白术 10g　茯苓 10g　半夏 6g　当归 10g
川芎 10g　炮姜 10g　神曲 10g　炙甘草 3g

乳疾：

（一）乳少或无乳：

炙黄芪 30g　党参 20g　白术 15g　茯苓 10g　紫苏 6g
干姜 10g　砂仁 10g　当归 20g　麦冬 10g　王不留行
10g 炙山甲 10g　炙甘草 3g

如有其它疾病，依脉象加入相应药物。

（二）哺间乳自流：

补中益气汤。去升柴重用炙黄芪、当归用量。

（三）乳痈：

仙方活命饮。

如红肿痛加清热解药物，如蒲公英、银花、瓜蒌、连翘、芩、连等。

（四）乳岩：（乳腺癌）

十全大补汤。加：白蒺藜。

再依脉证加入相应药物，需要时加鹿角霜，或鹿角胶。

按：妇科病多因它病影响及血分。如：外感或内伤势必发烧（潜性或显性）发烧则血动，血动则经乱，赶前错后，淋漓不止，赤白带下，痛经，流产等病出现。治先调气（气分）、舒经络。而后再理血收带，病当迎刃而解。

## 方剂评述

方剂之能有实践效果，大多基於正确的理论指导，正确理论的产生，源於对人体生理的、病理的、自然规律的正确认识。数千年来，中医方剂浩如烟海。其间世代相传应用最广者：补气：四、六君子汤，补血：四物汤。此二方药物不多，力量精专，目的明确，效价特高。二方作用，符合气血的生理功能，有促进人体气血生成作用。如：四君子汤对促进肠胃功能面面俱到，完全符合脾胃生理规律。（上二方分析详情参阅本书《内伤篇》地黄脉与白术脉条下）。地黄丸符合肾之生理规律；补中益气汤升提气血；生脉散强心肺补津液等等。大都与生理自然功能相适应，历千古而不变，为各代医家所用。

在纠正病理方面方剂如：四逆汤之追卫阳；白虎汤之平气热；犀角地黄汤之凉血解毒；清瘟解毒饮之清气凉血救阴解毒；小柴胡汤扶胃抑胆；都能适应病理机制以祛邪。

用药目的在於纠正病理。使用法则，要切合病情。方药组合要药药对症。单味独进，或复方合用，分进合击，共成其治疗作用。所谓有法有方，方是形式，法是精神。方中所

有药物，其作用集中於一个目的，这是方剂精神所在。如果方剂中失去精神，那便是药物的堆砌，有方而无法也。

法可随病势以变通，方剂可随证加减。加减变通，症候是一个方面，病体自然的脉象反映亦是很重要的一个方面。经验实践证明，依脉象症候给药组方，所得方剂，大多是有血肉、有神灵的奇妙方剂。

# 医案摘录

医者之於疾病首先要尊重客观，扬弃主观。依照病人体征，症候、脉象、病史等客观表现辨证施治。或祛病，或健身，或寓健身於祛病之中，或寓祛病於健身之中，互相联系，求取治疗目的。在处理疾病过程中还要尽量为病者消除隐患于无形。但急则治标，又是对特殊病情的特殊处理办法。一般情况下，医者掌握已知生理病理规律，因势利导。帮助人体自然疗能，促进病痛及早解除，法简而效速。对辨证论治，须充分运用四诊，深刻注意切诊，这对复杂病候，也较容易解决。原因是病人脉象对疾病反映是自然的、真实的、具体的，而症候表现往往却夹杂着好多假象，尤其在阴阳胜负，五行生克方面，常有真假互见，寒热并存现象。需去伪存真，经验证明，切脉一项，最为紧要。这种透过症候等表面现象，以切脉知内在根源的诊疗方法，实践证明有效，爰摘录医案若干则列后，以资参证。

**泻痢：**

**病例一：**

骆＊＊，男，50岁，农人。自述头身痛、发烧、腹痛、下痢赤白、（赤多）里急后重，一、二小时利下一次，昼夜无间，已二日。初诊：患者疲困乏力、面容愁苦、色苍白、舌红、苔黄、脉右浮大，微数、左浮大并兼桂枝脉。论治：头身痛发烧，证属外感。痢下赤白、腹痛、后重、为湿热内迫。今内外两伤，邪热沸腾。当以两解为宜。

处方：桂枝 10g　炒杭芍 20g　当归 10g　柴胡 10g　黄芩

10g　地榆炭 10g　椿根皮 6g　干姜 10g　木香 3g　枳壳 6g　生甘草 3g　二剂。

次诊：

头身痛烧均退，痢次减，腹痛里急未退。脉右仍数大，左变沉数。治再直清大肠湿热。

处方：当归 30g　炒杭芍 40g　白术 10g　黄连 6g　黄芩 10g　地榆炭 10g　滑石粉 10g　干姜 10g　生甘草 3g　二剂。痊愈。

**病例二：**

林＊＊，男，40 岁，工人，头身痛、高热、腹痛、痢下赤白、里急后重、口干。经诊：右有防风脉，左有羌活荆芥脉，舌质红，苔白。证属外感内伤。治宜两解。

处方：当归 15g　炒杭芍 20g　白术 10g　生姜 10g　羌活 10g　防风 10g　荆芥 6g　地榆炭 10g　黄芩 10g　木香 3g　枳壳 6g　生甘草 3g　秦皮 6g　二剂。

次诊：

痛止烧退红痢减，腹仍痛。脉左关沉弦微数，右关有干姜脉。证为肝脾不调，寒热互争。治再理肝脾清大肠。

处方：当归 15g　炒杭芍 15g　白术 10g　干姜 10g　黄芩 10g　地榆炭 10g　椿根皮 10g　木香 3g　生甘草 3g　二剂。愈。

**病例三：**

秦＊＊，女，52 岁，家庭妇女。腹痛，每日大便数次，量少，有粘白冻物。鼻干，眼涩难受，已二年余。经诊：体尚健，脉右有干姜、防风、白术、黄芪脉，左缓细。舌质淡红，苔青。咽喉周缘发青。饮食量好，但不能吃蔬菜。证属气虚

脾寒，湿气下注。治当温脾益气收湿。

处方：炙黄芪 20g　党参 15g　白术 20g　山药 15g　茯苓 10g　干姜 10g　细辛 3g　炙附子 6g　陈皮 6g　半夏 6g　椿根皮 6g　补骨脂 10g　煨肉蔻 10g　防风 10g　大枣三个　三剂。痛利止。鼻涕出。痊愈。

**病例四：**

马小孩，男，二岁余。大便稀水。经服某医药后，泻水稍止，变为腹臌。肛门洞开如竹筒，时出浊便，日夜嚎哭，乳食不要。转来就诊。脉右有防风脉，左关微大。舌质微青，苔黄厚腻。按腹壁如硬板，便如鸡屎，时时自流，黄绿色便。病属伤食外感，急于止泻，变出土症。用痛泻要方，疏肝理脾。

处方：炒杭芍 10g　白术 10g　茯苓 10g　防风 10g　柴胡 5g　藿香 5g　砂仁 10g　陈皮 6g　炙甘草 3g　一剂。嘱服二日。

次诊：

腹软，肛敛，泻止，困睡食少，舌苔仍腻。治再健脾消食。处以六君子汤，加砂仁、焦三仙。二剂愈。

**病例五：**

张小孩，男，4 岁。大便稀泻，右耳流脓，喜哭，已两月余。经诊：脉右有防风干姜脉，左有荆芥脉，左关微大。证属肝脾不调，风热未解，邪火郁于肝经，下迫外出致便泻耳脓。治当理肝脾，升阳散火。

处方：白术 10g　炒杭芍 10g　干姜 10g　陈皮 6g　半夏 6g　茯苓 10g　防风 10g　荆芥炭 6g　升麻 3g　椿根皮 6g 贯众炭 10g　木香 3g　枳壳 6g　紫苏 3g　炙甘草 3g　二剂。共服四日。痊愈。

**浮肿：**

**病例一：**

余＊＊，女，45岁，家庭妇女。面青黄浮肿，胸腹亦肿，不思饮食，小便少，大便正常，呼吸平稳，舌质微青，苔薄白，脉左右俱缓，左有桂枝脉。脉缓属湿，心阳不振，胃阳式微，运化失司，寒水上迫，治当温运中阳，导水下行。

处方：桂枝10g　白术10g　茯苓20g　砂仁10g　干姜10g　半夏6g　陈皮6g　炙甘草3g　加姜枣　三剂。痊愈。

**病例二：**

刘＊＊，男，38岁，教员。面目黑黄浮肿、目少神。自述：头晕、体困、食少、腰腿酸困无力。已三月余。切诊：左关有芍药脉，尺有地黄脉，右脉和缓。舌质嫩红，苔白。证脉相参，属肝肾阴虚阳亢，治当滋阴潜阳。

处方：九地20g　山萸肉10g　炒杭芍15g　枸杞子10g　山药20g　生龙骨15g　生牡蛎15g　珍珠母15g　石决明15g　北沙参10g　五剂后诸症退，精神好转，饮食增多。继用六味地黄丸以善其后。

**病例三：**

管＊＊，女，32岁，农人。头面四肢俱浮肿，足不能穿鞋，手不能握物，两乳房肿大如水罐。自述：产后十余日，感冒发烧，服用西药，痛烧退，全身渐肿，日渐沉重，不想吃饮。切诊：脉隐不显，沉取之，左右俱缓，右关硬。舌质微青，苔青灰。脉缓浮肿。为寒水充斥。急则治标。

处方：大腹皮15g　茯苓皮30g　生姜皮15g　陈皮10g　枳壳10g　苍术10g　砂仁10g　三剂。

次诊：

肿稍减，舌苔如前。切诊：右有大腹皮、白术脉，左有川芎、吴茱萸脉。辨证：产后血虚，生冷内伤，寒水弥漫，发为肿满。应标本兼顾。

处方：当归 10g　川芎 10g　吴茱萸 10g　茯苓 20g　大腹皮 15g　白术 10g　炮干姜 10g　砂仁 10g　藿香 6g　三剂。

三诊：

肿大减。自述：浑身不舒、腿硬行走不便、饮食知味。切诊：左关川芎、吴萸脉仍在，又有羌活脉，右关有白术脉。舌淡红，苔白。治再扶肝除湿：

处方：当归 10g　川芎 10g　吴茱萸 10g　茯苓 10g　白术 10g　炮干姜 10g　砂仁 10g　甘草 3g　三剂。

四诊：

肿全消、食饮增、面色萎黄、贫血可见。切诊：六脉俱虚。治当健脾扶肝以生血。

处方：六君子汤：加：炮干姜、当归、川芎五剂愈。

**病例四：**

马＊＊，女，25 岁，工人。自述：产后十天感冒，头身痛、发烧、口干、胸满、小腹攻痛。打针吃西药，痛烧减。现又手面浮肿，大腿肿硬不能挪动，不想吃。诊见患者：口唇干裂。舌红，苔厚腻黄。切诊：左虚数有羌活、荆芥脉，右有防风脉，证脉合参，外感未退，邪热不休，发为阳热浮肿。小腹攻痛，恶露未净。治当理血解表。

处方：当归 10g　川芎 10g　荆芥 6g　防风 10g　羌活 10g　桃仁 6g　红花 6g　益母草 10g　薄荷 5g　茯苓 10g　炙甘草 3g　二剂。

次诊：

肿痛去，恶露行，腿胯能坐卧，食尚少。切诊：六脉平静，舌嫩红，苔厚腻白。治再扶肝和胃。

处方：当归 10g　川芎 10g　白术 10g　茯苓 10g　神曲 10g　陈皮 6g　砂仁 10g　炙甘草 3g　三剂。愈。

**腰肢病：**

**病例一：**

孟＊＊，女，22 岁，护士。自述：左手腕关节肿硬疼痛，已两年余，百治不效。某医院诊断为类风湿病，腕关节骨膜增生。须手术治疗。病者疑惧。转来就诊：经察病者：身体健康，惟腕关节处浮肿，阳池穴部有蚕豆大一小疙瘩，按之微硬。自谓：经常痛疼，天亮时更痛。工作中不能提持重物。切诊：左有桂枝脉，右脉虚缓。论治：四肢属脾，脾主湿；今血分受寒，气分必起反应。腕部肿痛，显系湿流关节。气液壅滞太久，硬块以成。“邪之所凑，其气必虚”。治当强脾胃，祛寒邪，活经络，通气液，改善体液运行。

处方：桂枝 10g　党参 10g　白术 10g　茯苓 10g　丝瓜络 6g　络石藤 6g　松节 10g　忍冬藤 10g　草果仁 6g　干姜 10g　炙甘草 3g　五剂。

次诊：

肿痛减轻，硬块仍在。切诊：左有桂枝、芍药脉，右有防风脉。原方去草果仁，加芍药、防风各 10g。嘱服十剂。

三诊：

肿痛痊愈。硬块仍在。原方加白蒺藜 10g。嘱再服十五剂。

四诊：

硬块全消。左手亦能提持重物。痊愈。

病例二：

王＊＊，男，28岁，汽车司机。自述：腰痛四年多，原以为插队受潮而痛，不以为意。工作后虽经治疗，仍不见好。继后发现痛处有鸽卵大疙瘩一个。经某医院诊断为：腰椎骨质增生。转来治疗，见病者：春华正茂，体格健壮。切诊：左有桂枝、芍药、续断脉，右关寸低沉。舌质红，苔微白。饮食睡眠均好。只经常腰痛，劳累后更甚。依脉对症。腰痛原属肾阴不济所致，今桂枝脉尚存。肝阳亦不宁静，又加中气虚弱，难以支持全身。腰痛不已，日久殃及椎骨。治先散寒宁肝，壮气强腰。

处方：党参20g　白术10g　茯苓10g　桂枝15g　炒杭芍15g　续断10g　生龙骨15g　生牡蛎15g　乳香2g　陈皮6g　炙甘草3g　生姜三片　大枣三个　三剂。

次诊：

腰痛大减，劳动后仍痛。切诊：左桂枝等三脉不复再见，左尺转为地黄脉，右脉照旧。治当壮气滋肾。

处方：炙黄芪30g　党参15g　白术15g　山药15g　九地15g　茯苓10g　山萸肉10g　当归6g　炒杭芍10g　络石藤10g　乳香2g　大枣三个　五剂。

三诊：

劳动后腰痛明显减轻。腰椎间疙瘩虽变小但仍硬。切诊：左尺仍浮不沉，右脉同前。依原法。

处方：炙黄芪30g　党参15g　白术15g　山药20g　茯苓10g　山萸肉10g　当归6g　炒杭芍15g　络石藤10g　乳香2g　九地10g　骨碎补6g　大枣三个　十剂。

四诊：

劳动后间或腰痛。椎间疙瘩再度变小仍硬。切诊：左尺脉收敛，但未入骨，右关寸高起有力。治专强腰肾。

处方：九地 20g　山萸肉 10g　山药 20g　茯苓 10g　泽泻 10g　丹皮 6g　炒杭芍 15g　炙附子 10g　肉桂 10g　乳香 2g　络石藤 10g　骨碎补 6g　胡桃一个（连外壳打碎）十五剂。痊愈。

**病例三：**

杨＊＊，男，43 岁，工人。自述：原先感冒发烧，头身腰痛。经打针吃药，感冒痊愈。惟腰尚痛已十余日不解，俯仰困难。多方医治不效。经某医院诊断为椎间盘突出。施手术或卧平板床治疗。病者不同意。前来诊疗。病者体气壮实，面色红润，起坐以手插腰。切诊：右有防风脉，左有荆芥、续断脉。舌质红，苔白。病属汗出当风，肾阴受累。治当壮气驱风；缓和肝肾阴气。

处方：党参 10g　白术 10g　茯苓 10g　陈皮 6g　荆芥 6g　防风 10g　炒杭芍 10g　续断 10g　炙甘草 3g　加姜枣，三剂，痛止，未再复发。

**病例四：**

朱＊＊，男，32 岁，工人。自述：右胯及腰腿痛已一年余。医院诊断为坐骨神经痛。曾针灸，药物，仍不见好。诊见：病者体气尚好。切诊：左有桂枝、狗脊脉，右有茴香脉。饮食二便正常。脉证相参，下元虚寒，血分复受外寒侵袭，虚寒相结於腰胯经筋间，治当温下元，散寒邪。

处方：桂枝 15g　金狗脊 10g　威灵仙 10g　炙小香 10g　补骨脂 10g　山药 15g　山萸肉 10g　茯苓 10g　大云 10g　三剂。

次诊：

痛止，腿腰有酸困感。切诊：左有地黄脉，右尺虚弱。属肾虚证候。处以附桂八味丸三盒，以巩固疗效。

**病例五：**

郝＊＊，男，50岁，工人。自述：左胯连及大腿外侧痛，曾经针灸、按摩、蜡疗等。均未见效。转来诊治见病者体胖，走动左腿不灵。切诊：脉缓。右有防风、白术脉，左脉平缓。舌质青，边缘有齿印，苔青腻。病属内寒湿重，脾之经气不伸，筋脉为寒湿阻滞。治当理脾舒经，追逐寒湿。

处方：党参10g　白术15g　茯苓10g　陈皮6g　半夏6g　防风10g　干姜10g　炙附子10g　威灵仙6g　五加皮6g　藿香6g　炙甘草3g　五剂。

次诊：

痛止，行走方便，稍有困重感。切诊：右尺有菖香脉。舌淡红，苔青。气虚下寒。处以六君子汤。加：干姜10g　薏苡仁6g　炙小香10g　藿香6g　三剂。痊愈。

**病例六：**

白＊＊，男，45岁，农人。走路两手扶膝，躬腰慢步，上下台阶，困难度尤大。前来就诊。腰腿痛多年，因条件关系，没有很好治疗。现已不能劳动。经察：右腿痿细，左腿尚粗壮。切诊：左尺有山萸、狗脊脉。其它各脉也虚。舌质红，苔根厚腻。饮食睡眠正常。证系肾功能亏损，腰肢气血循环不良。治当温补肾气。

处方：九地15g　山萸肉15g　山药20g　茯苓10g　泽泻10g　丹皮6g　炙附子10g　肉桂10g　金狗脊10g　五剂。

次诊：

走路以手插腰，头前倾，左右摇摆。据谓：痛疼减轻，行动稍觉有力。切诊：左尺浮取微大，沉取则虚。舌苔同前。治依前法，原方加党参 15g　焦杜仲 15g。嘱服十剂。

三诊：

步行正常。自谓：腰肢有时发软。察看右腿仍瘦细如前。但皮肤色泽，和左腿一样。切诊：左尺阴阳脉仍虚。舌质红，苔根转白薄。治再壮肾气，调气血。

处方：炙黄芪 20g　党参 10g　山药 20g　九地 15g　山萸肉 10g　丹皮 6g　当归 10g　茯苓 10g　泽泻 10g　炙附子 10g　肉桂 10g　杜仲炭 10g　金狗脊 6g　嘱服十五剂。

半年后，时已入冬，白某挺胸入室，笑谓：药后能劳动，忙於秋收冬耕，故未再来。今因事来兰，特来致谢。察看其右腿，已粗壮如左。

**病例七：**

薛＊＊，男，62 岁，无业在家。双足肌肉呈晦黑色，黑印已上窜至足胫间，痛不能行动，卧床休息。痛者身体清瘦，饮食二便正常。切诊：右有党参、白术、茴香脉，右脉虚软。舌淡红苔青。论治：脾主四肢，下元虚寒，气血循行不畅，末稍血脉瘀滞。

处方：党参 10g　白术 10g　乌药 10g　炙小香 15g　天仙藤 10g　苏梗 6g　当归 10g　炒杭芍 6g　薏米仁 20g　砂仁 10g　炙甘草 3g　姜枣引　五剂。

次诊：

双足晦黑色退至足趾间，其他如归。原方又服五剂，愈。

**中风：**

**病例一：**

马氏，女，55岁，家庭妇女。家人谓昨晚睡时很好，天亮不语，也不起床。诊视：口眼㖞斜，面色黄暗，两眼左右看人，神志尚清，不愿饮食，舌质青，苔白薄。切诊：右脉寸关虚，左有桂枝脉。论治：年老气虚血弱，营分受寒。肺胃之气虚。阳明经气难行於面，颜面经脉失于濡养。太阴脏气匮乏，气虚不能语。治当壮气散寒，温通经络，疏利痰涎。

处方：桂枝15g　党参30g　陈皮6g　半夏6g　茯苓10g　天南星10g　白附子6g　白芷10g　远志6g　石菖蒲10g　干姜10g　炙甘草3g　生姜5g　大枣三个　二剂。

次诊：

口能言语，咬字时有不清，能饮食，口眼㖞斜无明显改善。切诊：右脉微起，桂枝脉尚在。依原法。

处方：桂枝10g　炙黄芪30g　党参20g　白术10g　陈皮6g　半夏6g　茯苓10g　干姜10g　远志6g　天南星6g　白附子6g　白芷10g　当归10g　菊花3g　炙甘草3g　生姜三片，大枣五个。五剂。

三诊：

能起坐饮食，精神亦好转，语言清亮。据病者谓：面部瘫痪一侧有刺痛感。切诊：右脉寸关虽起，中按仍无力，桂枝脉依稀尚存，嘱原方再服五剂。愈。

**病例二：**

周＊＊，男。43岁。农人。口眼㖞斜，仍照常劳动。自谓：头昏，说话、饮食，口不灵便。切诊：左有荆芥脉，关

部浮大，中有滑象。右有防风脉。舌红苔微白。证系轻度中风，肝气不宁。治用疏风平肝兼以活络。

处方：防风 10g　荆芥 10g　当归 10g　赤芍 10g　柴胡 6g　菊花 6g　陈皮 6g　天南星 6g　白芷 6g　白附子 6g　远志 6g　炙甘草 3g　三剂。

次诊：

说话微笑时口鼻现㖞斜状。切诊：左关尚微大，中取脉静上下均匀，防风荆芥脉不复再现。治再扶气平肝活络。

处方：党参 10g　白术 10g　茯苓 10g　陈皮 6g　半夏 6g　天南星 6g　白附子 6g　远志 6g　当归 10g　炒杭芍 10g　菊花 6g　柴胡 6g　白芷 6g　炙甘草 3g　加姜枣。三剂。愈。

**病例三：**

赵＊＊，男，48 岁，干部。自谓：左半身及下肢麻木少力，已半年多，曾多方治疗少效。前来就诊。病者身体一般。面色微黄，行动尚可。切诊：右有防风、党参、白术脉，左脉和缓。舌淡红，苔青。饮食量少。证属气虚中寒，复招外风，气血供应受制。治当壮气，疏风活络。

处方：炙黄芪 30g　党参 20g　白术 15g　茯苓 10g　防风 10g　干姜 10g　炙附子 10g　当归 10g　天麻 10g　鸡血藤 10g　甘草 3g　加姜枣。五剂。

次诊：

自谓：麻木时或出现，左半身有热感，似欲出汗状，切诊：右脉尚虚软无力，防风脉间或出现。治依前法。原处方加玉竹 10g。嘱服十剂，痊愈。

**病例四：**

马＊＊，63岁，农人，右半身瘫痪，不能行动，家人谓因买菜与人吵嘴，回家后即得此病。曾治疗一星期少效。切诊：右关微鼓，左尺细弱，左关沉取有涩象，浮取则大。面色暗紫，语言不清，神识知人。舌微青，苔白腻，证属肝肾虚损，根底不固，暴怒之下，肝阳上亢，内风为患。治当壮肝肾，潜肝阳。舒气活络。

处方：九地 15g　山萸肉 15g　山药 20g　茯苓 10g　炒杭芍 10g　生龙骨 15g　生牡蛎 15g　炙香附 10g　檀香 3g　砂仁 10g　金狗脊 10g　党参 10g　炙甘草 3g　加姜枣。三剂。

次诊：

语言时有一半句清楚。其他无变化。切诊：右脉虚软，左尺微大，左关稍平，中取涩脉依旧。治再壮肝肾补气血，兼以活络。

处方：炙黄芪 30g　党参 20g　白术 10g　山药 20g　九地 20g　山萸肉 15g　茯苓 10g　当归 15g　天麻 15g　金狗脊 10g　巴戟天 10g　枸杞子 10g　红花 3g　甘草 3g　加姜枣。五剂。

三诊：

语言稍清楚，能自行起卧。切诊：右脉微大少力，左尺阴阳脉能诊出，左关中取脉转细弱。治依前法。原方加川芎 6g　桃仁 6g　地龙 6g　十五剂。

四诊：

病者自扶拐杖，拖着右腿挪动，语言全部清楚。切诊：左尺脉稍有力，左关中取脉细，上下稍有力。原方再服十五剂。数月后其亲戚来谈：马某生活已能自理，现常扶杖外出，漫

步街头。

**胃病：**

**病例一：**

程＊＊，男，34岁，工人。自谓：胃痛一年余，时吐酸水，曾吐紫血块二次。经某医院诊断为“胃溃疡”。先后曾服用西药、中药而无效，遂携带已服用过中药方单前来就诊。其方有归芍六君子汤、香砂六君子汤、金铃子散、左金丸、补中益气汤等；有加用乌贼骨、瓦楞子、白芷、贝母、牡蛎、赭石等解酸止吐药物。服后平平，痛吐照常。病者面容消瘦，食饮少，舌微青，苔青腻。切诊：左有桂枝脉，右关虚弱乏力。论治：脾虚不喜食，胃寒不磨谷，加之胃络脉为寒所袭，水谷之气运行受阻，积腐日久，胃内膜溃疡。治当壮脾胃，疏经络，升降水谷之气，兼和气血。

处方：六君子汤。加：桂枝10g　乌贼骨10g　白芷6g　当归6g　红花3g　干姜10g　炙附子6g　三剂。

次诊：

痛吐减。切诊：桂枝脉尚在，右关微有起色。嘱原方再服五剂。

三诊：

痛吐止，面色转黄润，食欲稍增。切诊：桂枝脉尚在，右关阴阳脉缓和有力，改用归芍六君子汤。加：桂枝10g　砂仁10g　元胡3g。双调气血，温通经络，嘱服五剂。

四诊：

面色红润，饮食倍增，切诊：桂枝脉不复再见。处以补中益气丸三盒。以善其后。

**病例二：**

马＊＊，男，57岁，干部。自谓：胃痛经年，近经某医院检查，初步意见，“慢性胃炎”。有“胃癌”可能性。病者情绪紧张转来就诊。病者身体一般，面色苍黄，行动便捷。切诊：右有防风脉，关部脉弦，左关沉取有吴茱萸脉。舌质淡青，苔青。胃中脘深按之有硬块，高低不平，触之痛。证属脾胃虚寒，经气不伸，功能受制，又与足厥阴肝寒互相结滞，形成块硬，胶着胃脘，有癌变可能。治先除寒疏经。

处方：苍术10g　防风10g　藿香6g　吴茱萸10g　良姜10g　茯苓10g　陈皮6g　半夏6g　当归10g　党参10g　元胡3g　甘草3g　三剂。

次诊：

胃痛稍减，块硬触之仍痛。切诊：右关弦左关吴萸脉尚在。脉象，块硬，胃壁病变未改。治再和胃逐寒。

处方：苍术10g　藿香6g　元胡5g　白芷6g　当归10g　吴茱萸10g　良姜10g　砂仁10g　炒杭芍6g　红花3g　茯苓10g　炙甘草3g　三剂。

三诊：

硬块触之痛减，大小未改变。切诊：右关浮取转鼓，左关吴茱萸脉尚在。原方再加大腹皮10g，舒降胃中寒湿气。四剂。

四诊：

块硬照旧，触之不痛。切诊：右关浮软中弦，左关吴萸脉尚存。中取有紧脉一条。（肉桂脉）主此块硬物，恐属血痹死肌之类，治再除寒逐痹，宣散块结。

处方：当归10g　炒杭芍10g　炙香附6g　苍术10g　砂仁10g　良姜10g　吴茱萸6g　肉桂10g　元胡3g　莪

术 3g　茯苓 10g　红花 3g　陈皮 6g　甘草 3g　三剂。

五诊：

块大小未变，硬度稍减。切诊：左关中取肉桂脉尚在。《内经》："大瘕大聚，其可犯也，衰其大半而止"。改汤剂为散剂。嘱原方再取六剂，共为细末，每服 10g。早晚开水冲服。共服一月。愈。

**肝胆病：**

**病例一：**

李＊＊，男，48 岁，教员。肝炎（无黄疸型）已休息二年余。近由某中医治疗不效。改来就诊：体困乏力、肝区隐痛，食少腹胀，头昏，口干苦，夜不成眠，白天也无睡，面容黄滞，肢体清瘦，舌暗红，苔白厚腻。检看所服药方，有丹栀逍遥散、龙胆泻肝汤、大柴胡汤加黄连、板兰根等。据谓服上药后，只觉头目清爽一时，其他正常。切诊：左有桂枝、芍药脉，右有防风脉。论治：痛在肝区，口干苦。头昏，属肝胆病。肝藏魂，夜不能眠，肝阴已伤。体困乏食少，腹胀苔腻，肝木克上脾胃功能减弱。前医用丹栀等原着眼於"炎"字。迁延时日，病未消除。今察脉象，病之根源在经络，不在脏腑。有如太阳伤寒桂枝证可转为少阳证等，脾之经气不伸，肝气必致横逆。经病逆转，可以殃及脏腑；脏腑病顺转，可由脏及腑出经络而痊愈。古谓："肝为将军之官"。无论内伤外感，病邪一经入侵，肝胆之气即张。治若不清除病邪，反妄平肝胆，则徒伤正气。故以祛邪柔肝为主。

处方：桂枝 10g　防风 10g　炒杭芍 10g　柴胡 6g　党参 10g　白术 10g　干姜 6g　砂仁 10g　茯苓 10g　陈皮 6g

炙甘草 3g　加姜枣　三剂。

次诊：

自述：药后肢体头目稍感轻快，腹中响、口干减，苦尚在，其它如常。切诊：左关转微平，桂防二脉尚在。嘱原方再服三剂。

三诊：

夜能成眠，白天能睡一小时许。口不苦，腹不胀，食饮稍增，困乏轻，惟肝区隐痛尚在。切诊：桂防二脉消失；左关中取微紧。

处方：归芍六君子汤。加：肉桂 10g　煨肉蔻 10g　五剂。以温养肝脾。愈。

**病例二：**

孙＊＊，女，52 岁，工人。自述：因病休息二年多，经常食少，体困，右胁下痛。医院诊断为"早期肝硬化"。诊见：病者面容黄浮，头发半白。切诊：右关稍鼓，左有肉桂、丁香脉。舌质微暗紫，苔青厚。依脉察证，肝胃俱寒。治先暖肝和胃。

处方：苍术 10g　砂仁 10g　陈皮 6g　茯苓 10g　肉桂 10g　当归 10g　公丁香 3g　元胡 3g　苏梗 6g　炙甘草 3g　三剂。

次诊：

药后右胁下发响，时或痛，饮食知味，量少。切诊：右关仍鼓，左关稍大，中有紧脉，沉取无力。舌苔仍厚。治再温肝和胃。

处方：当归 10g　炒杭芍 10g　砂仁 10g　肉桂 10g　公丁香 3g　茯苓 10g　苍术 10g　陈皮 6g　元胡 6g　炒麦芽

10g　炙甘草 3g　三剂。

三诊：

食饮稍增，体困，右胁下胀闷不适。切诊：右关脉软，左关浮大，浮中沉均无力。舌淡红，苔白厚。治依前法。

处方：当归 15g　炒杭芍 10g　五味子 6g　枸杞子 10g　砂仁 10g　肉桂 10g　公丁香 3g　白术 10g　茯苓 10g　元胡 3g　陈皮 6g　炙甘草 3g　五剂。

四诊：

饮食增加，下午困乏，右腹间响，矢气多。切诊：左关脉敛，中取脉细弱，舌微红，苔白。治再强肝。

处方：当归 15g　川芎 6g　炒杭芍 15g　五味子 6g　枸杞子 10g　九地 10g　山药 15g　白术 10g　茯苓 10g　肉桂 10g　公丁香 3g　砂仁 10g　元胡 3g　陈皮 6g　炙甘草 3g　五剂。

五诊：

饮食睡眠都好，整天不感困乏，右肋下按之也不痛。切诊：左关阴阳脉清楚有力。舌红，苔白。处以十全大补丸三盒。以巩固疗效。继后恢复工作。

**病例三：**

妥＊＊，女，30 岁，家庭妇女。自述：患黄疸病，曾服中药多剂不效。现体困思睡，不想食饮，转来就诊。病者面容黄黑，两目白睛全黄，检看原服方药：有以阳黄为治者；有以阴黄为治者；有以逍遥散加茵陈而治者；方药尽善，其如病何。细问其发病时间，及其前后自身感觉：病前身体很好，从不有病，月前去娘家省亲后抱着孩子骑驴回家，路过一小溪时，坐驴突然向前一猛跳，母子二人几从驴背上翻倒。惊

吓之余，心跳不已。在家休息两天后也就好了。此后每天即觉困乏喜睡，饮食逐渐减少。继又两目发黄，始就医治不见好转。切诊：六脉缓和，细按左尺见虚。恐则伤肾，惊则伤胆，今水虚不能荣木，胆虚无以致泻，胆汁溢，发为黄疸。治当滋肾强肝壮胆，疏利胆汁。

处方：当归 10g　川芎 10g　炒杭芍 6g　九地 15g　山萸肉 10g　熟枣仁 10g　郁李仁 10g　茯苓 10g　山药 15g　茵陈 10g　党参 10g　陈皮 6g　炙甘草 3g　黄酒引，三剂。

次诊：

困乏轻，饮食增，目黄未尽退。切诊：左尺沉取稍有力，舌苔同前。原方又服三剂。愈。

**核肿：**

**病例一：**

王＊＊，男，22 岁，工人。自述：左胸乳下九、十肋间，生出一如鸡蛋大疙瘩，来兰经某医院检查为："肋间结核"，需手术切除。必要时得截去九、十两肋骨。家人不同意。转来治疗，病者面容黄润，体格健壮，疙瘩不热，不红不痛，发硬，摇之不动，与九、十肋骨紧相粘连。切诊：右有防风脉，左有羌活脉，右关中取无力。舌红，苔白。依照脉象，经络不和，脾气内虚，正气不足，气液结於表里之间，积聚成核。治当壮气疏经散结。

处方：炙黄芪 20g　党参 15g　白术 10g　茯苓 10g　当归 6g　白芷 10g　羌活 10g　防风 10g　白蒺藜 10g　炙山甲 6g　陈皮 6g　炙甘草 3g　加姜枣，三剂。

次诊：

按之疙瘩能活动，与肋骨似有脱离状。切诊：脉舌同前，治依原方，再服三剂。

三诊：

早上六时许，病者偕其父来家谓：今晨醒后发现疙瘩突窜至背部。全家惊骇。特早来请诊：诊见：疙瘩转至左背胁间，皮肤微红，表皮层有红疹，疙瘩按之仍硬。在皮之下，骨之上，摇之上下左右可动。亦不痛。似此病由胸转背，乃由阴转阳，向愈之象。切诊：防风脉仍在，舌苔同前。治再疏风活络，透邪外散。

处方：炙黄芪 20g　当归 10g　炒杭芍 10g　防风 10g　羌活 10g　炙甲珠 6g　白蒺藜 10g　白芷 10g　蝉退 10g　紫苏 6g　菊花 6g　生甘草 10g　加姜枣　三剂。

四诊：

背间疙瘩漫红如手掌大，按之中心有拇指大一块仍微硬，周缘发软，皮疹散漫於左半背，不痛发痒。病邪已开散。切诊：羌防二脉依稀尚存。舌苔同前。属原方再服三剂。

五诊：

左背疹块平复，皮肤润泽，轻重按之，无所发现。切诊：羌防二脉不复存在，无再服药必要。

**病例二：**

张＊＊，女，35 岁，工人。自述：两乳房内臂侧生疙瘩各一。多方治疗不效，前来就诊。病者体弱消瘦，面色黄黑，月经或来或不来，食少，困乏。两乳表面不红不肿，深按之疙瘩微硬如蚕豆大。切诊：六脉虚弱无力。舌质青，边缘有齿印。苔青腻。

病体虚弱，乳间郁结，治先壮气血。

处方：十全大补汤。加：鹿角霜 15g　五剂。

次诊：

面色和润，食略增，困乏轻。切诊：六脉稍有起色仍无力。舌苔同前。治依原方再服十剂。

三诊：

面色透红，家务劳累，不觉困乏。切诊：右脉起而有力，左关郁郁不前，有川芎脉象。舌淡红，苔白。乳间块硬仍存。乃肝郁气滞。治当舒肝理气。

处方：当归 15g　川芎 10g　白术 10g　佛手片 10g　陈皮 10g　茯苓 10g　紫苏 6g　白芷 6g　枸杞子 10g　鹿角霜 10g　白蒺藜 10g　炙甘草 3g　加姜枣。五剂。

四诊：

右乳房中疙瘩变小，左乳疙瘩照旧。切诊：左关仍有川芎脉，舌苔同前。治再舒肝理气。

处方：炙黄芪 20g　炙香附 10g　当归 15g　川芎 10g　白术 10g　茯苓 10g　佛手片 10g　陈皮 10g　紫苏 6g　白芷 10g　枸杞子 10g　鹿角霜 15g　白蒺藜 10g　炙甘草 3g　加姜枣。十剂。

五诊：

体气健旺，面色红润，两乳内疙瘩触之转小如豌豆大。月事按期来潮。切诊：左右脉阴阳均匀。舌红，苔淡白。处以十全大补丸三盒。愈。

**病例三：**

崔＊＊，女，20 岁，农人。自述：左大腿外侧生出一疙瘩，经某医院检查为“骨结核”。曾注射青连霉素若干支少效。后又找外科、中医治疗也少效。转诊见：病者走路摇摆跛足，

正立时左足跟提起约二市寸许，左腿现短缩。检视疙瘩，正当风市穴处，皮肤微青，中心高起，按之硬，摇之不动，与股骨相粘连。据谓：行动时整个左腿掣痛，静坐时只觉胀痛困重。月经不正常，色淡量少，切诊：两尺细弱，两关虚无力，左有羌活脉，右有防风脉。舌淡红，苔青薄。证属下元虚寒，经络为风邪阻滞，邪气结於风市穴间。“邪之所凑，其气必虚”。结核胶着於骨，肾气不足可知。治当壮肾气，疏经络。

处方：九地 10g　山药 15g　山萸肉 10g　肉桂 10g　炙附子 10g　茯苓 10g　防风 10g　羌活 10g　党参 10g　当归 10g　鹿角胶 10g　大枣五个。五剂。

次诊：

疙瘩无变化。切诊：两关尺脉微有起色，羌防脉仍在。舌苔同前。治依前法。

处方：炙黄芪 20g　党参 10g　山药 15g　九地 10g　山萸肉 10g　肉桂 10g　炙附子 10g　防风 10g　羌活 10g　当归 10g　鹿角胶 10g　骨碎补 10g　茯苓 10g　大枣五个　十剂。

三诊：

疙瘩变大，皮色由青变紫，痛疼照常。切诊：两关尺脉起，重按则无力。舌红，苔白。治依前法。原方加白术 10g　炒杭芍 10g　再服十剂。

四诊：

疙瘩更大，中心红热高起，边缘皮色紫，摇之仍不动。切诊：左右关尺有力，羌防二脉未除。原方加炙山甲 10g　皂刺 10g　白芷 6g　白蔹藜 10g　冀其外溃，俾毒邪外泄。五剂。

五诊：

自述疙瘩溃破时起先流脓血，一天后只流清黄水。检视患处：中心平塌下陷，脓孔四周色青，外周高起处皮色紫。切诊：脉象舌苔同前。痈疽溃后，当以大补气血，托里排毒为宜。

处方：炙黄芪 20g　党参 10g　白术 10g　茯苓 10g　当归 10g　川芎 10g　九地 15g　炒杭芍 10g　山药 15g　山萸肉 10g　肉桂 10g　炙附子 10g　骨碎补 10g　羌活 10g　防风 10g　白芷 10g　鹿角胶 10g　禹三花 10g　炙甘草 3g　大枣五个。十五剂。

六诊：

脓口仍流清黄水，孔周青紫范围缩小。切诊：脉象舌苔同前。原方再服十剂。

七诊：

脓孔收缩如红豆大，时流清水，周缘皮色转正红。处以十全大补汤五剂。冀其收口自愈。

八诊：

据谓：药后疮口仍不愈合，后有人给以“五枝膏”方，配制成药膏，经敷用约一星期，其疮口便愈合。

兹录五枝膏方及其制用方法如下：

槐枝　柳枝　榆枝　桑枝　桃枝各半尺，乳香 15g　没药 15g　猪胆一个　芝麻油 250g

制法：将五枝各截成一寸小截，用芝麻油炸焦，研细再和乳香、没药后放油锅中滚三五分钟。再放猪胆汁搅匀，作至滴地成珠即成。

用法：用花椒水和麻油及醋少许，搅和后，先洗疮口，然后

敷上药膏，每日一至二次，疗期一至二月，疮口出骨即愈。

附言：

按此方专治骨结核（疽）溃破流脓水者。崔姓女只敷用约一星期疮口即愈合，虽未出骨，但数月后曾在背项间和臀部出生脓包二次，经服药即解，恐系余毒作怪。痊愈后走路逐渐转为正常，不再有跛状。

**尿道病：**

**病例一：**

秦＊＊，男，14岁，学生。小便不通已二日。前往诊视：病孩啼哭，小腹胀硬，阴茎肿大，右眼角发红。切诊：右有防风脉，左关沉弦，寸有荆芥脉。舌红，苔腻。证属风寒外束，湿热内结於厥阴经。

治当两解。

处方：当归10g　赤芍10g　龙胆草6g　焦山栀10g　车前子10g（布包煎）　甘草梢10g　防风10g　荆芥10g　柴胡6g　木通6g　黄柏6g　海金砂10g（布包煎）　紫苏6g　一剂。

次诊：

服头煎药后约半小时许，病孩急唤尿器，及至其母送去，已尿撒满床，被褥均湿。恐后再犯，特请复诊。检视：阴茎肿消，小腹软，眼角红退。切诊：左右脉均缓和。处以归芍六君子汤二剂，调和肝脾以善其后。

**病例二：**

焦＊＊，男，55岁，工人。自谓：每意欲小便时，但临厕不出，过后点滴遗漏，裤服皆湿。甚为苦闷。诊视：患者

满面通红，行动便捷。切诊；右有防风脉，关虚尺紧，左脉平和。舌根青，苔灰。证属气虚受风，丹田有寒，膀胱排泄无力所致。治当壮气疏风，温暖丹田，助膀胱气化。

处方：党参 10g　白术 10g　茯苓 10g　防风 10g　乌药 6g　炙小香 10g　荜澄茄 10g　菟丝子 10g　干姜 10g　紫苏 6g　炙甘草 3g　大枣三个。二剂。

次诊：

小便畅，体困。切诊：右脉虚。舌红，苔白。服补中益气汤三剂。愈。

**血病：**

**病例一：**

马＊＊，女，43 岁，家庭妇女。据谓：三天前因感冒发烧，继则血崩，急赴医院，针药过后，血流仍不止。特请余诊：病者卧床啼哭，家人慌乱。切诊：右有防风脉，左有荆芥，续断脉。左关中取血流急促。舌淡红，苔白。证属风寒外束，邪热内迫，逼血妄行。治当解表清热止血。

处方：党参 10g　白术 10g　茯苓 10g　当归 10g　炒杭芍 10g　九地 10g　续断 10g　防风 10g　荆芥 6g　血馀炭 10g　仙鹤草 10g　甘草 3g　加姜枣。二剂。

次诊：

血崩止。肢体仍痛。切诊：右有防风脉，左关平静而虚。舌苔同前。治再补气血，疏外风。

处方：炙黄芪 10g　党参 10g　白术 10g　茯苓 10g　当归 10g　川芎 6g　炒杭芍 10g　九地 10g　防风 10g　干姜 10g　甘草 3g　大枣三个　三剂。愈。

**病例二：**

杜＊＊，男，28岁，工人。经常鼻干无涕，后来流鼻血，左塞右流，右塞左流，双塞则血从口出。医院塞治，血才不流。因此，双鼻经常紧塞棉纱，日夜不敢取离，每用口呼吸。历时已半年余。某医院建议手术缝闭鼻腔血管，可达根治目的。病者不同意，转来就诊：病者系一转业军人，体格健壮，双颊赤红。切诊：右有防风脉，右寸平塌不起，左关寸高大。左关中取血流涌涌。舌红苔白。食欲睡眠都好。多血体质，外受风寒，邪热内迫，血气妄行，上溢为鼻血。右寸平塌不起，气分有所亏损。阴阳不平，是衄病内在根源。治先疏风宁血止血。

处方：当归10g　炒杭芍15g　麦冬10g　五味子3g　防风10g　荆芥6g　血馀炭10g　北少参10g　紫苏3g　二剂。

次诊：

据谓：头目较前轻快，双鼻所塞棉纱仍未敢取去。切诊：防风脉犹在，右寸脉仍不起，左关寸稍敛，中取血流稍静。舌苔同前。治再壮气、疏风、宁血、止血。

处方：党参10g　白术10g　茯苓10g　半夏6g　防风10g　荆芥6g　当归10g　炒杭芍10g　麦冬10g　五味子3g　血馀炭10g　紫苏3g　陈皮3g　加姜枣　三剂。

三诊：

病者面色转白，双颊微红，两鼻孔棉纱照塞，鼻孔隆起。切诊：右关寸脉稍大，左关收敛为肝血热平。舌苔同前。嘱将鼻塞取去。

处方：党参10g　白术10g　茯苓10g　陈皮6g　半夏6g　麦冬10g　五味子3g　当归10g　炒杭芍10g　紫苏

3g　干姜 10g　白芷 6g　远志 6g　炙甘草 3g　加姜枣　三剂。

四诊：

据谓：血未再流，久干之鼻有清涕流出。切诊：左右关寸均平和。舌苔同前。处以六味地黄丸两盒，以善其后。半年后其妻来看病言未再复发。

**病例三：**

王＊＊，男，30 岁，自谓：鼻血数年，久治不愈。特来请诊：病者身体一般，面色黄。切诊：左有桂枝脉，右关寸虚软无力。舌红无苔。口干不喜饮。证属血分受寒，气分热必起，日久耗阴，太阳表寒又不解，两热相煎，血遂外溢。法当滋阴以配阳，解表以止血。

处方：北沙参 10g　桂枝 10g　麦冬 10g　贝母 10g　炙百合 10g　五味子 6g　紫苏 6g　干姜 10g　茯苓 10g　仙鹤草 10g　血馀炭 10g　阿胶 10g　陈皮 6g　菊花 6g　二剂。愈。未再犯。

附言：

按此症与《伤寒论》太阳膀胱蓄血证对照，同属桂枝证，一在上血外流，一在下血内积。一用滋阴解表止血法；一用解表逐瘀法。看来血分受寒，不流则积，是必然趋势。

**病例四：**

金＊＊，女，42 岁，工人。自述：大便后有鲜血流出，经某医院检查并非内痔。用止便血药如槐角丸等都不见效。现已二年余。体困乏力，身体日渐不支，请诊治：病者面容黄瘦，口唇淡白，切诊：六脉虚缓，左关抑郁有川芎脉象。舌淡，苔青。证现气血双亏。虚寒便血。治当壮气升血以止血。

处方：炙黄芪 15g　党参 10g　白术 10g　当归 10g　川芎 10g　阿胶 10g　山药 10g　鹿角胶 10g　煅牡蛎 15g　九地 10g　炙甘草 3g　三剂。

次诊：

据谓：困乏轻，便后血少。切诊：六脉稍有力，舌苔同前。嘱原方再服三剂。

三诊：

便血止，困乏轻，面色转润。切诊：六脉和缓稍有力，舌红苔白，处以十全大补汤加鹿角胶 10g　五剂。以善其后。

**病例五：**

何＊＊，男，40 岁，干部。自述：因患感冒曾煎服葱姜汤一杯，次晨起床时觉嗓子干痒，咳嗽时唾出鲜血一块，继则心中热闷，时咳带血，不咳不血。前来就诊：病者体躯肥胖，走路气喘，面红如枣，说话声音微哑。切诊：左关寸高大有力，右关较小，右寸浮大软。舌红，苔白。口干。左脉高大，血盛有余，右脉关小寸浮，气虚阳热过盛。血热互结於肺，灼伤血络，壅溢咳血。治仿桑丹泻白散。

处方：生石膏 30g　丹皮 10g　五味子 6g　赤芍 10g　生地炭 20g　仙鹤草 15g　海蛤壳 15g　生黄芪 10g　童便一小杯兑服，二剂。

次诊：

不咳，血止，仍口干。切诊：左脉微大，右脉较小。舌苔同前。治再凉血养血。

处方：北沙参 10g　麦冬 10g　五味子 6g　丹皮 10g　赤芍 10g　生地 15g　童便一小杯兑服，三剂。愈。

**病例六：**

林＊＊，男，62岁，工人。自谓：小便尿血，有时血块如拇指大，色如鸡肝，随尿而下，有时尿中缕缕如粗线，色鲜红，无论血块血线，尿时尿道鼓胀，尿道困痛难受，浑身发冷，不想食饮，头昏闷，体困。切诊：右脉虚缓有防风脉，尺有茴香脉，左有羌活、续断脉。舌质根青，苔青。证为气分虚寒，复受风寒外袭，气海亏损，邪热集於下元。血分为邪热所迫，随热下行，出尿道，与气分之寒相凝，互结成块。治当壮气散寒，温下元，固肝肾。

处方：党参10g　白术10g　茯苓10g　羌活10g　防风10g　炙小香10g　干姜10g　革澄茄10g　菟丝子10g　续断10g　当归10g　扁蓄10g　炙甘草3g　加姜枣。二剂。

次诊：

恶寒体困去，小便无血，尿时尿道酸困。切诊：右脉虚，左脉和缓。舌润滑，苔青。治再壮气温下元。

处方：党参10g　白术10g　茯苓10g　炙小香10g　良姜10g　菟丝子10g　砂仁10g　苏梗6g　炙甘草3g　加姜枣　三剂。愈。

**疮疡：**

**病例一：**

张＊＊，男，25岁，自谓：额部经常生疮疖，一病多日，肿连面目。曾用青霉素、仙方活命饮、防风通圣散等药剂治疗，虽能见好。但愈而复发，不能根除，已一年余。额部经常瘢痕累累，损伤面容，甚为苦恼。近又左额角新生出数枚，红肿烧痛。特请设法根除。诊见：病者气色正常，口中和，饮食好，切诊：左有桂枝脉，右脉和缓。外科疮疡，本属蕴毒

热结；今脉出桂枝，遂化裁。

处方：桂枝 10g　当归 6g　炒杭芍 10g　白芷 10g　银花 10g　蒲公英 10g　贝母 10g　茯苓 10g　陈皮 6g　生甘草 6g　五剂。

次诊：

原肿大者溃破，小者全部消散。切诊：桂枝脉不复再见，无再服药必要。后此年余，未再复发。

**病例二：**

马＊＊，男，46 岁，左耳轮内外连同颈项部，表皮脱落，内皮外现，红赤目渗出点滴清黄水。多因颈项部转动皮肤掣裂流血，两手十指亦然。不能劳动已年余。来兰就诊：切诊：左有羌活脉，右有防风脉。舌红苔白。依脉证系风湿热为病。治当驱风散热收湿。

处方：羌活 10g　防风 10g　荆芥 6g　白蒺藜 10g　蝉退 10g　菊花 10g　白鲜皮 10g　当归 6g　赤芍 10g　煅牡蛎 15g　生甘草 3g　五剂。

次诊：

流水少，红赤处仍有干裂状。切诊：羌防脉依稀尚存。舌苔同前。嘱原方再服五剂。愈。

**病例三：**

王＊＊，女，20 岁，工人。颜面两手指及掌背，表皮脱落，内皮外现，渗出清黄水，见风尤甚。不能上班。曾住医院治疗二次，为时四月，亦未痊愈。转来就诊：切诊：左有羌活脉，右有防风脉。右寸浮大。舌红苔白。口干。风湿热为病。治当驱风，清热，收湿。

处方：生石膏 30g　羌活 10g　防风 10g　荆芥 10g　白蒺藜

10g　禹二花 10g　菊花 10g　当归 10g　赤芍 10g　白藓皮 10g　煅牡蛎 20g　苦参 10g　生甘草 3g　五剂。

次诊：

手面水全止，皮色大部转白，仍干裂。切诊：羌防脉时或一现。舌红苔白。依原方加炙黄芪 20g　当归加 5g　去石膏　四剂。共研细末。每服 10g　早晚开水冲服。月余痊愈。

**病例四：**

王小孩，男，岁半。家人谓：口疮，啼哭不能食饮，已半月余医治未效。请诊：病孩面黄浮，舌淡边红，有白点，凹陷溃烂。苔青腻。切诊：左寸稍大，右有防风脉。证属外风内食，邪热结於口舌。治当疏风散热消食和胃。

处方：荆芥 6g　防风 10g　砂仁 10g　干姜 6g　焦山楂 10g　藿香 6g　陈皮 6g　半夏 6g　茯苓 10g　桔梗 10g　薄荷 6g　甘草 6g　二剂，共服四天。

次诊：

啼止、能吃饮。舌边尖疮痕未痊愈，苔厚腻。切诊；脉缓和。

处方：五消汤。加：砂仁 6g　桔梗 10g　薄荷 6g　粉甘草 6g　二剂。愈。

**气虚：**

**病例一：**

杨＊＊，男，42 岁，工人。据其妻谓：病者原因不明，突然不语，食饮给则食，不给不取。常卧不起，对外界一切事物，感觉漠然，有时自行外出，一二日不归。家人四处找寻，发现有时在田间地坑；有时在杂草垃圾堆中睡卧。挽之回家，

也不反抗，已三月余。经数家医院诊查既非精神病，又无其他病理反应，嘱其在家休养。转来就诊见：病者黑瘦，面无表情，两眼闪闪，左顾右盼。诊取其手也不反对。切诊：左脉缓和无力，右关寸平塌下陷。舌质淡红，边缘有齿印，苔白薄。依脉对证，当属气虚。治用补气通窍法。

处方：西洋参 15g　炙黄芪 20g　白术 10g　陈皮 6g　半夏 6g　茯苓 10g　砂仁 10g　石菖蒲 10g　远志 6g　当归 10g　炒杭芍 6g　甘松 2g　炙甘草 3g　加姜枣　三剂。

次诊：

其妻伴前来，就坐后，问其服药后有啥感觉？病者微笑说："没啥感觉"。其妻笑谓：吃饮还少。切诊：左脉有力，右关寸浮起，中沉尚无力。舌苔同前。治再补气理脾。

处方：炙黄芪 15g　党参 10g　白术 10g　山药 15g　煨肉蔻 10g　砂仁 10g　茯苓 10g　半夏 6g　陈皮 6g　炒谷芽 10g　炙甘草 3g　加姜枣　三剂。愈。

**病例二：**

张＊＊，女，27 岁，工人。自谓：子宫脱垂三月余。曾经针灸，服用中药补中益气汤加猬皮等未见效应。转来治疗：病者身体健康，面色红润，切诊；左脉和缓，右尺有乌药茴香脉，舌红苔淡，子宫脱垂原系气虚，久服补气升提药不效，下元气分为寒所滞之故，当先去寒滞，通气道。

处方：党参 10g　白术 10g　茯苓 10g　陈皮 6g　乌药 6g　炙小香 10g　菟丝子 10g　苏梗 6g　砂仁 10g　炙甘草 3g　加姜枣。三剂。

次诊：

右尺脉柔和少力，左尺出现续断脉。舌苔同前。

处方：炙黄芪 30g　党参 10g　白术 10g　茯苓 10g　当归 10g 炒杭芍 10g　菟丝子 10g　续断 10g　炙小香 10g　紫苏 6g　升麻 6g　柴胡 3g　炙甘草 3g　加姜枣　三剂。愈。

**病例三：**

柴＊＊，男，48 岁，工人。自述：日前患头身痛、咳嗽、胸痛。经服某医中药（麻杏石甘汤加：瓜蒌、黄芩等）二剂后，咳嗽胸痛见好。现头隐痛，背项强硬，不能转侧，卧床后，需要别人抬扶方能起坐。请余诊治。病者体格高大健壮，切诊：左有羌活脉，右关寸虚陷不起。舌青无苔。外感未解。气虚阳伤，治用补气壮胃阳兼以疏经。

处方：党参 10g　白术 10g　茯苓 10g　干姜 10g　砂仁 10g　陈皮 6g　半夏 6g　羌活 10g　藿香 6g　苏梗 6g　远志 6g　炙甘草 3g　加姜枣　三剂。

次诊：

项背能转侧，头昏痛。切诊：羌活脉去，右关寸起而无力。治再补气。处以补中益气汤　三剂。愈。

**病例四：**

刘＊＊，男，50 岁，农人。自述：病后双耳聋。已两年余，家乡治未愈，现来兰就诊：经医院检查：耳内构造完好。继转找余治疗。病者面色黑红，身体健壮。右关寸虚下少力，左关浮大。舌红，苔白薄。食饮睡眠都好。有时头中发响。依证脉辨病，属气虚耳聋。头响为肝邪，气虚肝亢，风害孔窍。治当壮气、平肝、开窍。

处方：炙黄芪 20g　党参 10g　白术 10g　茯苓 10g　陈皮 6g

半夏 6g　当归 10g　炒杭芍 15g　生牡蛎 15g　牛膝 10g　漏芦 10g　远志 6g　菊花 6g　炙甘草 3g　加姜枣。三剂。

次诊：

略大声音能听见。切诊：左右脉同前。舌苔同前。治依原法，原方加　王不留行 10g　三剂。愈。

**胀满：**

**病例一：**

管＊＊，男，30 岁，工人。自述：胸中胀满痛，食少，已二月余，经治不效。请诊：病者系一管道工，自谓：因过劳胸痛。切诊：右寸高大，中取滑而有力。舌微青，苔厚腻。证属胃有积滞，痰涎为患，治当消食涤痰。

处方：莱菔子 15g　苏子 10g　白芥子 3g　陈皮 6g　半夏 6g　茯苓 10g　砂仁 10g　焦三仙 30g　苏梗 6g　炙甘草 3g　三剂。

次诊：

胸胀痛减。切诊：右脉仍有滑象。舌红，腻苔尖边退，中燥黄。治再消食涤痰。

处方：大黄 10g　莱菔子 10g　苏子 10g　白芥子 3g　陈皮 6g　半夏 6g　茯苓 10g　焦三仙 30g　干姜 10g　炙甘草 3g　二剂。

三诊：

痛胀除。腻苔退。切诊：左右脉和缓。处以六君子汤以善其后。

**病例二：**

李＊＊，女，40 岁，家庭妇女。患颈淋巴结核和四肢关

节痛病已多年。后因腹胀特来请出诊：病者面容暗黄，左右颈淋巴结已破溃脓血。四肢挪动困难。食饮照常。肚腹膨胀，从两乳头下至小腹间，显出如珠算子大小，连续结节两条，按之软，不痛。据谓：月经不来已二月余，平时经水照常来时，腹不胀，浑身痛疼也轻，今次月经不来，腹又膨胀。大便不通已六日，曾服中药六剂，毫无效果。检视原方，一为大承气汤，一为桃仁承气汤。切诊：右有防风脉，左有羌活脉，右脉大於左脉。口干，舌质红，苔腐。腹胀，便结，经闭，是当前突出问题；但前医已用通经、通便药不效，两乳至下腹两条结节，软而不硬，当属痰核。内不通调、痰涎外结。急则治标。选用逐痰水法。

处方：大黄 10g　甘遂 10g　枳实 6g　芒硝 6g　厚朴 10g
　　陈皮 6g　一剂。嘱其便通后，勿再服用。

次诊：

据谓：晚上服药，天亮时大便一次，干硬如羊屎。腹中稍舒，甚喜。遂将二煎药空腹饮服。起床后，又便出干软便甚多，其中夹杂粘液样物也多，总共有多半瓷盆。腹中特别舒畅。因此又买来一剂，服后只有鼻涕状物便出，仍多。又次日，经血随之行开。请再诊：按腹软，乳下两条串珠样结节消失。切诊：羌防脉仍在。舌质红，苔白腻。后经多方调治，关节病痊愈。至颈淋巴结核病采取内服中药，同时注射青链霉素若干并也痊愈。

**肾脏病：**

**病例一：**

牛＊＊，女，23 岁。自述：患“肾炎”病曾住院治疗愈。二月后复发。前来就治：患者面目四肢浮肿，面色黄，口唇

白，食少体困，浑身不舒，腰痛，尿红有血，时或有血丝血块。切诊：左有桂枝脉，尺有地黄脉，右有防风脉。舌淡红，苔腻灰。症现腰痛，尿血，浮肿。脉出桂枝、防风、地黄脉象。证为邪热结积肾脏，急则治标。先消肿止血。

处方：九地 10g　山萸肉 10g　白茅根 20g　丹皮 6g　阿胶 10g　茯苓 10g　泽泻 10g　车前子 10g（布包煎）　山药 15g　薏米仁 20g　续断 10g　浙贝母 10g　三剂。

次诊：

浮肿消，尿红，血丝块不见。体困，浑身不舒，腰困痛。切诊：桂防二脉仍在，左尺小敛，又有续断脉突出，左关变大。舌淡红，腻苔减。治再疏风祛寒，调理肝肾。

处方：党参 10g　白术 10g　山药 15g　山萸肉 10g　九地 10g　续断 10g　炒杭芍 10g　防风 10g　桂枝 10g　茯苓 10g　丹皮 6g　泽泻 10g　炙甘草 3g　三剂。

三诊：

食饮好，周身轻快，腰仍困，尿清。切诊：左尺脉小且虚，其它病脉不复存在。舌淡红，苔青。治再强肾。处以桂附八味汤。五剂。愈。

**癌：**

**病例一：**

韩＊＊，男，59 岁。据家人谓：其父素有胃病，因吐血住某医院治疗，吐血止。食更少，食后反胃呕吐，日久不愈，体气益衰。遂转住另一医院治疗，经病理科胃镜活检诊为："食道下段贲门处，浸润癌—腺癌"。久治不效。出院。家人治备后事。病者意欲再找中医治疗姑往诊视：病者卧床，面黄目陷，声音低微，自述：食后即吐，饮食不能下，开水泡

饼干，或牛奶，勉强咽下，不久即吐出。腹凹陷如锅底。肋胸骨突出皮下，历历可见。呼吸微弱而平静。切诊：右脉平塌下陷，有防风脉，左脉虚大并有桂枝脉。舌红，无苔，口干。病至气阴两虚，又风寒外束，肝气独亢。治先滋阴，壮气、疏经、散寒、止吐。

处方：北沙参 10g　麦门冬 10g　炙香附 10g　竹茹 6g　陈皮 6g　半夏 6g　茯苓 10g　桂枝 10g　防风 10g　当归 6g　玫瑰花 2g　柴胡 3g　炙甘草 3g　一剂。嘱时时呷饮。

次诊：

家人谓：药后仍吐，但吐食，不吐药。因此原方又煎服一剂。吐少。腹中隆隆作响。切诊：右脉平塌，防风脉尚在，左关脉小敛，桂枝脉消失。舌红无苔，口干。治再壮气，滋阴和肝胃。

处方：北沙参 10g　党参 10g　白术 10g　茯苓 10g　陈皮 6g　半夏 6g　麦冬 10g　炙香附 10g　防风 10g　竹茹 6g　当归 6g　乳香 2g　炙甘草 3g　二剂。

三诊：

自述：时或有吐，能吃饭食，但不多，曾大便一次。量少，干如羊屎。切诊：右脉微起虚而无力，防风脉犹在，左脉敛小无力。舌红润，无苔。治再理脾胃。

处方：党参 10g　白术 10g　山药 15g　茯苓 10g　陈皮 6g　半夏 6g　砂仁 6g　竹茹 3g　防风 10g　当归 10g　乳香 2g　苏梗 6g　炙甘草 3g　四剂。

四诊：

不吐，饭食稍增，能坐起。切诊：左右脉虚缓无力，舌

红润，无苔。治再健脾胃。

处方：参苓白术散。每服一小包，日三服，共服二月。后其子来看病谓其父身体转好，能作家务零活。

**心脏病：**

**病例一：**

康＊＊，男，40岁，干部。自述：头昏体困，心慌气短，食少，看书易疲倦，思睡。曾服柏子养心丸，归脾丸等，效果不显。请诊治：病者体气尚健，面色微黄，切诊：右脉缓，左脉沉取虚而无力，三五至中，出现代脉一次。舌淡红，苔白薄。饮食知味，口不渴，睡眠二便正常。脉现缓中一止，左虚少力。血液有所亏损，心气不足，代脉由生。治当补血强心。

处方：党参10g　白术10g　茯苓10g　柏子仁10g　当归10g　川芎6g　九地10g　枸杞子10g　龙眼肉20g　肉桂20g　远志10g　炙甘草10g　加姜枣　三剂。

次诊：

困乏轻，有时心跳，切诊：右脉和缓，左脉稍有力。原方加：炙附子6g　麦冬10g　五剂。

三诊：

浑身轻快，精神好转。切诊：六脉和缓有力，代脉不复再见。十全大补丸二盒，以巩固疗效。

**病例二：**

甘＊＊，女，52岁，家庭妇女。自述：三个月前患感冒病后，身体经常困倦，稍有劳作，即心跳气短，有时自觉心胸间通通跳甚，头晕难受，伏枕片刻即解。经某医院诊为“心脏病”。嘱休息治疗。现又三月，仍未见好。特请诊：病

者面色微红，体胖，食饮二便正常，切诊：右脉沉分空虚，左三部有力，微数中屡屡出现结脉。舌红，苔白。证属脾虚，气血不相平衡。治先扶脾壮气。

处方：炙黄芪 10g　党参 10g　白术 15g　山药 20g　煨肉蔻 6g　柏子仁 10g　茯苓 10g　玉竹 10g　麦冬 10g　远志 6g　五味子 2g　苏梗 2g　炙甘草 10g　加姜枣　三剂。

次诊：

困乏轻，心跳难受仍有。切诊：右沉分脉微起，左脉稍缓。结脉仍在。舌苔同前，治依原方再服五剂。

三诊：

浑身不乏，头目清楚，有时心跳难受，切诊：右沉分脉起，左脉微缓，结脉时出时隐。治再壮气调血。原方加：丹参 6g　当归 12g　炒杭芍 10g　五剂。

四诊：

药后一星期，心跳又发作二次，切诊：左右阴阳脉缓和，久切结脉未再出现。处以补中益气汤加丹参 10g　五剂。后未再来。

**病例三：**

畅＊＊，男，40 岁，教员。自述：近月来心跳气短，头昏体困。经某医院诊断为“心脏病”。嘱服药休息治疗。已一月余，似不见好。转中医治疗：病者体气尚可，面色微黄，饮食睡眠都好。切诊：左脉时时出现结脉，沉中紧细，右关鼓缓，舌质苔均微青。证属脾胃寒湿郁积，肝寒血虚。治当暖肝脾，强心逐寒湿。

处方：党参 10g　白术 10g　茯苓 10g　陈皮 6g　半夏 6g

干姜 10g　炙附子 10g　肉桂 10g　当归 10g　炙甘草 3g　三剂。开水煎。

次诊：

自述：心跳头昏症照旧，腹中响。切诊：结脉依旧，右关软而无力，左关紧细。舌淡红，苔白薄。寒湿退。治再补肝强心。

处方：党参 10g　白术 10g　茯苓 10g　柏子仁 10g　当归 10g　枸杞子 10g　肉桂 10g　炙甘草 10g　加姜枣　五剂。

三诊：

自述：头昏，体困减，心跳有时出现。切诊：左右脉虚软少力，结脉时隐时现，治再壮气，补肝心。

处方：党参 10g　白术 10g　茯苓 10g　柏子仁 10g　当归 10g　肉桂 10g　公丁香 2g　枸杞子 10g　九地 10g　炙甘草 10g　加姜枣　五剂。

四诊：

自述：头目清爽，体不困乏，心跳症未再出现。切诊：六脉和缓有力，结脉不复再见。舌红，苔白。治再壮肾滋肝，以巩固疗效。处以

桂附八味丸。三盒。愈。

**病例四：**

赵小孩，男，6 岁。家人谓：两月前曾患感冒发烧，去医院就诊经查病系“心肌炎”。住院治疗。两月余未见好转，遂出院找中医治疗。诊见：病孩体气虚弱，食少，面黄，问其所苦，只说：浑身困的很。切诊：右有防风脉，左寸微大，沉取各脉虚软无力时时出现结脉。舌淡红，苔白薄。证属素体

内虚。外感风寒。治先壮气疏风。

处方：党参 10g　白术 10g　茯苓 10g　陈皮 6g　半夏 6g　防风 10g　荆芥 6g　藿香 3g　干姜 10g　砂仁 10g　炙甘草 3g　加姜枣　三剂。

次诊：

家人谓：饮食增多，爱戏笑玩耍。切诊：荆防脉消失，两手各脉和缓有力，惟五六十至中出现结脉一次。治再补气血强心。

处方：党参 10g　白术 10g　茯苓 10g　山药 15g　柏子仁 10g　龙眼肉 15g　当归 15g　黄精 10g　砂仁 10g　炙甘草 10g　加：姜枣。十剂。

三诊：

病孩面色转红润。切诊：六脉缓和，一百三十余至中仍出现结脉一次。舌苔同前。嘱原方再服十剂。

四诊：

病孩体气健好。舌苔同前。切诊：六脉和缓，二百余至后结脉不复再见，转而出现代脉一次。似此代脉，老年人多有，小孩出现，内虚可知。遂问其家人，此孩生来曾患何种重大疾病？家人谓：三岁左右时曾泻肚多日未愈。后住院治疗始好。其它时日，有时有点感冒，别无它疾。娇嫩之体，久泻伤阴，遂处以桂附八味丸二盒。每服半丸。日二服。

五诊：

病孩一切良好，切诊：六脉和缓有力，脉三四百至后，也不复再见代脉。愈。

附言：

按：心脏病成因很多，有先天不足肝肾血虚；有后天营

养失调，脾胃之气不足；或因经络不舒，内脏功能受滞，致心脏负荷太重；或误服药物致心功能受损等。所有因功能受损而致之心律不齐，都要依据脉象找出原因。或补气补血，增强心脏功能；或调理脏腑，疏通经络，以减轻心脏压力；都能使心功能趋于正常。唯独如心室肥大，冠脉病变等器质性心脏病，已属冰冻三尺，非一日之寒之症。药物有灵，回天无力，只能求助于手术等疗法而已。

## 医案录后语

辨证施治，是中医传统诊疗方法；辨证中包括望、闻、问、切四诊在内。但目前有些文献病例医案记载中，对望、闻、问三诊记载较详，对脉象记载多有忽略之处，如：只写脉浮，脉弦，脉大等。究竟浮弦大指何部脉象而言，也未标明左右部位上中下等，徒有其名，而无其实，失尽中医切脉诊病重要环节。历代医家，重视脉诊，但后来人们对切脉却产生种种看法：有人认为望而知之为之神，问而知之为之圣，切而知之为之工。究竟神与圣可信度有多大，谁也说不清楚。又有人认为切为四诊之末，没有前三诊重要，所以放在最后。这又是一种曲解。岂知前三诊是患者与医者双方接触后的表面印象而已，也就是由浅入深的开端。"切"是最后一道工序，是综合前三诊表面印象再向纵深发展与患者内在情况相结合后，论断疾病之所由生。最后作出相应对策。怎么能说不重要呢？又有人认为"切"是一种玄学，故有："心中了了，指下难明"的议论。这又是技术与功力问题，做为医者不能以自己无知，而妄加论说。凡此种种，长时以来，误将中医切脉，贬得可有可无。一个医者仅凭望听，凭他人述说，信以

为真，而不亲手诊察，作进一步综合、分析、核实，难免偏听轻信。小则妄药误病，大则有草菅人命之嫌。

本篇医案摘录中所选各节，除具述望，闻，问三诊外，更侧重于切脉一项，用为辨究病人体质、脏腑、经络、气血、疾病根源。然后论证治疗方法。务使证脉相合，证药相对，脉药相应，组药成方，方剂既适合於生理需要，又和病理转变规律相适应，环环相扣，顺理成章。依此诊疗疾病，法简而效速，形成一整套规律，便於同道使用，原识者明察焉。

## 治　略

一、诊脉必先察肝肾，根基固虽困无碍。

二、治病必先顾胃气，正气盛，邪气则易服。

三、后天之本为脾胃，先天之本系肝肾，肝肾生血，脾胃生气，二者一有损伤，则百病丛生。治疗时，顾先天，保后天，立足点稳定，然后方可以伸张打伐矣。

四、病有功能不调与器质病变之分，属功能者，各随其性以调之；属器质病变者，於调理功能中间附以调理精血。缘器质病多因功能久久受损而引起。功能病易调而易愈，器质病须旷日费时。

五、病有新久，治有先后，新者易愈，久者费时，先新而后旧也。

六、治病与治命须权衡斟酌。治病不顾命，病去而人亡。因此，治命为主，治病其次也。

七、接诊一病究应如何处理，前贤遗训此其一，个人认识与经验此其二。而最重要者，莫如病人本身脉象之显示。表里虚实，脏腑偏盛等，随其脉，合其证，扶其虚，抑其偏，顺

应自然疗能之规律，不难一一解决。

八、病之发生及其转变，都有一定不移之规律，如：《伤寒论》、《温热经纬》等书，虽总结的是外感病之起因与转变，及其治疗之规律，而其它疾病也不能超出此规律。所不同者病之性质有别。如不遵循此规律，头痛医头，脚痛医脚，治不求因，有失中医本色。

九、病有发生於气分者；有血分者；有液分者；三者必须分清。有治气以理血者；有治血以调气者；有调液后而气血平衡者；知本知末，始尽全功。

十、（《内经·素问·至真要大论》）曰："逆者正治，从者反治，从多从少，观其事也。热因寒用，寒因热用，塞因塞用，通因通用，必伏其所主，而先其所因。其始则同，其终则异，可使破积，可使溃坚，可使气和，可使必已……诸寒之而热者取之阴，热之而寒者取之阳，所谓求其属也。"用凉药退热，热药去寒，此其常。用热药退烧，补药除塞，此其变。脉理不明，何以达变知常，伏主求因，更何以破积溃坚，气和必已呢？

十一、古语云："工欲善其事，必先利其器"。医不明究脉理，何以知脏腑之虚实，表里经络之通调，气血阴阳之相乘等等。更何以探病理究病源，确定治疗法则呢。不究药之性能及其作用脏腑经络，配伍禁忌等，又何以明其用。

十二、俗话说："熟读王叔和，不如临证多"。这强调了临床经验的重要性。如果缺乏理论作指导，实践难免流於盲动。不经实践的理论，书本知识，放之实用也难免不无恍惚之感。惟有二者很好的结合，才能有真知灼见。

# 编后语

中医学术是一门古老、深奥、而实用价值极高、极广泛的一门学科。人类物质文明发展到核子时代的今天，她并不因时代进步而逊色。相反，它的作用和价值随着人类认识水平提高而不断在增进。在人体这个奥妙的小世界中，虽说已知数不少，但未知数也还不少。几千年来中医在探索人体生理病理药物性能等自然规律。从顺应自然疗能，运用树皮草根、金石骨角等自然药物，以偏济偏，补益人体，治疗疾病。在实践中形成一整套理论与实践相结合的理法方药。为广大人民的医疗保健作出了巨大贡献。也必将对全人类有所贡献。

这本书写成于1982年间，当时兰州市中医某权威人士认为：桂枝脉说，聊备一格，查古代经典和现代文献中尚少见论述，不足取也。遂遭搁置。岁月蹉跎，倏已十有余年，闲来经检原作，仍觉有供献于社会之必要。人类文化是在继承、发展、创造、发明中随着时代推移而进步的。中医学术，自不例外。“桂枝脉说”仅仅是中医诊疗方法之一，如果古今文献上已有，今天提出，那就毫无价值。事实上，少见的事物，才具有新的意义，推陈出新是一切事物发展的必然规律。至于新的东西，可取与否。自然科学的价值，贵在实用。中医学术应以临床效用为依归。而医者首先要有科学态度来对待外界客观事物。主观臆断，为识者所不取，面对别人研究成果，或临床实践所得，不经验证。妄自评说，甚或武断。这种表现，辩证地反映出本身的非科学态度。

桂枝脉证三十余种药脉，是个人四十余年临床实践中所

得。曾经无数次反复验证无误后确定下来的。从而总结出脉、证、药、方四者互相印证法。继而发现依脉、证、药治疗原发病中又能使续发病随之而愈的诸多例证来。这在中医方脉学上又是一个新的发现。

整体观是中医学的精华之一。阴阳五行，气血营卫，五脏六腑，十四经脉。在病理上互相转化规律映证下，现将古今理法方药，演伸分析，希冀在诊疗上行成一定方法、步骤、达到具体化、规范化。供学者掌握使用，扩大疗效，泽被苍生。

中医学术，博大精深。尚有更多宝藏有待人们去发掘。寥寥数篇，不足为贵。望医界同仁，重复再重复，实践再实践。惟作者学疏识浅，谬误之处，在所难免。尚希识者能在实践中提出宝贵意见，批评指正。以图抛砖引玉，使古老珍贵的中医学术更加完善、充实，焕发出新春，共创辉煌。为人类健康事业作出贡献。幸甚。

1998 年 6 月

0155393

[General Information]
书名=中医方脉精微
作者=彭应天
页数=１４２
ＳＳ号=１０３８７９０２
出版日期=１９９９年０４月第1版